

Buku Referensi

KEBIDANAN KOMUNITAS

Dalam Penurunan AKI dan AKB di Indonesia

Nurrahma Layuk • Azizatul Hamidiyah • Dewi Junita Lamtumiar
Ana Mufidaturrosida • Putu Lusita Nati Indriani
Imroatus Sholihah • Siti Yuriah



BUKU REFERENSI: KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM PENURUNAN AKI DAN AKB DI INDONESIA

Penulis:

Nurrahma Layuk., S.Tr.Keb., M.Keb

Dr. Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes.

Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb. M.Kes

Ana Mufidaturrosida, S.ST., MPH.

Putu Lusita Nati Indriani, SST., Bdn., M.Kes.

Imroatus Sholihah, S.Keb., Bd., M.Keb

Bd. Siti Yuriah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Buku Referensi: Kebidanan Komunitas dalam Penurunan AKI dan AKB di Indonesia

Penulis:

Nurrahma Layuk., S.Tr.Keb., M.Keb
Dr. Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes.
Dewi Junita Lamtumiari, SKM, S.Keb. M.Kes
Ana Mufidaturrosida, S.ST., MPH.
Putu Lusita Nati Indriani, SST., Bdn., M.Kes.
Imroatus Sholihah, S.Keb., Bd., M.Keb
Bd. Siti Yuriah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-18-3

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul “Kebidanan Komunitas dalam Penurunan AKI dan AKB di Indonesia” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan, khususnya kebidanan komunitas yang memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Permasalahan kesehatan ibu dan bayi tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai determinan sosial, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, budaya, lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kebidanan komunitas menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Buku ini membahas berbagai pokok bahasan penting, meliputi determinan sosial kesehatan ibu dan bayi, asuhan kebidanan berbasis komunitas, pencegahan komplikasi pada kehamilan risiko tinggi, serta peran bidan dalam sistem rujukan maternal neonatal. Selain itu, buku ini juga menguraikan pentingnya pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan berbasis kebidanan komunitas sebagai bagian dari upaya menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Pembahasan mengenai model intervensi kebidanan komunitas berbasis lokal juga dihadirkan agar pembaca memahami pentingnya pelayanan kebidanan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penyusunan buku referensi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui buku ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kebidanan komunitas dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi, terutama melalui upaya promotif, preventif, deteksi dini, rujukan tepat waktu, dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan keilmuan, serta menjadi referensi yang berguna dalam penguatan pelayanan kebidanan komunitas sebagai bagian dari upaya bersama menurunkan AKI dan AKB di Indonesia.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 EPIDEMIOLOGI AKI DAN AKB DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Epidemiologi Kesehatan Ibu dan Anak.....	1
C. Konsep Angka Kematian Ibu (AKI).....	4
D. Konsep Angka Kematian Bayi (AKB)	6
E. Determinan AKI dan AKB di Indonesia	9
F. Distribusi AKI dan AKB di Indonesia	11
G. Program Pemerintah dalam Penurunan AKI dan AKB.....	14
H. Penutup	16
Referensi.....	18
Glosarium.....	22
 BAB 2 DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN IBU DAN BAYI.....	 26
A. Pendahuluan.....	26
B. Konsep Determinan Sosial Kesehatan.....	27
C. Status Sosial Ekonomi Dan Kesehatan Ibu Bayi.....	28
D. Pendidikan dan Literasi Kesehatan Ibu	30
E. Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	31
F. Lingkungan dan Budaya.....	32
G. Ketimpangan Sosial dan Kematian Ibu Bayi	33
H. Ketimpangan Sosial dan Kematian Ibu Bayi	34
I. Penutup	35
Referensi.....	36
 BAB 3 ASUHAN KEBIDANAN BERBASIS KOMUNITAS	 37
A. Pendahuluan.....	37
B. Kebidanan Komunitas dan Keluarga sebagai Pusat Pelayanan	37
C. Peran Serta Masyarakat dalam Kebidanan Komunitas	42
D. Asuhan Antenatal di Komunitas.....	45
E. Asuhan Intranatal di Komunitas	47

F. Asuhan Postnatal di Komunitas.....	49
G. Asuhan Bayi dan Balita di Komunitas	50
H. Penutup	51
Referensi.....	53

BAB 4 PENCEGAHAN KOMPLIKASI KEHAMILAN RISIKO TINGGI55

A. Pendahuluan.....	55
B. Definisi Kehamilan Risiko Tinggi	56
C. Kriteria Kehamilan Risiko Tinggi.....	57
D Konsep Risiko dalam Kehamilan	57
E. Implikasi Definisi dalam Praktik Kebidanan Komunitas	58
F. Faktor Risiko Kehamilan Risiko Tinggi	58
G. Jenis Komplikasi pada Kehamilan Risiko Tinggi	61
H Pencegahan Komplikasi Kehamilan Risiko Tinggi.....	63
I. Peran Bidan dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan Risiko Tinggi.....	65
J. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	68
Referensi.....	71
Glosarium.....	75

BAB 5 PERAN BIDAN DALAM SISTEM RUJUKAN MATERNAL NEONATAL77

A. Sistem Rujukan	77
B. Kegawatdaruratan maternal dan neonatal.....	78
C. Rujukan maternal dan neonatal	85
D. Penutup	88
Referensi.....	89
Glosarium.....	90

BAB 6 PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER KESEHATAN BERBASIS

KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM UPAYA MENURUNKAN AKI DAN AKB DI

INDONESIA91

A. Pendahuluan.....	91
B. Konsep Dasar Pemberdayaan dalam Kebidanan Komunitas.....	92
C. Pemberdayaan Keluarga dalam Kesehatan Ibu dan Anak.....	95
D. Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas	97
E. Strategi Pemberdayaan Berbasis Komunitas	99
F. Tantangan dan Hambatan dalam Pemberdayaan Keluarga dan Kader.....	101

G. Penutup	104
Referensi	106
Glosarium	110

BAB 7 MODEL INTERVENSI KEBIDANAN KOMUNITAS BERBASIS LOKAL111

A. Pendahuluan	111
B. Kawal Bumil Kawal Masa Depan: Sinergi Lintas Sektor Untuk Kesehatan Ibu Anak	112
C. Model Berbasis Masyarakat	114
D. Kelas Ayah Siaga	115
E. Pelayanan Kebidanan Berbasis Komunitas (PKBK)	116
F. Digitalisasi Layanan Kebidanan Komunitas	118
G. Desa Siaga	119
H. Society 5.0	121
I. Penutup	123
Referensi	124
Glosarium	126

PROFIL PENULIS128

BAB 1

EPIDEMIOLOGI AKI DAN AKB DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara. Tingginya AKI dan AKB mencerminkan masih adanya permasalahan dalam akses pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan maternal dan neonatal, status sosial ekonomi, pendidikan masyarakat, serta faktor budaya yang berkembang di masyarakat.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kematian ibu adalah kematian seorang perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan dalam waktu 42 hari setelah terminasi kehamilan akibat penyebab yang berkaitan dengan kehamilan dan penanganannya. Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Kedua indikator ini menjadi target utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan AKI dan AKB, terutama pada wilayah terpencil dan kepulauan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan menjadi faktor utama tingginya kematian maternal dan neonatal.

B. Epidemiologi Kesehatan Ibu dan Anak

Epidemiologi kesehatan ibu dan anak merupakan cabang ilmu epidemiologi yang mempelajari distribusi, frekuensi, determinan, serta faktor risiko yang memengaruhi status kesehatan ibu dan anak dalam suatu populasi. Fokus kajian ini meliputi kesehatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, serta kesehatan neonatus, bayi, dan anak. Pendekatan epidemiologi digunakan untuk mengidentifikasi pola masalah kesehatan, faktor penyebab, kelompok berisiko, serta strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Amalia et al., 2023).

Kesehatan ibu dan anak menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu negara karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan pembangunan kesehatan nasional. Indikator yang sering digunakan dalam epidemiologi kesehatan ibu dan anak antara lain Angka

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN), prevalensi stunting, prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR), serta cakupan pelayanan antenatal care (ANC) dan persalinan oleh tenaga kesehatan (Fitriani & Astutik, 2024).

Epidemiologi kesehatan ibu dan anak tidak hanya menitikberatkan pada faktor biologis, tetapi juga memperhatikan determinan sosial kesehatan seperti pendidikan, status ekonomi, budaya, lingkungan, sanitasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tingkat morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, terutama di negara berkembang (Putri & Maulidia, 2023).

Pendekatan epidemiologi berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan ibu dan anak. Data epidemiologi dapat digunakan untuk memetakan wilayah dengan risiko tinggi, menentukan prioritas masalah kesehatan, serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (Titaley et al., 2022).

Kesehatan ibu dan anak masih menjadi salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Meskipun telah terjadi penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menurunkan AKI dan AKB (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Angka Kematian Ibu di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Penyebab utama kematian ibu meliputi perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, komplikasi persalinan, serta penyakit penyerta yang diperburuk oleh kondisi kehamilan (Amalia et al., 2023). Selain faktor medis, terdapat pula faktor nonmedis yang berkontribusi terhadap tingginya AKI, seperti keterlambatan mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan yang adekuat atau dikenal dengan konsep *three delays* (Mustofa, 2024).

Ketimpangan akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses yang lebih rendah terhadap pelayanan antenatal care dan persalinan di fasilitas kesehatan dibandingkan perempuan di wilayah perkotaan (Fitriani & Astutik, 2024).

Permasalahan kesehatan anak di Indonesia juga masih cukup kompleks. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti prematuritas, asfiksia, infeksi neonatal, berat badan lahir rendah (BBLR), dan komplikasi persalinan (Oza et al., 2014). Penelitian lain menunjukkan bahwa komplikasi maternal dan neonatal, berat badan lahir ekstrem, serta keterlambatan penanganan rujukan menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko kematian neonatal di Indonesia (Alvianto et al., 2026).

Selain masalah mortalitas, Indonesia juga menghadapi masalah stunting yang masih cukup tinggi pada balita. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas anak di masa depan (Putri & Maulidia, 2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di Indonesia meliputi rendahnya status ekonomi keluarga, kurangnya asupan gizi, sanitasi yang buruk, rendahnya pemberian ASI eksklusif, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan (Putri & Maulidia, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program pelayanan antenatal terpadu, persalinan di fasilitas kesehatan, program imunisasi nasional, peningkatan gizi ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, serta penguatan pelayanan primer melalui Puskesmas dan Posyandu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan ibu juga mulai berkembang di Indonesia. Penggunaan aplikasi pemantauan kesehatan ibu hamil dinilai mampu meningkatkan deteksi dini komplikasi kehamilan, mempermudah pemantauan kondisi ibu, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan maternal (Widi et al., 2025).

Meskipun berbagai program telah dilakukan, tantangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih cukup besar. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta faktor sosial budaya masyarakat masih menjadi hambatan dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak (Amalia et al., 2023).

Pendekatan epidemiologi sangat penting dalam mendukung penguatan sistem kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Data epidemiologi dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pengembangan program kesehatan, evaluasi intervensi, dan pemetaan wilayah prioritas sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran (Titaley et al., 2022).

C. Konsep Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai status kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan maternal. AKI menggambarkan jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, yang disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan maupun penanganannya, tetapi bukan akibat kecelakaan atau cedera (World Health Organization, 2023).

Menurut WHO, kematian ibu mencerminkan kegagalan sistem pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang aman, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh perempuan. Oleh karena itu, AKI menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan nifas, serta sistem rujukan maternal dan neonatal (WHO, 2023).

AKI digunakan secara global sebagai indikator pembangunan kesehatan karena memiliki hubungan erat dengan kualitas hidup perempuan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan keberhasilan program kesehatan nasional. Tingginya AKI menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan maternal, serta adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Say et al., 2014).

Dalam konsep epidemiologi, kematian ibu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kematian obstetri langsung dan kematian obstetri tidak langsung. Kematian obstetri langsung terjadi akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas atau akibat intervensi, kelalaian, maupun penanganan yang tidak tepat selama proses tersebut. Penyebab utama kematian obstetri langsung meliputi perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan, eklampsia, infeksi, dan komplikasi persalinan (Kassebaum et al., 2016).

Sementara itu, kematian obstetri tidak langsung terjadi akibat penyakit yang telah dimiliki ibu sebelum kehamilan atau penyakit yang berkembang selama masa kehamilan dan diperburuk oleh kondisi kehamilan tersebut, seperti penyakit jantung, anemia berat, diabetes mellitus, tuberkulosis, dan hipertensi kronis (Filippi et al., 2018).

Di Indonesia, AKI masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023, penyebab utama kematian ibu meliputi perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan komplikasi obstetri lainnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Tingginya AKI di Indonesia

menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelayanan kesehatan maternal, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses fasilitas kesehatan.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingginya AKI di Indonesia meliputi rendahnya akses pelayanan antenatal care (ANC), keterlambatan rujukan, rendahnya tingkat pendidikan ibu, kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata (Amalia et al., 2023). Ketimpangan pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesehatan maternal di Indonesia (Fitriani & Astutik, 2024).

Konsep *three delays* atau tiga keterlambatan sering digunakan untuk menjelaskan tingginya angka kematian ibu di negara berkembang. Tiga keterlambatan tersebut meliputi keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan yang adekuat setelah tiba di fasilitas kesehatan (Thaddeus & Maine, 1994). Ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan maternal di Indonesia.

Angka Kematian Ibu dihitung dengan membandingkan jumlah kematian ibu dalam suatu periode tertentu dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama, kemudian dikalikan dengan 100.000 kelahiran hidup. Rumus ini digunakan secara internasional untuk memudahkan perbandingan antarwilayah maupun antarnegara (WHO, 2023).

Rumus AKI dapat dituliskan sebagai berikut:

$$AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$$

Berdasarkan rumus tersebut, yang dimaksud dengan jumlah kematian ibu adalah seluruh kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat penyebab yang berkaitan dengan kehamilan atau penanganannya. Sementara itu, jumlah kelahiran hidup adalah seluruh bayi yang lahir hidup pada periode dan wilayah yang sama (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Sebagai contoh, apabila dalam satu tahun di suatu wilayah terdapat 25 kematian ibu dan 10.000 kelahiran hidup, maka perhitungan AKI adalah sebagai berikut:

$$AKI = \frac{25}{10.000} \times 100.000 = 250$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di wilayah tersebut adalah 250 per 100.000 kelahiran hidup. Semakin tinggi nilai AKI, maka semakin besar risiko kematian ibu di wilayah tersebut dan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal (WHO, 2023).

AKI digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program kesehatan ibu, memantau tren kesehatan maternal, serta menentukan prioritas intervensi kesehatan masyarakat. Data AKI juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan, perencanaan program pelayanan maternal, dan penguatan sistem rujukan kesehatan ibu dan bayi (Say et al., 2014).

Dalam praktik epidemiologi, pengukuran AKI sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan, perbedaan definisi kematian ibu, serta masih adanya kasus kematian ibu yang tidak tercatat, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans kesehatan maternal dan peningkatan kualitas data menjadi hal yang sangat penting dalam menghasilkan estimasi AKI yang akurat (Kassebaum et al., 2016).

Upaya penurunan AKI memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan peningkatan akses pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi ibu, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, penguatan sistem rujukan, serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Dengan intervensi yang tepat dan berbasis data epidemiologi, diharapkan AKI dapat terus menurun sehingga target pembangunan kesehatan nasional dan global dapat tercapai (Filippi et al., 2018).

D. Konsep Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. AKB menggambarkan jumlah kematian bayi yang terjadi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu (World Health Organization, 2024).

AKB digunakan secara luas dalam bidang epidemiologi dan kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, gizi, pendidikan, serta kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di suatu wilayah. Tingginya angka kematian bayi menunjukkan masih adanya masalah

kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (CDC, 2024).

Menurut WHO, kematian bayi mencakup seluruh kematian yang terjadi sejak bayi lahir hidup hingga sebelum mencapai usia satu tahun. Kematian bayi dibedakan menjadi kematian neonatal, yaitu kematian pada usia 0–28 hari, dan kematian postneonatal, yaitu kematian pada usia 29 hari hingga kurang dari satu tahun (WHO, 2024).

Kematian neonatal merupakan penyumbang terbesar dalam angka kematian bayi, terutama di negara berkembang. WHO melaporkan bahwa sebagian besar kematian neonatal terjadi pada minggu pertama kehidupan dan banyak di antaranya terjadi dalam 24 jam pertama setelah lahir. Penyebab utama kematian neonatal meliputi prematuritas, asfiksia lahir, infeksi neonatal, dan kelainan kongenital (WHO, 2024).

AKB menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ketiga yang menargetkan penurunan kematian neonatal hingga minimal 12 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita hingga 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations Economic Commission for Europe, 2024).

Di Indonesia, AKB masih menjadi salah satu masalah kesehatan prioritas nasional. Penyebab utama kematian bayi di Indonesia meliputi berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, asfiksia, infeksi, diare, pneumonia, dan masalah gizi (Titaley et al., 2022). Selain faktor medis, kondisi sosial ekonomi, pendidikan ibu, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan juga memengaruhi tingginya angka kematian bayi di Indonesia (Fitriani & Astutik, 2024).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki risiko kematian lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat badan normal. Selain itu, keterlambatan penanganan komplikasi neonatal dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan neonatal juga meningkatkan risiko kematian bayi (Alvianto et al., 2026).

AKB tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan bayi, tetapi juga menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan. Pelayanan antenatal care (ANC) yang tidak optimal, kurangnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, serta keterlambatan rujukan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian bayi di berbagai daerah (Amalia et al., 2023).

Angka Kematian Bayi dihitung dengan membandingkan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun dalam satu periode tertentu dengan jumlah kelahiran

hidup pada periode yang sama, kemudian dikalikan dengan 1.000 kelahiran hidup (WHO, 2024).

Rumus perhitungan AKB adalah sebagai berikut:

$$AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun)}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$$

Dalam rumus tersebut, jumlah kematian bayi adalah seluruh kematian bayi sejak lahir hidup hingga sebelum usia satu tahun yang terjadi dalam satu wilayah dan periode tertentu. Sementara itu, jumlah kelahiran hidup adalah seluruh bayi yang lahir hidup pada wilayah dan periode yang sama (United Nations Statistics Division, 2024).

Sebagai contoh, apabila dalam satu tahun di suatu wilayah terdapat 80 kematian bayi dan 5.000 kelahiran hidup, maka perhitungan AKB adalah sebagai berikut:

$$AKB = \frac{80}{5000} \times 1000 = 16$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi di wilayah tersebut adalah 16 per 1.000 kelahiran hidup. Semakin tinggi nilai AKB, maka semakin tinggi risiko kematian bayi di wilayah tersebut dan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (Britannica, 2026).

AKB digunakan sebagai dasar dalam evaluasi program kesehatan ibu dan anak, pemantauan keberhasilan intervensi kesehatan neonatal, serta penentuan prioritas kebijakan kesehatan masyarakat. Data AKB juga digunakan untuk menilai efektivitas pelayanan antenatal, persalinan, imunisasi, program gizi, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (CDC, 2024).

Dalam praktik epidemiologi, pengukuran AKB sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sistem pencatatan kelahiran dan kematian, rendahnya kualitas pelaporan kesehatan, serta masih adanya kasus kematian bayi yang tidak tercatat, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan akses kesehatan terbatas (OECD, 2024).

Upaya penurunan AKB memerlukan pendekatan multidisiplin yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, perbaikan status gizi masyarakat, peningkatan sanitasi lingkungan, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal. Dengan pendekatan epidemiologi yang tepat, diharapkan angka kematian bayi dapat terus menurun sehingga target pembangunan kesehatan nasional dan global dapat tercapai (WHO, 2024).

E. Determinan AKI dan AKB di Indonesia

1. Determinan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan maternal suatu negara. Tingginya AKI mencerminkan masih adanya masalah dalam sistem pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (Amalia et al., 2024).

Di Indonesia, AKI masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kajian systematic review menunjukkan bahwa meskipun AKI mengalami penurunan dari tahun 1990 hingga 2020, disparitas antarwilayah masih sangat besar, terutama antara wilayah Jawa-Bali dan Indonesia Timur (Amalia et al., 2024).

Salah satu determinan utama tingginya AKI adalah komplikasi obstetri langsung seperti perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan, eklampsia, sepsis, dan komplikasi persalinan lainnya. Perdarahan dan gangguan hipertensi masih menjadi penyebab utama kematian maternal di Indonesia (Amalia et al., 2024).

Selain faktor medis, faktor sosial ekonomi juga memiliki hubungan yang kuat dengan kejadian kematian ibu. Perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, status ekonomi rendah, dan tinggal di daerah terpencil cenderung memiliki risiko kematian maternal yang lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal yang memadai (Firmansyah, 2023).

Akses pelayanan kesehatan maternal menjadi determinan penting lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal care (ANC), persalinan di luar fasilitas kesehatan, dan kurangnya tenaga kesehatan terlatih meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu (Aji et al., 2022).

Ketimpangan geografis di Indonesia juga memengaruhi tingginya AKI. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas kesehatan, sistem rujukan, dan distribusi tenaga kesehatan. Wilayah Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya masih mengalami hambatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal yang cepat dan berkualitas (Rizkianti et al., 2021).

Konsep three delays atau tiga keterlambatan menjadi salah satu pendekatan utama dalam menjelaskan determinan AKI di Indonesia. Tiga keterlambatan tersebut meliputi keterlambatan mengambil keputusan mencari pertolongan,

keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan pelayanan yang adekuat setelah tiba di fasilitas kesehatan (Natasha & Putri, 2022).

Faktor budaya dan kepercayaan masyarakat juga memengaruhi perilaku pencarian pelayanan kesehatan maternal. Masih adanya persalinan yang dibantu oleh dukun bayi tradisional serta rendahnya pengambilan keputusan kesehatan oleh perempuan di beberapa daerah menjadi hambatan dalam upaya penurunan AKI (World Bank, 2010).

Ketersediaan sumber daya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dokter spesialis obstetri, bidan, dan fasilitas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar maupun komprehensif juga berhubungan erat dengan AKI. Semakin rendah ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, maka semakin tinggi risiko kematian ibu (Sejati et al., 2023).

2. Determinan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam menggambarkan status kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan anak, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. AKB dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan determinan sosial lainnya (Titaley et al., 2008).

Di Indonesia, penyebab utama kematian bayi masih didominasi oleh prematuritas, asfiksia, infeksi neonatal, berat badan lahir rendah (BBLR), dan komplikasi neonatal lainnya. Bayi dengan BBLR memiliki risiko kematian neonatal yang jauh lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat badan normal (Sampurna et al., 2023).

Faktor maternal memiliki hubungan yang sangat erat dengan AKB. Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan, anemia, hipertensi, atau persalinan dengan komplikasi memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan kondisi kesehatan yang buruk dan meningkatkan risiko kematian bayi (Titaley et al., 2008).

Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan neonatal dan postnatal juga menjadi determinan utama AKB di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kunjungan postnatal care, keterlambatan penanganan komplikasi neonatal, dan rendahnya kualitas pelayanan rumah sakit meningkatkan risiko kematian neonatal (Sampurna et al., 2023).

Status sosial ekonomi keluarga sangat memengaruhi kesehatan bayi. Bayi yang lahir dari keluarga miskin cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap pelayanan kesehatan, gizi yang adekuat, sanitasi lingkungan, dan imunisasi sehingga lebih rentan mengalami kematian pada masa neonatal maupun bayi (Sariunita et al., 2024).

Faktor pendidikan ibu juga menjadi determinan penting AKB. Ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kesehatan kehamilan, perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif, dan tanda bahaya pada neonatus sehingga meningkatkan risiko keterlambatan penanganan penyakit pada bayi (Balkis et al., 2023).

Sanitasi lingkungan dan akses terhadap air bersih juga memiliki hubungan dengan kejadian kematian bayi, terutama akibat penyakit infeksi seperti diare dan pneumonia. Bayi yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk memiliki risiko kematian lebih tinggi dibandingkan bayi yang tinggal di lingkungan sehat (Sariunita et al., 2024).

Ketimpangan wilayah di Indonesia menyebabkan variasi AKB antarprovinsi. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah Papua dan Maluku memiliki angka kematian perinatal lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa-Bali akibat keterbatasan fasilitas kesehatan, transportasi, dan tenaga kesehatan (Sariunita et al., 2024).

Upaya penurunan AKI dan AKB di Indonesia memerlukan pendekatan multidisiplin melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, penguatan sistem rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat, serta penguatan intervensi berbasis komunitas. Pendekatan epidemiologi sangat penting untuk mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi dan menyusun kebijakan kesehatan berbasis bukti guna menurunkan kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan (Amalia et al., 2024).

F. Distribusi AKI dan AKB di Indonesia

1. Distribusi Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi salah satu indikator kesehatan yang menunjukkan adanya ketimpangan pelayanan kesehatan antarwilayah. Distribusi AKI di Indonesia tidak merata dan dipengaruhi oleh kondisi geografis, akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi di masing-masing daerah (Syairaji et al., 2024).

Berdasarkan hasil systematic review mengenai tren kematian maternal di Indonesia, angka kematian ibu nasional pada periode 2016–2020 mencapai sekitar 249 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, distribusi AKI masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antarprovinsi dan antarwilayah di Indonesia (Syairaji et al., 2024).

Wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur cenderung memiliki AKI lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa dan Bali. Tingginya AKI di wilayah tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, sulitnya akses transportasi, rendahnya jumlah tenaga kesehatan terlatih, serta keterbatasan sistem rujukan maternal-neonatal (Rizkianti et al., 2021).

Sebaliknya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta memiliki AKI yang relatif lebih rendah karena didukung oleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, jumlah rumah sakit yang lebih memadai, serta distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata (Sejati et al., 2023).

Distribusi AKI juga menunjukkan variasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah pedesaan memiliki risiko kematian maternal lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan akibat keterbatasan akses terhadap pelayanan antenatal care (ANC), fasilitas persalinan, serta keterlambatan penanganan komplikasi obstetri (Fitriani & Astutik, 2024).

Penyebab utama kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan, eklampsia, infeksi, dan komplikasi persalinan lainnya. Namun, distribusi penyebab kematian maternal juga berbeda antarwilayah. Di beberapa daerah terpencil, keterlambatan rujukan dan rendahnya kualitas pelayanan obstetri emergensi menjadi faktor dominan penyebab kematian ibu (Yanti, 2024).

Konsep *three delays* atau tiga keterlambatan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi distribusi AKI di Indonesia. Wilayah dengan akses transportasi terbatas dan fasilitas kesehatan yang berjauhan cenderung mengalami keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan pelayanan yang adekuat sehingga meningkatkan risiko kematian maternal (Fibriana & Azam, 2010).

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 4.000 kasus dan masih lebih tinggi dibandingkan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

2. Distribusi Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia

Distribusi Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia juga menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. AKB dipengaruhi oleh kondisi pelayanan kesehatan neonatal, status gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, tingkat pendidikan ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga (Titaley et al., 2008).

Berdasarkan data kesehatan nasional, AKB di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Target nasional RPJMN 2024 menetapkan AKB sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup, namun beberapa wilayah di Indonesia masih berada di atas target tersebut (Ikawati & Ramadhani, 2021).

Wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur memiliki AKB yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa dan Bali. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan fasilitas pelayanan neonatal, rendahnya jumlah tenaga kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi faktor utama tingginya AKB di wilayah tersebut (UNICEF Indonesia, 2024).

Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta cenderung memiliki AKB lebih rendah karena didukung oleh pelayanan neonatal yang lebih optimal, cakupan imunisasi yang tinggi, dan akses kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Distribusi AKB di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh kematian neonatal. WHO melaporkan bahwa sekitar 50% kematian bayi terjadi pada periode neonatal dan sebagian besar terjadi dalam minggu pertama kehidupan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan saat persalinan dan masa neonatal sangat menentukan keselamatan bayi baru lahir (WHO, 2024).

Penyebab utama kematian bayi di Indonesia meliputi prematuritas, asfiksia lahir, infeksi neonatal, pneumonia, diare, dan berat badan lahir rendah (BBLR). Distribusi penyebab kematian bayi berbeda antarwilayah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, kualitas pelayanan kesehatan, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat (Sampurna et al., 2023).

Kesenjangan AKB antara daerah perkotaan dan pedesaan juga masih cukup tinggi. Bayi yang lahir di daerah pedesaan memiliki risiko kematian lebih besar akibat keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan neonatal, rendahnya cakupan imunisasi, serta keterbatasan sarana sanitasi dan air bersih (Sariunita et al., 2024).

Distribusi AKB juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan tanda bahaya neonatal sehingga meningkatkan risiko kematian bayi (Balkis et al., 2023).

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai strategi untuk menurunkan AKI dan AKB melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, penguatan sistem rujukan maternal-neonatal, serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan epidemiologi sangat penting dalam memetakan distribusi AKI dan AKB sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

G. Program Pemerintah dalam Penurunan AKI dan AKB

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya strategis untuk menurunkan AKI dan AKB melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Syairaji et al., 2024).

Program pemerintah dalam penurunan AKI dan AKB dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target menurunkan AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan kematian neonatal menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2023). Pemerintah Indonesia juga menetapkan target nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan target AKI sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup (Wibowo, 2024).

Salah satu program utama pemerintah dalam penurunan AKI dan AKB adalah penguatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Program KIA mencakup pelayanan antenatal care (ANC), pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan nifas, pelayanan neonatal esensial, imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang anak (Safi'i et al., 2024).

Pelayanan antenatal care (ANC) menjadi strategi penting dalam menurunkan AKI dan AKB karena mampu mendeteksi dini faktor risiko dan komplikasi kehamilan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama kehamilan dengan standar pelayanan terpadu untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap optimal (Ulfa, 2025).

Selain ANC, pemerintah juga memperkuat program persalinan di fasilitas kesehatan melalui peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan risiko komplikasi obstetri yang menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi, seperti perdarahan postpartum, eklampsia, dan asfiksia neonatorum (Permata Sari et al., 2023).

Program Jaminan Persalinan (Jampersal) juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung penurunan AKI dan AKB. Program ini memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi (Amir, 2014).

Pemerintah Indonesia juga mengembangkan sistem rujukan maternal dan neonatal untuk mempercepat penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan. Penguatan sistem rujukan dilakukan melalui peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, penyediaan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di puskesmas, serta Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit (Rosyidatuzzahro & Supit, 2023).

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan, pemerintah juga mengembangkan program pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak. Program ini melibatkan rumah sakit rujukan nasional untuk membina fasilitas kesehatan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan maternal dan neonatal, terutama di provinsi dengan beban AKI dan AKB tinggi seperti Jawa Barat (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

Program penurunan AKI dan AKB juga dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis masyarakat. Salah satu bentuknya adalah optimalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai sarana pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita di tingkat masyarakat. Posyandu berperan penting dalam pemantauan status gizi, imunisasi, pemberian vitamin, edukasi kesehatan reproduksi, dan deteksi dini risiko kehamilan (Nurhayati & Mulyanti, 2023).

Selain itu, pemerintah memperkuat Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini berfokus pada penguatan fungsi keluarga, perencanaan kehamilan, pencegahan kehamilan risiko tinggi, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan keluarga (Chomariyati, 2020).

Pemerintah daerah juga mengembangkan berbagai inovasi lokal dalam upaya penurunan AKI dan AKB. Provinsi Jawa Timur misalnya mengembangkan program GELIAT yang menitikberatkan pada skrining risiko kehamilan, pendampingan ibu hamil, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan deteksi dini komplikasi maternal dan neonatal (Damayanti, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital kesehatan juga mulai dikembangkan untuk mendukung penurunan AKI dan AKB. Penggunaan Electronic Medical Record (EMR), aplikasi pemantauan ibu hamil, dan sistem pelaporan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) membantu meningkatkan kualitas pencatatan, pemantauan

risiko, dan evaluasi pelayanan kesehatan maternal-neonatal secara real time (Juliansyah et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan lintas sektor dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan ibu dan anak, terutama dalam penguatan edukasi masyarakat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan monitoring program kesehatan maternal-neonatal (Kemenko PMK, 2024).

Meskipun berbagai program telah dijalankan, tantangan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia masih cukup besar. Hambatan seperti ketimpangan geografis, keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, serta faktor sosial budaya masyarakat masih memengaruhi keberhasilan program pemerintah (Yulianto, 2026).

Pendekatan epidemiologi sangat penting dalam mendukung efektivitas program penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Data epidemiologi digunakan untuk memetakan wilayah prioritas, mengidentifikasi kelompok risiko tinggi, mengevaluasi efektivitas program kesehatan, serta menyusun kebijakan kesehatan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Syairaji et al., 2024).

H. Penutup

Epidemiologi AKI dan AKB merupakan bagian penting dalam kajian kesehatan masyarakat karena mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Melalui pendekatan epidemiologi, berbagai permasalahan kesehatan maternal dan neonatal dapat diidentifikasi secara sistematis sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan intervensi kesehatan yang lebih efektif.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya menurunkan AKI dan AKB. Tingginya angka kematian maternal dan neonatal dipengaruhi oleh berbagai determinan, baik faktor medis maupun nonmedis, seperti komplikasi obstetri, rendahnya akses pelayanan kesehatan, ketimpangan geografis, kondisi sosial ekonomi, pendidikan, sanitasi lingkungan, serta keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, distribusi AKI dan AKB di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi dan program untuk menurunkan AKI dan AKB melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas antenatal care, penguatan sistem rujukan maternal-neonatal,

optimalisasi Posyandu, pengembangan program keluarga berencana, serta pemanfaatan teknologi digital kesehatan. Keberhasilan program-program tersebut memerlukan dukungan lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Dengan penguatan surveilans epidemiologi, peningkatan kualitas data kesehatan, serta implementasi kebijakan berbasis bukti, diharapkan upaya penurunan AKI dan AKB di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas sehingga target pembangunan kesehatan nasional maupun SDGs dapat tercapai secara berkelanjutan.

Referensi

- Aji, R. S., et al. (2022). Determinants of maternal healthcare service utilisation among Indonesian mothers. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 15, 1325–1337.
- Alvianto, M. A. A., Kusumawardani, D. A., & Baroya, N. (2026). Risk factors of neonatal mortality in Jember Regency, Indonesia: A case-control study. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 14(1), 126–146.
- Amalia, R., Nurdianti, D. S., & Hakimi, M. (2023). Determinants of maternal mortality in Indonesia: A systematic review. *Belitung Nursing Journal*, 9(2), 145–154.
- Amalia, R., Nurdianti, D. S., & Hakimi, M. (2024). Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), 455.
- Amir, M. (2014). Dilema program MDGs dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui Jampersal di Kabupaten Tuban. *Jurnal Bina Praja*, 6(1), 11–20.
- Balkis, F., et al. (2023). Analysis determinants of neonatal death in Indonesia. *South Eastern Journal of Public Health*, 2(1), 1–10.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Infant mortality. Atlanta: CDC.
- Chomariyati, T. (2020). Upaya penurunan AKI dan AKB melalui peningkatan program Bangga Kencana di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah*, 19(2), 2051–2064.
- Damayanti, A. N. (2023). Strategi penurunan AKI/AKB di Indonesia dalam perspektif kesehatan masyarakat. Universitas Airlangga.
- Encyclopaedia Britannica. (2026). Infant mortality rate. Chicago: Britannica.
- Fibriana, A. I., & Azam, M. (2010). Three delay model sebagai salah satu determinan kematian ibu di Kabupaten Cilacap. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 16–23.
- Filippi, V., Chou, D., Ronsmans, C., Graham, W., & Say, L. (2018). Levels and causes of maternal mortality and morbidity. *Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health: Disease Control Priorities*, 2(3), 51–70.
- Firmansyah, F. (2023). Gambaran determinan kematian maternal. *Jurnal Ilmiah Sehat*, 5(2), 55–64.
- Fitriani, Y., & Astutik, E. (2024). Inequality in maternal healthcare utilization in Indonesia: Evidence from national survey data. *International Journal of Women's Health*, 16, 77–89.
- Ikawati, B., & Ramadhani, T. (2021). Pencapaian target angka kematian neonatus dan bayi dalam program kesehatan ibu dan anak dan langkah strategis selanjutnya. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(2), 87–95.
- Juliansyah, R., Aqid, B. M., Salsabila, A. P., & Nurfiyanti, K. (2024). Implementation of EMR system in Indonesian health facilities: Benefits and constraints. *arXiv*

Preprint, arXiv:2410.12226.

- Kassebaum, N. J., Barber, R. M., Bhutta, Z. A., Dandona, L., Gething, P. W., Hay, S. I., et al. (2016). Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *The Lancet*, 388(10053), 1775–1812.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Luncurkan program pengampunan kesehatan ibu dan anak, Kemenkes targetkan penurunan kematian ibu, bayi, dan stunting di Jawa Barat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). Sikapi serius tingginya AKI AKB, Kemenko PMK lakukan koordinasi multi-sektor. Jakarta: Kemenko PMK.
- Mustofa, A. (2024). Analisis kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 120–131.
- Natasha, T. Z., & Putri, A. (2022). Determinan kematian ibu serta upaya dalam penurunannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 14(3), 190–199.
- Nurhayati, & Mulyanti, D. (2023). Peran Puskesmas untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 2(2), 108–116.
- OECD. (2024). *Infant mortality rates*. Paris: OECD.
- Oza, S., Lawn, J. E., Hogan, D. R., Mathers, C., & Cousens, S. (2014). Cause-of-death estimates for the early and late neonatal periods for 194 countries from 2000–2013. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(1), 19–28.
- Permata Sari, I., et al. (2023). Faktor penyebab angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta strategi penurunan kasus: Systematic review. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(3), 2023–2035.
- Putri, A. D., & Maulidia, S. (2023). Pengelompokan kejadian stunting di Indonesia pada tahun 2022 dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 449–457.
- Rizkianti, A., Saptarini, I., & Rachmalina, R. (2021). Perceived barriers in accessing health care and the risk of pregnancy complications in Indonesia. *International Journal of Women's Health*, 13, 761–772.
- Rosyidatuzzahro, A., & Supit, P. W. E. (2023). Evaluasi pembangunan kesehatan dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Malang. *Journal Publicuho*, 6(1), 257–266.

- Safi'i, A., et al. (2024). Upaya strategis program kesehatan ibu dan anak dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia. *Jurnal ARSI*, 10(1), 44–56.
- Sampurna, M. T. A., et al. (2023). Determinants of neonatal deaths in Indonesia: A national survey data analysis of 10,838 newborns. *BMC Pediatrics*, 23(1), 215.
- Sariunita, N., et al. (2024). Regional perinatal mortality differences in Indonesia. *Public Health in Practice*, 6, 100457.
- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A. B., Daniels, J., et al. (2014). Global causes of maternal death: A WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 2(6), e323–e333.
- Sejati, E. N., et al. (2023). Trends and determinants of the maternal mortality ratio based on healthcare resources in Indonesia. *Unnes Journal of Public Health*, 12(2), 89–98.
- Syairaji, M., et al. (2024). Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), 455.
- Thaddeus, S., & Maine, D. (1994). Too far to walk: Maternal mortality in context. *Social Science & Medicine*, 38(8), 1091–1110.
- Titaley, C. R., Dibley, M. J., & Roberts, C. L. (2008). Determinants of neonatal mortality in Indonesia. *BMC Public Health*, 8, 232.
- Titaley, C. R., Dibley, M. J., & Roberts, C. L. (2022). Factors associated with neonatal mortality in Indonesia. *BMC Public Health*, 22(1), 1124.
- Ulfa, M. (2025). Strategi pelayanan antenatal care berkualitas dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. *Jurnal Riset Ilmiah*, 8(1), 12–24.
- UNICEF Indonesia. (2024). Kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- United Nations Economic Commission for Europe. (2024). Infant mortality rate: Sustainable Development Goals indicator 3.2.1. Geneva: UNECE.
- United Nations Statistics Division. (2024). Infant mortality rate glossary. New York: United Nations.
- United Nations. (2023). The Sustainable Development Goals Report 2023. New York: United Nations.
- Wibowo, D. (2024). Analisis implementasi keberhasilan program penurunan AKI dan AKB di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 23(2), 88–99.
- Widi, N. A. E., Runjati, R., & Sunarjo, L. (2025). Pregnant women's health monitoring application: Systematic literature review. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(1), 911–918.
- World Bank. (2010). "...and then she died": Indonesia maternal health assessment. Washington DC: World Bank.

- World Health Organization. (2023). Trends in Maternal Mortality 2000–2023. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2024). Infant mortality rate (between birth and 11 months per 1000 live births). Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2024). Newborn mortality. Geneva: WHO.
- Yulianto, M. A. (2026). Kajian strategi penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Ultras Brebes*, 8(2), 55–69.

Glosarium

Akses Pelayanan Kesehatan

Kemampuan individu atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara mudah, tepat waktu, dan terjangkau.

Antenatal Care (ANC)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin serta mendeteksi dini komplikasi kehamilan.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan 42 hari setelah persalinan per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu.

Angka Kematian Neonatal (AKN)

Jumlah kematian bayi usia 0–28 hari per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu.

Asfiksia Neonatorum

Kondisi bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan akibat kekurangan oksigen saat proses persalinan.

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Kondisi bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan.

Determinasi Kesehatan

Faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan seseorang atau kelompok masyarakat, baik faktor biologis, sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan.

Eklampsia

Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan kejang pada ibu hamil akibat hipertensi dalam kehamilan.

Epidemiologi

Ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, dan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu populasi.

Epidemiologi Kesehatan Ibu dan Anak

Cabang epidemiologi yang mempelajari masalah kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, serta kesehatan bayi dan anak dalam suatu populasi.

Hipertensi dalam Kehamilan

Peningkatan tekanan darah yang terjadi selama masa kehamilan dan dapat menyebabkan komplikasi bagi ibu maupun janin.

Imunisasi Dasar Lengkap

Pemberian vaksin dasar sesuai jadwal untuk melindungi bayi dan anak dari penyakit menular tertentu.

Infeksi Neonatal

Infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir selama periode neonatal, yaitu usia 0–28 hari.

Jampersal (Jaminan Persalinan)

Program pemerintah yang memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

Kematian Maternal

Kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, atau 42 hari setelah kehamilan akibat penyebab terkait kehamilan dan penanganannya.

Kematian Neonatal

Kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan.

Kesehatan Maternal

Kondisi kesehatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Komplikasi Obstetri

Gangguan atau masalah kesehatan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau nifas dan dapat membahayakan ibu maupun bayi.

Mortalitas

Angka atau tingkat kematian dalam suatu populasi pada periode tertentu.

Morbiditas

Keadaan sakit atau angka kejadian penyakit dalam suatu populasi.

Neonatus

Bayi baru lahir yang berusia 0–28 hari.

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal lengkap yang tersedia di rumah sakit.

Perdarahan Postpartum

Perdarahan yang terjadi setelah persalinan dan menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu.

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter atau bidan.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Upaya kesehatan berbasis masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas.

Prematuritas

Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu.

Prevalensi

Jumlah seluruh kasus suatu penyakit atau kondisi kesehatan pada populasi tertentu dalam periode waktu tertentu.

Rujukan Maternal-Neonatal

Sistem pengalihan pasien ibu atau bayi dengan komplikasi ke fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan lebih lengkap.

Sanitasi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan limbah untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Sepsis

Kondisi infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kegagalan organ.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar usianya.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Surveilans Epidemiologi

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara terus-menerus untuk mendukung pengambilan keputusan kesehatan masyarakat.

Three Delays

Konsep tiga keterlambatan penyebab kematian ibu, yaitu keterlambatan mengambil keputusan mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan yang adekuat.

BAB 2

DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN IBU DAN BAYI

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator paling penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Masa kehamilan, persalinan, dan masa neonatal merupakan periode yang sangat rentan karena pada fase ini tubuh ibu mengalami perubahan fisiologis yang signifikan, sementara bayi baru lahir masih sangat bergantung pada kondisi lingkungan eksternal untuk bertahan hidup.

Masalah kesehatan ibu dan bayi masih menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi, sedangkan pada bayi disebabkan oleh berat badan lahir rendah, asfiksia, dan infeksi neonatal. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi belum sepenuhnya optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebab kematian ibu dan bayi tidak hanya berasal dari faktor klinis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang lebih luas. Kondisi sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan ibu, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta lingkungan tempat tinggal memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan hasil kesehatan ibu dan bayi (Hakim et al., 2023). Dengan demikian, pendekatan kesehatan tidak dapat hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial yang melingkupi kehidupan masyarakat.

Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam determinan sosial kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis yang kompeten, serta kemudahan transportasi menuju layanan kesehatan sangat memengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Di daerah terpencil, keterbatasan akses ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan komplikasi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.

Lingkungan tempat tinggal turut memberikan pengaruh yang tidak kalah penting. Sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, serta kondisi perumahan yang tidak layak dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi pada ibu dan bayi. Selain itu, paparan terhadap polusi dan bahan berbahaya juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan kehamilan dan perkembangan bayi.

Faktor budaya dan norma sosial juga menjadi bagian dari determinan sosial kesehatan. Praktik-praktik tradisional yang tidak sesuai dengan prinsip kesehatan, seperti pantangan makanan tertentu bagi ibu hamil atau kebiasaan melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, dapat meningkatkan risiko komplikasi. Di sisi lain, dukungan keluarga dan masyarakat juga memiliki peran positif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, terutama dalam memberikan dukungan emosional dan praktis selama masa kehamilan dan setelah persalinan.

Oleh karena itu, pendekatan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi perlu dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh determinan sosial yang ada. Intervensi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perbaikan lingkungan, serta perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, menjadi kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan ibu dan bayi secara optimal.

Dengan memahami determinan sosial kesehatan ibu dan bayi secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menurunkan angka kematian serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan generasi mendatang.

B. Konsep Determinan Sosial Kesehatan

Determinan sosial kesehatan merupakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi derajat kesehatan individu maupun kelompok masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis atau medis, tetapi juga oleh berbagai kondisi eksternal yang membentuk kehidupan seseorang secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, lingkungan fisik, kondisi perumahan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kesehatan dan peluang individu untuk mencapai kondisi sehat secara optimal. Interaksi antar faktor tersebut berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan, sehingga kondisi kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia hidup.

Perkembangan konsep determinan sosial kesehatan didasarkan pada adanya ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan medis. Perbedaan status kesehatan antarkelompok sosial ekonomi tinggi dan rendah menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kesehatan. Individu yang hidup dalam kondisi sosial yang kurang menguntungkan, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan kesehatan, cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai

masalah kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesehatan merupakan hasil dari distribusi sumber daya dan kesempatan yang tidak merata di dalam masyarakat.

Dalam kajian kesehatan masyarakat, determinan sosial mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kesehatan, sementara pekerjaan dan pendapatan menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan kesehatan. Lingkungan fisik seperti sanitasi, kualitas udara, serta ketersediaan air bersih juga memiliki pengaruh langsung terhadap risiko penyakit. Keterkaitan antar faktor ini menunjukkan bahwa perubahan dalam satu aspek sosial dapat berdampak pada aspek kesehatan lainnya.

Astuti dan Widayatun (2021) menjelaskan bahwa faktor sosial seperti pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, dan kualitas pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kesehatan ibu hamil. Ibu yang memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai cenderung lebih mampu menjaga kesehatannya selama kehamilan melalui pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi, serta deteksi dini terhadap risiko komplikasi. Sebaliknya, keterbatasan dalam aspek sosial dapat menjadi hambatan dalam penerapan perilaku hidup sehat selama masa kehamilan.

Dahlgren dan Whitehead (1991) menggambarkan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh berbagai lapisan faktor yang dimulai dari karakteristik individu hingga kebijakan publik. Lapisan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan ibu dan bayi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang lebih luas, sehingga pemahaman terhadap determinan sosial kesehatan menjadi penting dalam melihat permasalahan kesehatan secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

C. Status Sosial Ekonomi Dan Kesehatan Ibu Bayi

Status sosial ekonomi merupakan salah satu determinan paling kuat dalam memengaruhi kesehatan ibu dan bayi karena berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengakses pelayanan kesehatan. Status ini mencakup pendapatan, jenis pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan keluarga yang secara langsung menentukan kualitas hidup, termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pemeriksaan kehamilan, serta persalinan yang aman. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sementara keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering menghadapi keterbatasan yang dapat berdampak pada meningkatnya risiko kesehatan ibu dan bayi.

Subramanian et al. (2022) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi. Keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, padahal asupan nutrisi yang cukup sangat penting bagi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Selain itu, biayapelayanan kesehatan yang relatif tinggi serta biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah dengan akses terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh langsung terhadap kemampuan individu dalam menjaga kesehatannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ibu hamil yang harus menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjaga kesehatan selama kehamilan. Tidak sedikit ibu yang menunda pemeriksaan kehamilan karena keterbatasan biaya atau karena harus memprioritaskan kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Penundaan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi komplikasi kehamilan, seperti anemia, hipertensi, atau gangguan pertumbuhan janin, yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemeriksaan rutin. Situasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi memiliki dampak nyata terhadap perilaku kesehatan ibu.

Pratiwi et al. (2023) menemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga, usia ibu, serta akses terhadap fasilitas kesehatan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kematian ibu di beberapa wilayah di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui keterbatasan akses informasi dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan. Ibu dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap edukasi kesehatan, sehingga kurang memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan perawatan kesehatan secara menyeluruh.

Selain itu, jenis pekerjaan juga menjadi bagian dari status sosial ekonomi yang turut memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Ibu yang bekerja dalam kondisi fisik yang berat atau dengan jam kerja yang panjang berisiko mengalami kelelahan yang dapat berdampak pada kondisi kehamilan. Di sisi lain, pekerjaan dengan pendapatan rendah sering kali tidak memberikan jaminan kesehatan yang memadai, sehingga menambah beban ketika membutuhkan pelayanan medis. Keterkaitan antara pendapatan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan ini menunjukkan bahwa status sosial ekonomi memiliki peran yang sangat kompleks dalam menentukan kesehatan ibu dan bayi, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

D. Pendidikan dan Literasi Kesehatan Ibu

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan literasi kesehatan ibu karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung lebih mudah memahami informasi kesehatan, baik yang diperoleh dari tenaga kesehatan maupun media lainnya, sehingga mampu menerapkan perilaku hidup sehat selama masa kehamilan dan setelah persalinan. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi landasan utama dalam membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Notoatmodjo (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan dasar terbentuknya perilaku kesehatan, yang berarti semakin baik tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk menerapkan perilaku kesehatan yang positif. Dalam kesehatan ibu, pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemenuhan gizi yang cukup, pengenalan tanda bahaya kehamilan, serta perawatan bayi baru lahir. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih siap dalam menghadapi berbagai kondisi selama kehamilan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi.

Astuti et al. (2021) menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam melakukan ante natal care secara rutin dibandingkan ibu dengan pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai faktor pelindung dalam kesehatan ibu dan bayi karena mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan. Ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi juga cenderung lebih aktif dalam mencari informasi kesehatan dan lebih terbuka terhadap praktik kesehatan modern, sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjaga kesehatannya.

Selain itu, literasi kesehatan yang baik turut memengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia di masyarakat. Tambunan (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan layanan posyandu sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu mengenai manfaat pelayanan kesehatan dasar. Ibu yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih cenderung memanfaatkan layanan seperti imunisasi, pemeriksaan tumbuh kembang anak, serta konsultasi kesehatan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, semakin besar kemungkinan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi.

Secara keseluruhan, pendidikan dan literasi kesehatan memiliki hubungan yang erat dalam membentuk perilaku kesehatan ibu. Tingkat pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan ibu dalam memahami informasi, mengambil keputusan, serta memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu faktor kunci dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi, terutama dalam mencegah berbagai risiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, maupun masa setelah kelahiran.

E. Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

Akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi mencerminkan sejauh mana individu dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan secara tepat waktu, aman, dan berkualitas. Konsep akses tidak hanya terbatas pada keberadaan fasilitas kesehatan, melainkan juga mencakup aspek keterjangkauan biaya, kemudahan transportasi, kesiapan tenaga kesehatan, serta kualitas layanan yang diberikan. World Health Organization (2022) menegaskan bahwa persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih memiliki kontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan layanan kesehatan yang memadai perlu diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya secara nyata.

Permasalahan yang sering muncul di berbagai wilayah adalah adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Hakim et al. (2023) mengungkapkan bahwa faktor jarak menuju fasilitas kesehatan, keterbatasan sarana transportasi, serta rendahnya frekuensi kunjungan antenatal memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya risiko kematian ibu. Kondisi geografis seperti daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur yang belum berkembang sering kali menjadi penghambat utama dalam memperoleh layanan kesehatan secara cepat. Keterlambatan dalam mendapatkan penanganan medis dapat memperbesar kemungkinan terjadinya komplikasi yang seharusnya dapat dicegah sejak dini.

Selain faktor fisik dan geografis, kualitas pelayanan kesehatan juga berpengaruh terhadap keputusan ibu dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Pelayanan yang kurang responsif, keterbatasan tenaga kesehatan, serta fasilitas yang belum memadai dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Situasi ini berpotensi membuat ibu hamil enggan melakukan pemeriksaan rutin atau memilih alternatif lain yang belum tentu aman secara medis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses perlu disertai dengan perbaikan mutu pelayanan agar dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat.

Aspek sosial juga memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat pemanfaatan layanan kesehatan. Tambunan (2023) menjelaskan bahwa keputusan

untuk mengakses pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh motivasi individu dan dukungan keluarga. Dukungan keluarga dapat berupa dorongan moral, bantuan finansial, hingga kemudahan dalam mobilitas menuju fasilitas kesehatan. Keberadaan dukungan ini mampu meningkatkan kesadaran ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin serta memanfaatkan layanan kesehatan lainnya.

Keterkaitan antara faktor ekonomi, geografis, kualitas layanan, dan dukungan sosial memperlihatkan bahwa akses pelayanan kesehatan merupakan konsep yang bersifat multidimensional. Upaya peningkatan akses tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi juga perlu memperhatikan keterjangkauan, kualitas pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang menyeluruh ini memberikan peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayiserta menekan risiko kematian yang dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan yang optimal.

F. Lingkungan dan Budaya

Lingkungan fisik dan sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi karena berkaitan langsung dengan kondisi tempat tinggal dan kualitas hidup sehari-hari. Lingkungan yang tidak sehat, seperti sanitasi yang buruk, kepadatan hunian, serta keterbatasan akses terhadap air bersih, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi pada ibu hamil maupun bayi baru lahir. UNICEF (2021) menjelaskan bahwa perbaikan sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu upaya penting dalam menurunkan angka kematian bayi di negara berkembang. Kondisi lingkungan yang bersih dan sehat mampu mendukung proses kehamilan yang lebih aman serta pertumbuhan bayi yang optimal sejak awal kehidupan.

Pengaruh lingkungan tidak hanyaterbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kondisi sosial yang membentuk kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Lingkungansosial yang kurang mendukung, seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan, dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan. Sebaliknya, lingkungan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan cenderung mendorong individu untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan secara keseluruhan memiliki peran penting dalam membentuk pola kesehatan ibu dan bayi.

Selain itu, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan perilaku kesehatanibu. Rahmanet al. (2019) menemukan bahwa kepercayaan tradisional masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan ibu dalam mencari pelayanan kesehatan modern. Dalam beberapa masyarakat, praktik

persalinan masih dilakukan secara tradisional karena adanya kepercayaan terhadap tokoh adat atau dukun bayi yang dianggap lebih sesuai dengan nilai dan kebiasaan setempat. Kepercayaan ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

Budaya dapat berfungsi sebagai faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Nilai budaya yang sejalan dengan prinsip kesehatan modern dapat meningkatkan kesadaran ibu dalam menjaga kesehatannya, sementara kepercayaan yang kurang sesuai dapat menghambat akses terhadap pelayanan medis yang aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi perlu mempertimbangkan aspek budaya agar intervensi yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat.

Keterkaitan antara lingkungan dan budaya memperlihatkan bahwa kesehatan ibu dan bayi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh kondisi sosial yang lebih luas. Lingkungan yang sehat dan budaya yang mendukung perilaku kesehatanan memberikan dampak positif terhadap kualitas kesehatan ibu dan bayi. Pendekatan yang memperhatikan kedua aspek ini menjadi penting dalam menciptakan upaya kesehatan yang efektif dan berkelanjutan di masyarakat.

G. Ketimpangan Sosial dan Kematian Ibu Bayi

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan angka kematian ibu dan bayi di berbagai kelompok masyarakat. Kondisi ini muncul akibat perbedaan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung menghadapi berbagai individu untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan secara keseluruhan memiliki peran penting dalam membentuk pola kesehatan ibu dan bayi.

Selain itu, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan perilaku kesehatan ibu. Rahmanet al. (2019) menemukan bahwa kepercayaan tradisional masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan ibu dalam mencari pelayanan kesehatan modern. Dalam beberapa masyarakat, praktik persalinan masih dilakukan secara tradisional karena adanya kepercayaan terhadap tokoh adat atau dukun bayi yang dianggap lebih sesuai dengan nilai dan kebiasaan setempat. Kepercayaan ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.

Budaya dapat berfungsi sebagai faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Nilai budaya yang sejalan

dengan prinsip kesehatan modern dapat meningkatkan kesadaran ibu dalam menjaga kesehatannya, sementara kepercayaan yang kurang sesuai dapat menghambat akses terhadap pelayanan medis yang aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi perlu mempertimbangkan aspek budaya agar intervensi yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat.

Keterkaitan antara lingkungan dan budaya memperlihatkan bahwa kesehatan ibu dan bayi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh kondisi sosial yang lebih luas. Lingkungan yang sehat dan budaya yang mendukung perilaku kesehatanan memberikan dampak positif terhadap kualitas kesehatan ibu dan bayi. Pendekatan yang memperhatikan kedua aspek ini menjadi penting dalam menciptakan upaya kesehatan yang efektif dan berkelanjutan di masyarakat.

H. Ketimpangan Sosial dan Kematian Ibu Bayi

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan angka kematian ibu dan bayi di berbagai kelompok masyarakat. Kondisi ini muncul akibat perbedaan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kelompok masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan yang tidak stabil, serta akses layanan kesehatan yang terbatas, sehingga memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Marmot (2022) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan sosial merupakan akar dari ketidaksetaraan kesehatan, yang menunjukkan bahwa perbedaan kondisi sosial akan berdampak langsung pada perbedaan hasil kesehatan yang diperoleh individu maupun kelompok.

Ketimpangan sosial tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perbedaan kondisi geografis dan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas kesehatan, di mana kelompok tertentu memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup sehat dibandingkan kelompok lainnya.

Hakim et al. (2023) menemukan bahwa faktor pendidikan, jarak ke fasilitas kesehatan, serta kurangnya pemeriksaan kehamilan menjadi determinan utama kematian ibu di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kematian ibu dan bayi tidak hanya disebabkan oleh faktor medis, tetapi juga dipengaruhi oleh

kondisi sosial yang kompleks dan saling berkaitan. Keterbatasan dalam pendidikan dapat memengaruhi pemahaman ibu terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan, sementara jarak dan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan medis.

Selain itu, ketimpangan sosial juga berpengaruh terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Individu yang berada dalam kondisi sosial yang kurang menguntungkan cenderung memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan kesehatan yang tepat, baik karena kurangnya informasi maupun keterbatasan sumber daya. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang tidak tertangani dengan baik selama kehamilan dan persalinan. Di sisi lain, kelompok dengan kondisi sosial yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan dan informasi, sehingga mampu melakukan tindakan pencegahan secara lebih optimal.

Keterkaitan antara berbagai faktor sosial tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kematian ibu dan bayi merupakan isu yang bersifat multidimensional. Ketimpangan sosial menciptakan hambatan dalam akses, pemanfaatan layanan, serta kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memperhatikan perbaikan kondisi sosial secara menyeluruh, sehingga kesenjangan kesehatan dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

I. Penutup

Determinan sosial kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan derajat kesehatan ibu dan bayi. Kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya, dan akses pelayanan kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial merupakan akar utama dari tingginya angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial masyarakat.

Referensi

- Astuti, Y., Widayatun. (2021). Social determinants of maternal health behavior during pregnancy in urban Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Hakim, L., Manurung, J., & Amazihono, I. F. A. (2023). Determinan kematian ibu dan bayi di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup*.
- Marmot, M. (2022). *Health equity in an unequal world*. The Lancet.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Pratiwi, D. I., et al. (2023). Determinan faktor kematian ibu di Kabupaten Sintang. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*.
- Rahman, A., et al. (2019). Cultural beliefs and maternal health service utilization. *BMC Public Health*.
- Subramanian, S. V., et al. (2022). Socioeconomic inequalities in maternal and child health outcomes. *The Lancet Public Health*.
- Tambunan, E. M. (2023). Determinan pemanfaatan posyandu dalam upaya kesehatan ibu dan anak. *Jurnal Kajian Kesehatan Masyarakat*.
- UNICEF. (2021). *Maternal and newborn health report*.
- World Health Organization. (2022). *Social determinants of health*. WHO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia*.

BAB 3

ASUHAN KEBIDANAN BERBASIS KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Pelayanan kebidanan memiliki peran yang cukup strategis dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, khususnya di tingkat komunitas. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk mendekatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak.

Asuhan kebidanan komunitas merupakan pelayanan kebidanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Pelayanan ini dilakukan oleh bidan komunitas yang bekerja di wilayah tertentu. Pelayanan kebidanan yang profesional ditujukan untuk masyarakat sebagai upaya mencapai pelayanan derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit, dengan menjamin terjangkaunya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus melibatkan seluruh kalangan masyarakat dan klien sebagai mitra dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kebidanan.

Keluarga memegang peran penting sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berperan langsung dalam keberhasilan asuhan kebidanan. Konsep pelayanan kebidanan yang berorientasi pada komunitas dan keluarga memberikan pendekatan holistik yang memandang ibu dan bayi dalam konteks lingkungan sosial dan budaya mereka.

B. Kebidanan Komunitas dan Keluarga sebagai Pusat Pelayanan

Kebidanan komunitas merupakan bentuk asuhan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya serta mendekatkan akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan. Sementara itu, layanan kebidanan komunitas adalah suatu usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan ibu dan anak, baik dalam lingkup keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Pelayanan kebidanan komunitas merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui

pendekatan berbasis komunitas. Konsep ini mengacu pada teori promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Teori *Diffusion of Innovations* oleh Rogers menyatakan bahwa inovasi, termasuk praktik kebidanan baru, akan lebih mudah diterima jika sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan komunitas perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan melibatkan tokoh masyarakat untuk mempercepat adopsi praktik kesehatan. Selain itu, teori *Continuity of Care* (COC) juga menjadi dasar penting. Teori ini menekankan kesinambungan pelayanan dari masa kehamilan hingga pascapersalinan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi optimal.

Prinsip pelayanan kebidanan komunitas meliputi pelayanan yang berkesinambungan, partisipatif, berbasis bukti, berorientasi pada keluarga, dan sensitif terhadap budaya lokal. Bidan dituntut untuk mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memberdayakan keluarga agar mandiri dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan anggotanya. Sebagai pusat pelayanan kesehatan, keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Konsep ini menekankan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mengenali masalah kesehatan, mengambil tindakan awal, dan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.

Keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan asuhan kebidanan, terutama dalam mendukung ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, dan pengasuhan bayi. Dukungan keluarga terbukti mempercepat proses pemulihan ibu dan meningkatkan kesehatan bayi. Bidan perlu melibatkan keluarga dalam setiap intervensi agar tercapai hasil yang optimal.

Peran keluarga dalam pelayanan kesehatan promotif adalah menciptakan lingkungan sehat dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Peran keluarga dalam pelayanan kesehatan preventif adalah melakukan upaya pencegahan penyakit seperti imunisasi, pengawasan gizi, dan sanitasi lingkungan. Peran keluarga dalam pelayanan kesehatan kuratif adalah memberikan pertolongan pertama pada kondisi sakit atau kecelakaan ringan. Peran keluarga dalam pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah mendukung anggota keluarga yang sedang dalam proses pemulihan atau memiliki penyakit kronis. Dengan menjadikan keluarga sebagai pusat pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan akan lebih berdaya guna dan berkelanjutan, karena keluarga adalah pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi kesehatannya sendiri.

Model pelayanan berbasis keluarga bertumpu pada prinsip bahwa keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Menurut teori *Family-Centered Care* (FCC), pelayanan kesehatan harus menghargai peran aktif keluarga dalam pengambilan keputusan dan perawatan pasien. FCC menekankan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga untuk menciptakan asuhan yang responsif terhadap kebutuhan individu dan keluarga secara holistik. Beberapa model pelayanan berbasis keluarga antara lain:

3. Keluarga Berencana (KB) Berbasis Keluarga

Keluarga Berencana (KB) berbasis keluarga adalah pendekatan pelayanan KB yang menempatkan keluarga sebagai pusat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program KB. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran secara sadar dan bertanggung jawab. KB berbasis keluarga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga, terutama pasangan suami istri, dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.

KB berbasis keluarga dilandaskan pada prinsip *Family-Centered Care* yang menghargai otonomi keluarga dan mendukung partisipasi mereka dalam setiap langkah pelayanan. Program ini tidak hanya memfokuskan pada aspek teknis penggunaan alat kontrasepsi tetapi juga edukasi menyeluruh mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, serta peran keluarga dalam mendukung keberhasilan KB.

4. Posyandu Keluarga

Posyandu keluarga adalah pengembangan dari posyandu konvensional yang memperluas cakupan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk bayi dan balita, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keluarga sehat melalui pelayanan kesehatan terpadu yang dilakukan secara berkala di tingkat desa atau kelurahan. Posyandu keluarga menjadi wadah kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif kesehatan keluarga.

Posyandu keluarga berlandaskan prinsip pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan keluarga, di mana keluarga menjadi pusat perhatian dalam setiap intervensi. Program ini menyatukan berbagai layanan seperti kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, pencegahan penyakit tidak menular (PTM), hingga pelayanan lansia. Keterpaduan layanan ini memungkinkan keluarga mendapatkan layanan yang komprehensif dalam satu tempat.

5. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Berbasis Keluarga

Pelayanan kesehatan reproduksi berbasis keluarga adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang memprioritaskan peran serta keluarga dalam menjaga, melindungi dan meningkatkan kesehatan reproduksi setiap anggota keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya tanggung jawab individu tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam keluarga untuk memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Konsep pelayanan kesehatan reproduksi berbasis keluarga mencakup berbagai aspek kesehatan reproduksi, mulai dari kesehatan ibu dan bayi, remaja, hingga lansia, termasuk edukasi seksual, perencanaan kehamilan, pencegahan infeksi menular seksual (IMS), serta pelayanan kesuburan dan menopause. Pelayanan ini dilakukan dengan cara yang komprehensif, berkesinambungan, dan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat.

6. Pendekatan Holistik dan Kultural dalam Keluarga

Pelayanan kebidanan berbasis keluarga harus memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal yang ada dalam komunitas. Pendekatan holistik mempertimbangkan semua aspek yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak, termasuk faktor psikososial, ekonomi, dan lingkungan. Pemahaman budaya yang baik membantu bidan memberikan pelayanan yang lebih diterima oleh masyarakat.

Pendekatan holistik dan kultural dalam keluarga adalah metode pelayanan kesehatan yang memandang individu sebagai bagian utuh dari sistem keluarga dan masyarakat, serta memperhatikan aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik lokal yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Pendekatan holistik menekankan bahwa kesehatan tidak hanya dilihat dari ketiadaan penyakit, tetapi juga dari keseimbangan seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga, bidan dan tenaga kesehatan harus memahami kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual setiap anggota keluarga. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan kultural melibatkan pemahaman terhadap norma, nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Pelayanan yang sensitif budaya memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan kepercayaan lokal. Ini memperkuat penerimaan program kesehatan dan meningkatkan efektivitas intervensi.

Strategi pelayanan kebidanan berbasis komunitas dan keluarga merupakan pendekatan terintegrasi yang memprioritaskan peran aktif keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Strategi ini menekankan kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas keluarga sebagai pusat pelayanan kesehatan. Beberapa strategi pelayanan kebidanan berbasis komunitas dan keluarga:

1. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Promosi kesehatan merupakan langkah pertama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Strategi yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan kesehatan, kampanye kesehatan, penggunaan media lokal, dan pelibatan tokoh masyarakat. Pencegahan penyakit dilakukan dengan imunisasi, pemeriksaan kehamilan rutin, serta penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

2. Deteksi Dini dan Intervensi

Deteksi dini bertujuan menemukan masalah kesehatan sejak awal agar dapat segera diintervensi. Bidan berperan penting dalam melakukan skrining rutin untuk mendeteksi risiko tinggi seperti preeklamsia, anemia, dan komplikasi persalinan. Intervensi dapat berupa rujukan cepat ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, atau pemberian asuhan kebidanan sesuai standar di komunitas.

3. Asuhan Kebidanan pada Ibu dan Anak di Tingkat Komunitas

Asuhan kebidanan mencakup perawatan selama kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Di tingkat komunitas, bidan memberikan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan yang aman, pelayanan postnatal, pemantauan tumbuh kembang, serta konseling menyusui. Bidan juga berperan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan kebidanan komunitas tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dengan sektor lain seperti dinas kesehatan, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah desa. Pendekatan multisektor membantu memperkuat program kesehatan ibu dan anak melalui sinergi berbagai pihak. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membentuk kader kesehatan, pelatihan, dan penguatan kapasitas komunitas agar mampu mandiri dalam menjaga kesehatan.

5. Inovasi dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas

Inovasi menjadi kunci untuk menjawab tantangan pelayanan kebidanan di komunitas, seperti penggunaan teknologi digital untuk konsultasi kesehatan, aplikasi pemantauan kehamilan, dan penyuluhan daring. Bidan diharapkan

adaptif terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan.

C. Peran Serta Masyarakat dalam Kebidanan Komunitas

Peran serta masyarakat adalah keterlibatan aktif individu, keluarga, kelompok, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanataan, dan evaluasi program kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan komunitas. Partisipasi ini mencerminkan rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di komunitas.

Peran serta masyarakat dalam suatu program akan menjamin perkembangan yang langsung, karena dasarnya adalah kebutuhan dan kesadaran dari masyarakat sendiri. Melalui peran serta, setiap anggota masyarakat dirangsang untuk belajar berorganisasi, dan mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tipologi peran serta masyarakat dalam kesehatan mengklasifikasikan tingkat dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan. Beberapa tipologi yang umum digunakan antara lain:

1. Tidak Berpartisipasi (*Non-Participatory*): masyarakat hanya sebagai penerima program tanpa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi Simbolik (*Tokenism*): masyarakat dilibatkan secara terbatas, hanya sebagai formalitas tanpa kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan.
3. Konsultatif (*Consultative*): masyarakat dimintai pendapat atau masukan, tetapi keputusan tetap diambil oleh pihak luar.
4. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*): masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program karena dianggap membantu efektivitas, namun tidak dalam perencanaan atau evaluasi.
5. Partisipasi Interaktif (*Interactive Participation*): masyarakat terlibat aktif dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan pengambilan keputusan.
6. Mobilisasi Mandiri (*Self-Mobilization*): masyarakat memprakarsai dan menjalankan kegiatan secara mandiri, dengan atau tanpa bantuan dari luar.

Peran serta masyarakat dalam kesehatan di komunitas mencakup bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi perorangan dan keluarga.

Partisipasi ini dilaksanakan oleh setiap individu, anggota keluarga dalam menolong dirinya sendiri dan keluarga untuk hidup sehat.

2. Partisipasi masyarakat umum.

Kegiatan partisipasi dalam meningkatkan kesehatan di komunitas dengan melakukan kerjasama yang aktif, menjalin hubungan yang baik antara masyarakat umum dengan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan. Partisipasi masyarakat umum yang ada di masyarakat seperti partisipasi kelompok kader, PKK, kelompok agama, kelompok karang taruna dan lain sebagainya.

3. Partisipasi masyarakat penyelenggara upaya kesehatan.

Kegiatannya meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat seperti balai pengobatan swasta, rumah bersalin swasta, dokter praktik swasta, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan kader, penghimpunan dana masyarakat untuk pelayanan kesehatan.

4. Partisipasi masyarakat profesi kesehatan, yaitu kelompok profesi kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Kegiatannya berupa pelayanan kesehatan, bersama-sama pemerintah menjalankan program untuk peningkatan kesehatan di komunitas.

Berikut merupakan bentuk pendekatan peran serta masyarakat, antara lain:

1. Peran serta dengan paksaan (Enforcement Participation).

Masyarakat melakukan peran serta pada suatu kegiatan atau program dengan cara dipaksa. Pemaksaan ini dilakukan melalui berlakunya peraturan atau undang-undang. Pendekatan ini lebih mudah dan cepat untuk melaksanakan program, namun masyarakat merasa takut karena peran serta dilakukan dengan paksaan, sehingga dapat menyebabkan masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

2. Persuasi dan edukasi.

Pendekatan ini dalam bentuk suatu partisipasi berdasarkan kesadaran masyarakat. Pendekatan ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh di masyarakat. Tetapi jika pendekatan ini berhasil dan tujuan program tercapai, maka masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan memelihara terhadap program yang dijalankan.

3. Peran serta karena imbalan (*Participation due to rewards*).

Peran serta yang dilakukan karena adanya imbalan yang diberikan, baik dalam bentuk materi, penghargaan, kedudukan.

4. Peran serta karena tuntutan akan hak asasi dan tanggung jawab.

Pendekatan ini biasanya terjadi di negara-negara maju yang paham demokrasi.

Dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kebidanan komunitas, wahana atau forum yang ada di masyarakat yang dipandang mampu untuk meningkatkan kesehatan komunitas diantaranya:

1. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

Posyandu merupakan wahana yang sudah dikenal luas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu adalah salah satu bentuk kegiatan nyata yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Kegiatan posyandu dilaksanakan oleh kader yang telah dilatih oleh puskesmas. Posyandu adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Posyandu berfungsi sebagai forum untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait masalah kesehatan yang dihadapi komunitas.

Tujuan dari penyelenggaraan posyandu antara lain menurunkan Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas), Angka Kematian Bayi (AKB), membudayakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat, meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

2. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

Pos Kesehatan Desa atau biasa disebut dengan Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela. Pengertian desa dapat berarti desa atau kelurahan atau nagari atau sebutan lainnya bagi satuan administrasi pemerintahan setingkat desa.

Peran serta masyarakat dalam pelayanan kebidanan komunitas melalui kegiatan poskesdes sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, poskesdes dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan tepat sasaran. Selain itu, poskesdes juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat, yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan di komunitas, khususnya pada kesehatan ibu dan anak. Melalui peran serta masyarakat yang penuh, pelayanan kesehatan di tingkat desa dapat lebih

efektif, berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota komunitas.

D. Asuhan Antenatal di Komunitas

Antenatal *Care* (ANC) merupakan asuhan berupa pemeriksaan kehamilan untuk mempersiapkan serta mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil dalam menghadapi persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya sistem reproduksi seperti keadaan sebelum hamil. Antenatal *Care* (ANC) terpadu adalah keterpaduan pelayanan antenatal dengan program lain yang diperlukan pencegahan serta penanganan segera selama masa kehamilan. Tujuan pelayanan ini untuk memberikan asuhan yang komprehensif, mendeteksi dan menangani gangguan pada ibu hamil, intervensi dini terhadap kelainan atau agngguan penyakit lain, serta menyediakan rujukan sesuai dengan sistem yang ada. Asuhan antenatal yang diadakan di masyarakat disebut asuhan antenatal di komunitas.

Pelaksanaan asuhan antenatal di lingkungan masyarakat merupakan serangkaian tindakan yang bersifat alami dan sistematis oleh bidan, yang bertujuan untuk mempersiapkan kehamilan serta persalinan yang sehat sesuai dengan standar yang ditetapkan, melalui kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan masyarakat. Tujuan khusus dari antenatal adalah:

1. Melakukan pemantauan perkembangan kehamilan untuk menjamin kondisi kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.
2. Mengidentifikasi secara dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin.
3. Menyusun rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ibu hamil.
4. Menyiapkan proses persalinan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu maupun bayi.
5. Merencanakan masa nifas dengan memperhatikan pemberian ASI secara optimal.

Standar pelayanan antenatal di tingkat komunitas pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan pelayanan yang diberikan di fasilitas klinik. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat enam komponen standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan antenatal, yaitu:

1. Identifikasi Ibu Hamil

Bidan melakukan kunjungan ke rumah serta menjalin interaksi secara berkala dengan masyarakat guna memberikan edukasi dan memotivasi ibu hamil, suami, serta anggota keluarga lainnya. Tujuannya adalah mendorong ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sejak dini dan teratur. Hasil yang diharapkan ibu mampu mengenali tanda-tanda kehamilan, ibu dan keluarga memahami

pentingnya pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur, meningkatnya jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada awal kehamilan.

2. Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal

Bidan melaksanakan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya empat kali selama masa kehamilan. Pemeriksaan ini meliputi anamnesis dan pemantauan secara cermat terhadap kondisi ibu dan janin untuk menilai apakah proses kehamilan berlangsung dengan normal. Bidan harus dapat mengidentifikasi kehamilan risiko tinggi maupun gangguan lain seperti anemia, malnutrisi, hipertensi, PMS, atau infeksi HIV. Bidan bertugas memberikan layanan imunisasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE), serta penyuluhan kesehatan, termasuk pelayanan lain yang terkait dengan fasilitas kesehatan primer. Bidan wajib mendokumentasikan data kunjungan secara akurat. Apabila ditemukan kelainan, bidan harus dapat menentukan langkah penanganan yang sesuai, termasuk melakukan rujukan bila diperlukan.

Hasil yang diharapkan yaitu ibu hamil memperoleh layanan antenatal sekurang-kurangnya empat kali selama kehamilan di bidan. Terjadi peningkatan pemanfaatan layanan kebidanan oleh masyarakat. Terlaksananya deteksi dini serta penanganan terhadap komplikasi kehamilan. Ibu hamil, suami, keluarga, serta masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil.

3. Palpasi Abdomen

Pemeriksaan abdomen dilakukan secara cermat melalui palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Seiring bertambahnya usia kehamilan, bidan juga memeriksa posisi janin, memastikan bagian terendah janin telah memasuki rongga panggul, mendeteksi kemungkinan adanya kelainan, serta melakukan rujukan secara tepat waktu bila diperlukan. Hasil yang diharapkan antara lain usia kehamilan dapat diperkirakan secara lebih akurat. Kehamilan ganda maupun kelainan lainnya dapat didiagnosis lebih awal dan segera dirujuk. Diagnosis kehamilan dapat ditegakkan secara dini dan rujukan dilakukan sesuai kebutuhan.

4. Pengelolaan Anemia pada Kehamilan

Bidan bertugas melaksanakan tindakan pencegahan, deteksi, penanganan, dan/atau merujuk seluruh kasus anemia selama kehamilan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil yang diharapkan ibu hamil dengan anemia berat dapat segera dirujuk. Terjadi penurunan jumlah ibu yang melahirkan dalam kondisi anemia. Menurunnya jumlah bayi yang lahir dengan anemia atau Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

5. Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan

Bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini setiap peningkatan tekanan darah selama masa kehamilan dan mengenali tanda-tanda preeklamsia. Selain itu, bidan juga harus mengambil langkah yang tepat dan melakukan rujukan sesuai kebutuhan. Hasil yang diharapkan adalah ibu hamil yang menunjukkan gejala preeklamsia dapat memperoleh perawatan yang memadai dan tepat waktu. Menurunnya angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh preeklamsia.

6. Persiapan Persalinan

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil dan keluarganya selama trimester ketiga. Bidan memastikan persiapan persalinan dilakukan secara menyeluruh dan aman, menciptakan suasana yang nyaman, memilih tempat persalinan yang sesuai, serta menyiapkan penolong persalinan, sarana transportasi, pendonor darah, biaya persalinan, dan kebutuhan lainnya untuk menghadapi kemungkinan kondisi gawat darurat. Bidan berupaya melakukan kunjungan ke setiap rumah ibu hamil.

Hasil yang diharapkan adalah ibu hamil, suami, dan keluarga terdorong untuk merencanakan persalinan yang bersih dan aman. Proses persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan yang layak dan aman, dengan bantuan dari tenaga bidan yang kompeten. Tersedianya sarana transportasi dan pembiayaan untuk merujuk ibu bersalin bila diperlukan. Rujukan dilakukan secara tepat waktu jika dibutuhkan.

E. Asuhan Intranatal di Komunitas

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan tindakan yang aman dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, seperti dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan bidan. Namun, pada praktiknya, masih dijumpai penolong persalinan yang bukan berasal dari tenaga kesehatan serta pelaksanaannya dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

Falsafah asuhan persalinan dalam komunitas menekankan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan persalinan dapat ditingkatkan melalui pendidikan, intervensi kesehatan, serta dukungan asuhan yang berorientasi pada kebutuhan individu dan keluarganya, baik dari sisi emosional, fisik, sosial, maupun klinis. Pelayanan harus diberikan secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan manajemen klinis yang sesuai dengan standar.

Tujuan dari pelaksanaan asuhan intranatal adalah menjamin bahwa proses persalinan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Menjamin kesiapan pelaksanaan persalinan yang bersih, aman, dan berlangsung dalam suasana yang nyaman dan mendukung. Menyediakan sarana transportasi serta alokasi dana rujukan yang memadai jika sewaktu-waktu diperlukan.

Standar asuhan pelayanan kebidanan terdiri dari standar pelayanan kebidanan dan persiapan.

1. Standar pelayanan kebidanan

a. Asuhan saat persalinan

Bidan melakukan penilaian secara akurat mengenai dimulainya proses persalinan, kemudian memberikan asuhan serta pemantauan yang memadai dengan tetap memperhatikan kebutuhan individu klien selama berlangsungnya proses persalinan.

b. Persalinan yang aman

Bidan memberikan pertolongan persalinan dengan menjunjung tinggi prinsip keamanan, kesopanan, serta menghargai klien dan mempertimbangkan tradisi setempat. Proses pengeluaran plasenta dilakukan dengan penegangan tali pusat yang terkontrol. Bidan melakukan penegangan tali pusat secara tepat untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara menyeluruh. Penanganan kala II dengan indikasi gawat janin dilakukan melalui tindakan episiotomy. Bidan mampu mengenali secara dini tanda-tanda gawat janin pada kala II yang berlangsung lama dan segera melakukan tindakan episiotomi secara aman untuk memperlancar proses persalinan, yang dilanjutkan dengan penjahitan perineum.

2. Persiapan

a. Persiapan bidan

- 1) Melakukan penilaian secara akurat terkait dimulainya proses persalinan, serta memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan tetap memperhatikan kebutuhan ibu selama proses berlangsung.
- 2) Menyediakan ruang persalinan yang hangat, bersih, dan nyaman guna menunjang proses persalinan serta kelahiran bayi.
- 3) Menyiapkan alat, bahan, dan obat-obatan yang diperlukan, serta memastikan ketersediaannya dalam jumlah dan jenis yang cukup, dalam kondisi siap pakai untuk setiap proses persalinan.
- 4) Mengatur kesiapan rujukan bersama ibu dan keluarganya, agar jika terjadi keterlambatan dalam merujuk ke fasilitas yang lebih memadai tidak membahayakan keselamatan ibu dan bayi.
- 5) Memberikan asuhan sayang ibu, seperti dukungan emosional, membantu pengaturan posisi ibu, pemberian cairan dan nutrisi, membantu relaksasi, penggunaan kamar mandi secara teratur, serta memberikan pertolongan

persalinan yang bersih dan aman dengan menerapkan teknik pencegahan infeksi.

b. Persiapan rumah dan lingkungan

Rumah harus dalam kondisi aman dan cukup hangat, tersedianya ruangan khusus untuk proses persalinan, ketersediaan air mengalir, terjaganya kebersihan lingkungan, adanya fasilitas media komunikasi yang dapat digunakan.

c. Persiapan ibu dan keluarga

Persiapan yang dilakukan oleh ibu dan keluarga mencakup penyediaan berbagai perlengkapan, seperti waskom besar, wadah atau ember untuk penyediaan air bersih, alat untuk mencuci tangan (air mengalir), sabun, handuk bersih, pakaian ibu, serta kain panjang yang dapat digunakan saat persalinan maupun setelah melahirkan. Selain itu perlu juga disediakan alas plastic, pembalut, handuk untuk bayi, waslap, perlengkapan pakaian bayi, selimut, dan kain halus atau lembut untuk mengeringkan serta membungkus bayi.

F. Asuhan Postnatal di Komunitas

Asuhan pascapersalinan merupakan bentuk manajemen pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam masa nifas di lingkungan masyarakat. Pemberian layanan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pemulihan dan kesejahteraan ibu setelah melahirkan. Tujuan dari pelayanan asuhan postnatal antara lain:

1. Memelihara kesehatan ibu serta bayinya.
2. Melaksanakan skrining secara menyeluruh untuk deteksi dini dan melakukan rujukan bila ditemukan komplikasi pada ibu maupun bayi.
3. Menyediakan edukasi kesehatan kepada ibu pasca persalinan.
4. Memberikan layanan terkait program keluarga berencana.

Kebijakan pemerintah dalam pelayanan postnatal menetapkan bahwa kunjungan postpartum dilakukan minimal sebanyak empat kali, yaitu pada 6-8 jam setelah persalinan, pada hari ke-6 setelah persalinan, dua minggu setelah persalinan, dan enam minggu setelah persalinan.

Pelayanan postpartum oleh bidan mencakup pemantauan selama empat jam pertama pascapersalinan, terutama tanda vital dan potensi perdarahan. Perawatan menyeluruh bagi ibu pascapersalinan, bimbingan terkait inisiasi menyusui dini, edukasi mengenai pemantauan kontraksi uterus kepada ibu dan keluarganya, pemberian dukungan psikologis. Penyuluhan kesehatan terkait kebutuhan gizi ibu, program KB, tanda bahaya masa nifas, hubungan seksual, serta perawatan bayi, bimbingan dalam merawat payudara dan area perineum.

G. Asuhan Bayi dan Balita di Komunitas

Bayi baru lahir (BBL)/neonatus adalah bayi dengan usia 0 hingga 28 hari. Pelayanan kesehatan pada neonatus merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Pelayanan ini wajib dilakukan paling sedikit tiga kali selama periode sejak bayi lahir hingga berusia 28 hari, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Tujuannya adalah menjamin proses pertumbuhan dan perkembangan bayi berlangsung secara optimal.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi neonatus meliputi:

1. Kunjungan neonatus pertama (KN 1), dilakukan dalam rentang waktu 6 hingga 48 jam setelah kelahiran. Tindakan yang dilakukan mencakup menjaga kehangatan tubuh bayi, memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan merawat tali pusat.
2. Kunjungan neonatus kedua (KN 2), dilaksanakan pada hari ke-3 hingga hari ke-7 setelah kelahiran. Tindakan yang dilakukan mencakup menjaga kehangatan tubuh bayi, pemberian ASI eksklusif, pencegahan infeksi, dan perawatan tali pusat.
3. Kunjungan neonatus ketiga (KN 3), dilakukan antara hari ke-8 hingga hari ke-28 setelah kelahiran. Dalam kunjungan ini dilakukan pemeriksaan adanya tanda bahaya atau gejala penyakit. Kegiatan utamanya menjaga kehangatan tubuh bayi, memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan melakukan perawatan pada tali pusat secara tepat.

Prinsip asuhan bayi dan balita dalam pelayanan kebidanan komunitas:

1. Bidan wajib memiliki data bayi dan balita yang berada di wilayah kerjanya.
2. Menjamin seluruh bayi memperoleh Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif.
3. Bidan perlu mencatat data bayi yang telah maupun belum menerima imunisasi.
4. Bekerjasama dengan masyarakat untuk memotivasi keluarga dalam memberikan imunisasi kepada bayinya.
5. Mengajak keluarga yang memiliki bayi dan balita agar memanfaatkan fasilitas posyandu dan sarana kesehatan lain di lingkungannya.
6. Memberikan pelayanan asuhan yang penting dan sesuai standar kepada bayi dan balita.
7. Melibatkan keluarga dalam kegiatan stimulasi serta pemantauan tumbuh kembang anak.

8. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola asuh anak tanpa diskriminasi gender serta menanamkan nilai-nilai anti kekerasan, baik fisik maupun psikis.
9. Menyampaikan informasi kepada keluarga mengenai deteksi dini penyakit yang umum menyerang bayi dan balita, pentingnya gizi seimbang, serta pola perawatan yang tepat.
10. Membantu keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti pembuatan akta kelahiran dan dokumen penting lainnya.

Pengelolaan dengan pendekatan manajemen terpadu untuk bayi baru lahir (BBL):

1. Pemeriksaan dan perawatan BBL.
 - a. Perawatan tali pusat, pemberian ASI secara eksklusif, memastikan bayi telah menerima injeksi vitamin K.
 - b. Memastikan bahwa salep mata antibiotik telah diaplikasikan pada bayi.
 - c. Memberikan imunisasi hepatitis B-0 apabila belum dilakukan segera setelah kelahiran.
2. Pemeriksaan menggunakan pendekatan MTBM
 - a. Dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda bahaya seperti infeksi bakteri, ikterus, diare, serta permasalahan dalam pemberian ASI.
 - b. Pemberian imunisasi hepatitis B-0 diberikan kepada bayi yang belum menerima pada saat kelahiran
 - c. Mencakup edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif, pencegahan hipotermia, serta panduan dalam melakukan perawatan BBL di rumah dengan memanfaatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

H. Penutup

Kebidanan komunitas memusatkan perhatian pada ibu dan balita, keluarga, serta masyarakat. Setiap individu merupakan makhluk sosial dengan keunikan masing-masing, budaya tertentu, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, sosial budaya, ekonomi serta lingkungan. Pelayanan kebidanan komunitas mencakup seluruh upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh bidan di lingkungan komunitas. Pelayanan ini melibatkan berbagai aspek mulai dari kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga kesehatan reproduksi perempuan secara menyeluruh.

Bidan memiliki peran ganda sebagai pemberi layanan kesehatan sekaligus sebagai pendidik dan advokat bagi masyarakat. Tanggung jawab bidan dalam komunitas meliputi penyuluhan kesehatan, deteksi dini masalah kesehatan, rujukan,

serta pelaksanaan program nasional seperti imunisasi, KB, dan gizi. Asuhan kebidanan komunitas yang komprehensif dan berkesinambungan sbegai upaya dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.

Referensi

- BKKBN. (2020). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana*.
- Cholifah, S. & Purwanti, Y. (2019). *Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Devitasari, I., et al. (2024). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Fitri, F. J. (2020). Asuhan Kebidanan Continuity of Care di Klinik Medika Utama Sidoarjo. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 34-43.
- Ginting, A. B., et al. (2025). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia.
- Hutasuhut, R. M. et al. (2023). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional.
- International Cofederation of Midwives (ICM). (2020). *Strengthening Midwifery Services in Low-Resource Settings*.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2017). *Essential Competencies for Midwifery Practice*.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2019). *Midwifery Services Framework*.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Midwifery: A Vital Health-Care Service*.
- Karyati, D. P., & Mujiwati, S. (2011). *Asuhan Kebidanan V (Kebidanan Komunitas)*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Kementerian Kesehatan RI (2023). Panduan Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Permenkes No. 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidan Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Permenkes No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Kebidanan Komunitas*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Modul Keluarga Sehat*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Rencana Strategis Kesehatan Ibu dan Anak*.
- Mangngi, A. P., Nainggolan, L., Sormin, R. E. M., & Mauliyah, I. (2025). Asuhan Kebidanan di Komunitas di Era Society 5.0. Padang: Get Press Indonesia.
- Mas'udah, S., Tumilah, T., & Windyarti, M. L. N. Z. (2023). Asuhan Kebidanan

- Berkelanjutan (Continuity of Care) pada Ny. "A" G1P0A0 di Puskesmas Kedung I Jepara. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2), 67-72.
- Mubarak, W. I. (2012). *Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi dalam Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Podungge, Y. (2020). Asuhan Kebidanan Komprehensif. *Jambura Health and Sport Journal*, 2(2), 68-77.
- Siti, C. & Yanik, P. (2019). *Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Solekhah, H. L. M., Tyarini, I. A., Nurdiani, N., & Nugraheni, N. (2024). Studi Kasus: Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. S di Puskesmas Watumalang Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(2), 181-188.
- Susanti, K., & Ruspita, R. (2022). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Triana, H. K. & Wulandari, N. (2023). Asuhan Kebidanan Komprehensif. *Journal of Health Care Education*, 2(1), 15-25.
- World Health Organization (WHO). (2016). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*.
- World Health Organization (WHO). (2018). *Family Health: A Global Perspective*.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health*.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Community-Based Maternal and Newborn Health Care*.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Innovations in Maternal and Child Health*.

BAB 4

PENCEGAHAN KOMPLIKASI KEHAMILAN RISIKO TINGGI

A. Pendahuluan

Kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) masih menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, serta akses terhadap layanan kesehatan maternal dan neonatal. Sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi yang tepat, terutama melalui deteksi dini dan pencegahan komplikasi pada kehamilan risiko tinggi (WHO, 2023).

Kehamilan risiko tinggi merupakan kondisi kehamilan yang memiliki potensi lebih besar untuk mengalami komplikasi yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor maternal seperti usia, penyakit penyerta, status gizi, maupun faktor obstetri seperti riwayat kehamilan sebelumnya dan komplikasi kehamilan saat ini. Kajian epidemiologi menunjukkan bahwa sebagian besar kematian maternal berkaitan dengan komplikasi yang sebenarnya dapat diidentifikasi sejak awal melalui pelayanan antenatal yang berkualitas (Carroli et al., 2001).

Pendekatan kebidanan komunitas memiliki peran strategis dalam menurunkan AKI dan AKB melalui upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan berperan dalam menjangkau kelompok rentan, melakukan skrining risiko, memberikan edukasi, serta memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan ibu. Model pelayanan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi dini kehamilan risiko tinggi dan meningkatkan kepatuhan kunjungan antenatal (Naswir, 2022; Fauziah et al., 2023).

Perkembangan ilmu kebidanan dan kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pendekatan *continuum of care*, yaitu pelayanan berkesinambungan sejak prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor risiko sejak dini dan intervensi yang tepat sebelum terjadi komplikasi. Evidence menunjukkan bahwa peningkatan kualitas antenatal care (ANC) secara signifikan

berkontribusi dalam menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, terutama melalui deteksi dini kondisi seperti preeklamsia, anemia, dan infeksi (Yeoh et al., 2016; Iskandar et al., 2025).

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa tantangan dalam pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi masih cukup besar. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta rendahnya literasi kesehatan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko komplikasi. Pendekatan kebidanan komunitas yang melibatkan kader kesehatan, keluarga, dan masyarakat menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan tersebut. Intervensi berbasis komunitas seperti edukasi kesehatan, pemantauan ibu hamil, serta rujukan tepat waktu terbukti meningkatkan keselamatan ibu dan bayi (Prasetyo et al., 2020).

Pembahasan mengenai pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi dalam konteks kebidanan komunitas menjadi sangat relevan karena sebagian besar faktor risiko dapat diidentifikasi dan dikelola pada tingkat pelayanan primer. Upaya preventif yang dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi secara signifikan.

B. Definisi Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi merupakan kondisi kehamilan yang memiliki kemungkinan lebih besar mengalami komplikasi dibandingkan kehamilan normal, baik terhadap ibu, janin, maupun keduanya. Konsep ini berkembang dalam ilmu obstetri sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejak dini kehamilan yang memerlukan perhatian khusus dan intervensi lebih intensif (Yang et al., 2025).

Definisi kehamilan risiko tinggi tidak bersifat tunggal karena dapat bervariasi berdasarkan pedoman klinis dan konteks pelayanan kesehatan. Sebagian besar literatur mendefinisikan kehamilan risiko tinggi sebagai kehamilan dengan satu atau lebih faktor risiko yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal (Yang et al., 2025; Rodrigues et al., 2016).

Pendekatan berbasis evidence menunjukkan bahwa identifikasi kehamilan risiko tinggi dilakukan melalui penilaian faktor risiko yang mencakup aspek medis, obstetri, dan sosial. Penilaian ini bertujuan untuk

mendeteksi potensi komplikasi sejak awal sehingga dapat dilakukan pencegahan atau penanganan yang tepat (Torricelli et al., 2012).

C. Kriteria Kehamilan Risiko Tinggi

1. Faktor Maternal

Meliputi usia terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun), status gizi buruk, anemia, serta adanya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Usia maternal lanjut terbukti meningkatkan risiko komplikasi obstetri seperti preeklamsia dan persalinan prematur (Correa-de-Araujo & Yoon, 2021).

2. Faktor Obstetri

Mencakup riwayat komplikasi pada kehamilan sebelumnya seperti abortus berulang, persalinan prematur, perdarahan, atau operasi sesar. Kehamilan ganda, kelainan letak janin, serta gangguan plasenta juga termasuk dalam kategori ini (Flenady et al., 2011).

3. Faktor Kehamilan Saat Ini

Meliputi kondisi yang muncul selama kehamilan seperti preeklamsia, eklamsia, diabetes gestasional, infeksi, serta gangguan pertumbuhan janin. Faktor-faktor ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan risiko kematian ibu dan bayi apabila tidak ditangani dengan baik (Bartsch et al., 2016).

4. Faktor Sosial dan Lingkungan

Kondisi sosial ekonomi rendah, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, serta rendahnya literasi kesehatan juga berperan dalam meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Faktor ini sering kali menjadi determinan tidak langsung yang memperburuk kondisi kesehatan ibu (Lee et al., 2012).

D. Konsep Risiko dalam Kehamilan

Konsep risiko dalam kehamilan bersifat dinamis dan dapat berubah sepanjang periode kehamilan. Kehamilan yang awalnya normal dapat berkembang menjadi risiko tinggi apabila muncul komplikasi tertentu. Oleh karena itu, pemantauan berkelanjutan melalui pelayanan antenatal menjadi sangat penting dalam mendeteksi perubahan kondisi secara dini (Mirzakhani et al., 2020).

Pendekatan modern dalam kebidanan menekankan bahwa semua kehamilan memiliki potensi risiko. Prinsip ini mendorong tenaga kesehatan untuk tidak hanya berfokus pada kelompok berisiko tinggi, tetapi juga memberikan pelayanan berkualitas pada seluruh ibu hamil sebagai upaya pencegahan universal (Yang et al., 2025).

E. Implikasi Definisi dalam Praktik Kebidanan Komunitas

Definisi kehamilan risiko tinggi memiliki implikasi penting dalam praktik kebidanan komunitas. Identifikasi dini memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk melakukan stratifikasi risiko dan menentukan rencana asuhan yang sesuai. Pendekatan berbasis komunitas menekankan pentingnya skrining sederhana yang dapat dilakukan di tingkat pelayanan primer maupun oleh kader kesehatan. Sistem rujukan yang efektif menjadi bagian penting dalam memastikan ibu dengan risiko tinggi mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif di fasilitas kesehatan yang memadai.

Bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem penilaian risiko secara sistematis dalam pelayanan antenatal dapat meningkatkan deteksi dini komplikasi serta menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal (Farajnezhad et al., 2017).

Definisi kehamilan risiko tinggi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis dan perencanaan intervensi kesehatan masyarakat. Pemahaman yang tepat mengenai konsep ini memungkinkan upaya pencegahan komplikasi dilakukan secara lebih efektif, terutama dalam konteks kebidanan komunitas yang berorientasi pada deteksi dini dan intervensi tepat waktu.

F. Faktor Risiko Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang memengaruhi kondisi ibu dan janin. Identifikasi faktor risiko menjadi langkah kunci dalam upaya pencegahan komplikasi karena sebagian besar kondisi tersebut dapat dikenali sejak awal kehamilan bahkan sebelum konsepsi. Pendekatan berbasis evidence menunjukkan bahwa faktor risiko dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu faktor maternal, janin, lingkungan, serta pelayanan kesehatan (Muglia et al., 2022; Yang et al., 2025).

1. Faktor Maternal

Faktor maternal merupakan determinan utama dalam kehamilan risiko tinggi. Usia ibu menjadi salah satu indikator penting, di mana kehamilan pada usia terlalu muda maupun usia lanjut memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Kondisi biologis yang belum matang atau penurunan fungsi organ reproduksi berkontribusi terhadap meningkatnya risiko tersebut.

Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, anemia, dan penyakit jantung memiliki pengaruh signifikan terhadap kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia, gangguan pertumbuhan janin, hingga kematian maternal. Status gizi juga menjadi faktor penting, di mana malnutrisi maupun obesitas dapat mengganggu keseimbangan metabolik dan hormonal selama kehamilan (Muglia et al., 2022).

Riwayat obstetri sebelumnya, seperti abortus berulang, persalinan prematur, atau operasi sesar, juga meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada kehamilan berikutnya. Faktor ini menunjukkan pentingnya pendekatan life course dalam memahami risiko kehamilan.

2. Faktor Janin

Faktor janin mencakup kondisi yang berasal dari atau memengaruhi perkembangan janin selama kehamilan. Kehamilan ganda, kelainan kongenital, serta gangguan pertumbuhan intrauterin merupakan kondisi yang sering dikaitkan dengan risiko tinggi.

Penurunan gerakan janin, misalnya, menjadi indikator klinis penting yang dapat mengarah pada risiko kematian perinatal jika tidak ditangani secara cepat. Studi sistematis menunjukkan bahwa faktor janin memiliki kontribusi signifikan terhadap luaran kehamilan, termasuk prematuritas dan berat badan lahir rendah (Carroll et al., 2019).

Interaksi antara faktor maternal dan janin juga berperan besar. Kondisi ibu seperti hipertensi atau diabetes dapat memengaruhi lingkungan intrauterin sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan dan perkembangan janin.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan semakin mendapat perhatian dalam kajian kesehatan reproduksi modern. Paparan terhadap polusi udara, bahan kimia, pestisida, serta zat berbahaya lainnya dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Merokok selama kehamilan merupakan salah satu faktor risiko lingkungan yang paling banyak diteliti dan terbukti meningkatkan risiko

komplikasi seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, serta gangguan perkembangan janin (Mund et al., 2013). Paparan bahan kimia yang bersifat endocrine disrupting chemicals (EDCs) juga diketahui dapat mengganggu sistem hormonal dan memengaruhi hasil kehamilan. Lingkungan tempat tinggal, termasuk akses terhadap sanitasi dan kondisi hunian, turut berperan sebagai determinan kesehatan kehamilan (Sakali et al., 2023).

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi berperan sebagai determinan tidak langsung yang memengaruhi kesehatan kehamilan. Tingkat pendidikan, pendapatan, serta status pekerjaan memengaruhi kemampuan ibu dalam mengakses pelayanan kesehatan dan informasi yang dibutuhkan. Perempuan dengan status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kehamilan risiko tinggi akibat keterbatasan akses layanan kesehatan, kurangnya nutrisi, serta rendahnya literasi kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan komplikasi kehamilan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga terkait dengan pembangunan sosial secara luas (Gedefaw et al., 2020).

5. Faktor Pelayanan Kesehatan

Akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu kehamilan berkembang menjadi risiko tinggi atau tidak. Kurangnya kunjungan antenatal, keterlambatan deteksi komplikasi, serta sistem rujukan yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi serius. Pelayanan antenatal yang tidak adekuat sering dikaitkan dengan peningkatan kejadian komplikasi kehamilan dan luaran buruk pada bayi. Sebaliknya, pelayanan yang berkualitas memungkinkan deteksi dini faktor risiko serta intervensi yang tepat waktu (Yeoh et al., 2016).

Faktor risiko kehamilan risiko tinggi menunjukkan bahwa kondisi ini bersifat multifaktorial dan dinamis. Interaksi antara faktor biologis, lingkungan, sosial, dan sistem kesehatan menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh ibu hamil. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam merancang intervensi pencegahan yang efektif, terutama dalam konteks kebidanan komunitas yang menekankan deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat.

G. Jenis Komplikasi pada Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi berkaitan erat dengan berbagai komplikasi yang dapat terjadi selama masa kehamilan, persalinan, maupun pascapersalinan. Komplikasi tersebut menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bukti global menunjukkan bahwa sebagian besar kematian maternal disebabkan oleh beberapa komplikasi utama yang sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat (Musarandega et al., 2021). Pemahaman mengenai jenis komplikasi menjadi penting dalam praktik kebidanan komunitas karena memungkinkan tenaga kesehatan melakukan skrining, edukasi, serta rujukan secara tepat waktu.

1. Preeklamsia dan Eklamsia

Preeklamsia merupakan gangguan hipertensi dalam kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan kerusakan organ, terutama ginjal dan hati. Kondisi ini dapat berkembang menjadi eklamsia yang ditandai dengan kejang dan berpotensi mengancam nyawa ibu serta janin. Preeklamsia menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi stroke, edema paru, gagal organ, hingga kematian maternal apabila tidak ditangani dengan baik (Ghulmiyyah & Sibai, 2012; Chang et al., 2023).

2. Perdarahan Obstetri

Perdarahan merupakan penyebab utama kematian ibu secara global, terutama perdarahan postpartum. Kondisi ini dapat terjadi akibat atonia uteri, plasenta previa, solusio plasenta, atau robekan jalan lahir. Perdarahan yang tidak tertangani dengan cepat dapat menyebabkan syok hipovolemik dan kematian dalam waktu singkat. Penelitian menunjukkan bahwa perdarahan berkontribusi besar terhadap kematian maternal, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan (Ziganshin & Nagimova, 2021).

3. Infeksi dalam Kehamilan

Infeksi selama kehamilan dapat berasal dari bakteri, virus, maupun parasit. Infeksi seperti sepsis, infeksi saluran kemih, serta infeksi intrauterin dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan janin. Infeksi juga memiliki hubungan dengan komplikasi lain seperti preeklamsia dan persalinan prematur. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kematian ibu

serta gangguan perkembangan janin (Conde-Agudelo et al., 2008; Nourollahpour Shiadeh et al., 2017).

4. Anemia dan Gangguan Nutrisi

Anemia merupakan kondisi yang sering terjadi pada kehamilan dan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko komplikasi seperti perdarahan, infeksi, serta kelelahan berat pada ibu. Anemia berat dapat memperburuk kondisi ibu saat terjadi komplikasi lain dan meningkatkan risiko kematian maternal. Kondisi ini juga berdampak pada janin, seperti berat badan lahir rendah dan prematuritas.

5. Diabetes Gestasional

Diabetes gestasional merupakan gangguan metabolisme glukosa yang terjadi selama kehamilan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti makrosomia janin, persalinan sulit, serta preeklamsia. Dampak jangka panjang juga perlu diperhatikan karena ibu dengan diabetes gestasional memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari (Neiger, 2017).

6. Persalinan Prematur

Persalinan prematur merupakan kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kondisi ini sering dikaitkan dengan berbagai faktor risiko seperti infeksi, preeklamsia, dan gangguan plasenta. Bayi prematur memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi seperti gangguan pernapasan, infeksi, serta gangguan perkembangan jangka panjang. Persalinan prematur menjadi salah satu penyumbang utama angka kematian neonatal.

7. Gangguan Plasenta

Gangguan plasenta seperti plasenta previa dan solusio plasenta merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan perdarahan hebat dan mengancam keselamatan ibu serta janin. Gangguan ini sering memerlukan intervensi medis segera, termasuk persalinan operatif, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

8. Komplikasi Multisistem

Kehamilan risiko tinggi juga dapat menyebabkan komplikasi yang melibatkan berbagai sistem organ, seperti gangguan ginjal, gangguan hati (HELLP syndrome), serta gangguan neurologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan tidak hanya terbatas pada sistem reproduksi, tetapi dapat berdampak sistemik terhadap kesehatan ibu (Szczepanski et al., 2020).

Jenis komplikasi pada kehamilan risiko tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi bersifat dapat dicegah apabila dikenali sejak dini. Pendekatan kebidanan komunitas berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat deteksi dini, serta memastikan rujukan yang tepat waktu. Upaya ini menjadi kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan.

H. Pencegahan Komplikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi merupakan strategi utama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pendekatan preventif berbasis kebidanan komunitas menekankan pentingnya deteksi dini, intervensi tepat waktu, serta keterlibatan aktif masyarakat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa sebagian besar komplikasi kehamilan dapat dicegah melalui pelayanan antenatal yang berkualitas dan berkesinambungan (WHO, 2018; Hofmeyr et al., 2023). Perkembangan ilmu kesehatan maternal mengarah pada pendekatan preventive continuum of care, yang mencakup intervensi sejak prakonsepsi hingga pascapersalinan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor risiko secara dini dan penerapan tindakan pencegahan yang sesuai dengan kondisi ibu hamil.

1. Pelayanan Antenatal Care (ANC) Berkualitas

Pelayanan antenatal merupakan intervensi utama dalam pencegahan komplikasi kehamilan. ANC tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan rutin, tetapi juga sebagai sarana skrining, edukasi, serta manajemen faktor risiko.

WHO merekomendasikan minimal delapan kali kunjungan antenatal untuk memastikan pemantauan optimal terhadap kondisi ibu dan janin. Pelayanan ANC yang berkualitas mencakup pemeriksaan tekanan darah, status gizi, kadar hemoglobin, deteksi infeksi, serta pemantauan pertumbuhan janin (WHO, 2018).

Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan pelayanan ANC secara adekuat memiliki risiko lebih rendah mengalami komplikasi seperti preeklamsia, anemia, dan persalinan prematur (Yeoh et al., 2016).

2. Deteksi Dini dan Skrining Risiko

Deteksi dini merupakan langkah penting dalam mencegah komplikasi serius. Skrining risiko dilakukan melalui pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang selama kehamilan.

Identifikasi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, anemia, dan riwayat obstetri memungkinkan tenaga kesehatan melakukan intervensi lebih awal. Sistem penilaian risiko yang sederhana dapat diterapkan di tingkat komunitas oleh bidan dan kader kesehatan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan rujukan tepat waktu dan mengurangi keterlambatan penanganan komplikasi (Amoakoh-Coleman et al., 2016).

3. Edukasi dan Pemberdayaan Ibu Hamil

Edukasi kesehatan menjadi komponen penting dalam pencegahan komplikasi. Ibu hamil perlu memahami tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, nyeri hebat, pembengkakan ekstrem, serta penurunan gerakan janin.

Peningkatan literasi kesehatan memungkinkan ibu dan keluarga mengambil keputusan yang tepat, termasuk mencari pertolongan medis lebih awal. Program edukasi berbasis komunitas terbukti meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan ibu hamil (de Masi et al., 2017).

4. Intervensi Nutrisi

Pemenuhan gizi yang adekuat berperan penting dalam mencegah komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan gangguan pertumbuhan janin. Suplementasi zat besi, asam folat, serta mikronutrien lainnya direkomendasikan selama kehamilan.

WHO juga merekomendasikan intervensi nutrisi tambahan pada kelompok berisiko untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Status gizi yang baik terbukti berhubungan dengan penurunan komplikasi kehamilan dan peningkatan luaran neonatal (WHO, 2020).

5. Pencegahan dan Penatalaksanaan Penyakit

Pengelolaan penyakit kronis dan infeksi selama kehamilan merupakan bagian penting dari pencegahan komplikasi. Pengendalian tekanan darah, kadar gula darah, serta pengobatan infeksi harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Intervensi seperti pemberian aspirin dosis rendah pada ibu berisiko preeklamsia atau terapi khusus pada kondisi tertentu telah terbukti efektif dalam menurunkan risiko komplikasi (Hofmeyr et al., 2023).

6. Sistem Rujukan yang Efektif

Sistem rujukan yang cepat dan tepat merupakan kunci dalam penanganan kehamilan risiko tinggi. Keterlambatan dalam rujukan sering menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi.

Kebidanan komunitas berperan dalam memastikan bahwa ibu hamil dengan risiko tinggi segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Koordinasi antara tenaga kesehatan di tingkat primer dan rujukan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan komplikasi.

7. Model Pelayanan Berbasis Komunitas

Model pelayanan kebidanan berbasis komunitas, termasuk continuity of care oleh bidan, terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehamilan. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan yang lebih dekat dan berkelanjutan terhadap kondisi ibu hamil.

Penelitian menunjukkan bahwa model pelayanan berbasis bidan dapat menurunkan risiko komplikasi, meningkatkan kepuasan ibu, serta meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan (Symon et al., 2016).

8. Keterlibatan Keluarga dan Masyarakat

Keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pencegahan komplikasi kehamilan. Dukungan keluarga memengaruhi keputusan ibu dalam mengakses layanan kesehatan serta kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan.

Program berbasis komunitas seperti kelas ibu hamil, kader kesehatan, serta pendampingan ibu hamil terbukti meningkatkan deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Pendekatan ini memperkuat sistem kesehatan dari tingkat paling dasar.

Pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara pelayanan klinis dan komunitas. Evidence menunjukkan bahwa kombinasi intervensi seperti ANC berkualitas, edukasi, nutrisi, serta sistem rujukan yang efektif dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi secara signifikan. Peran kebidanan komunitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan yang tepat sejak awal kehamilan hingga persalinan.

I. Peran Bidan dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan maternal di tingkat komunitas, terutama dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi. Peran bidan tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, edukatif, dan koordinatif yang terintegrasi dalam sistem kesehatan. Keberadaan bidan di masyarakat terbukti

berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan (Adnani et al., 2022).

Pendekatan kebidanan modern menekankan *continuity of care*, di mana bidan memberikan pelayanan berkelanjutan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga nifas. Model ini terbukti meningkatkan deteksi dini komplikasi serta memperbaiki luaran kesehatan ibu dan bayi (Hilal & Melia, 2025).

1. Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi

Bidan berperan dalam melakukan skrining awal terhadap ibu hamil untuk mengidentifikasi faktor risiko. Kegiatan ini meliputi pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, serta pemantauan perkembangan kehamilan secara berkala. Kemampuan bidan dalam mengenali tanda dan gejala awal komplikasi seperti preeklamsia, anemia, dan infeksi menjadi kunci dalam pencegahan komplikasi yang lebih berat. Studi menunjukkan bahwa deteksi dini oleh bidan di tingkat komunitas dapat menurunkan keterlambatan diagnosis dan meningkatkan keselamatan maternal (Aulia et al., 2026).

2. Pemberian Asuhan Antenatal Komprehensif

Pelayanan antenatal yang diberikan oleh bidan mencakup pemeriksaan rutin, konseling, serta intervensi preventif sesuai kebutuhan ibu hamil. Asuhan ini dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial ibu. Bidan juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan ibu terhadap jadwal kunjungan antenatal serta pelaksanaan intervensi seperti suplementasi zat besi dan imunisasi. Pelayanan antenatal oleh bidan terbukti meningkatkan kualitas kehamilan dan menurunkan risiko komplikasi (Yeoh et al., 2016).

3. Edukasi dan Konseling Kesehatan

Edukasi menjadi salah satu peran utama bidan dalam kebidanan komunitas. Informasi yang diberikan mencakup tanda bahaya kehamilan, pola hidup sehat, persiapan persalinan, serta pentingnya kunjungan antenatal. Bidan juga berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan keluarga sehingga keputusan terkait kesehatan ibu dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Edukasi berbasis komunitas terbukti meningkatkan perilaku pencarian pelayanan kesehatan dan menurunkan risiko komplikasi (Djannah & Ervina, 2026).

4. Pendampingan dan Continuity of Care

Pendampingan ibu hamil secara berkelanjutan memungkinkan bidan memahami kondisi individu secara lebih mendalam. Hubungan yang terjalin antara bidan dan ibu meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan terhadap anjuran kesehatan. Model continuity of care terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, terutama dalam mendeteksi perubahan kondisi secara dini dan memberikan intervensi tepat waktu (Taqiyya et al., 2025).

5. Koordinasi dan Sistem Rujukan

Bidan memiliki peran penting dalam sistem rujukan, terutama dalam mengidentifikasi kasus yang memerlukan penanganan lanjutan. Keputusan rujukan harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Koordinasi antara bidan dengan fasilitas kesehatan rujukan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan kehamilan risiko tinggi. Sistem rujukan yang efektif dapat mengurangi keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan yang memadai.

6. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Bidan berperan dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk mendukung kesehatan ibu hamil. Kegiatan seperti kelas ibu hamil, kunjungan rumah, serta pelibatan kader kesehatan menjadi bagian dari strategi ini. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan deteksi dini risiko serta peningkatan dukungan sosial bagi ibu hamil. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan program kesehatan maternal (Yuliwati & Sulistyaningrum, 2025).

7. Implementasi Praktik Berbasis Bukti

Bidan dituntut untuk menerapkan praktik berbasis bukti dalam setiap aspek pelayanan. Penggunaan pedoman klinis, standar pelayanan, serta hasil penelitian terbaru menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Penerapan evidence-based practice terbukti meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan kejadian komplikasi kehamilan. Penguatan kompetensi bidan melalui pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting dalam mendukung praktik ini (Ruhdiat et al., 2024).

8. Advokasi dan Peran dalam Sistem Kesehatan

Bidan juga berperan sebagai advokat dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi perempuan, terutama kelompok rentan. Peran ini mencakup upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperjuangkan

hak kesehatan ibu, serta mendukung kebijakan kesehatan maternal. Kontribusi bidan dalam sistem kesehatan nasional sangat penting, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu (Adnani et al., 2025).

Peran bidan dalam pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif bidan dalam deteksi dini, edukasi, pelayanan antenatal, serta koordinasi rujukan menjadi faktor kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pendekatan kebidanan komunitas yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesehatan maternal di Indonesia.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kehamilan risiko tinggi masih menjadi tantangan utama dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Berbagai komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan, infeksi, anemia, dan persalinan prematur memberikan kontribusi besar terhadap tingginya morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal. Sebagian besar komplikasi tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini, pelayanan antenatal yang berkualitas, serta sistem rujukan yang efektif dan tepat waktu.

Pendekatan kebidanan komunitas memiliki peran strategis dalam pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi karena mampu menjangkau ibu hamil hingga tingkat keluarga dan masyarakat. Peran bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan menjadi sangat penting dalam melakukan skrining risiko, edukasi kesehatan, pemantauan kondisi ibu hamil, serta pendampingan secara berkelanjutan selama masa kehamilan. Pelayanan yang berkesinambungan terbukti meningkatkan kualitas asuhan maternal dan memperbaiki luaran kesehatan ibu maupun bayi (Adnani et al., 2025).

Pencegahan komplikasi kehamilan tidak hanya berkaitan dengan intervensi medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Rendahnya literasi kesehatan, keterbatasan akses pelayanan, kondisi gizi yang kurang baik, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan masih menjadi penyebab tingginya risiko komplikasi pada ibu hamil. Pendekatan komunitas yang melibatkan keluarga, kader kesehatan, dan

masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan serta mempercepat pencarian pertolongan ketika muncul tanda bahaya kehamilan.

Penguatan pelayanan antenatal berbasis risiko menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan antenatal tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan rutin, tetapi juga sebagai sarana deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Penerapan standar pelayanan berbasis evidence dan rekomendasi WHO diperlukan agar setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan yang optimal sejak awal kehamilan (WHO, 2023).

Penguatan kapasitas bidan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal. Kompetensi bidan dalam mendeteksi komplikasi, melakukan penanganan awal, serta mengambil keputusan rujukan secara tepat sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi. Distribusi tenaga bidan yang merata, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, menjadi bagian penting dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan maternal.

Sistem rujukan maternal dan neonatal perlu diperkuat agar ibu hamil dengan risiko tinggi dapat memperoleh pelayanan yang sesuai secara cepat dan tepat. Keterlambatan rujukan masih menjadi salah satu faktor utama penyebab kematian maternal di Indonesia. Koordinasi antar fasilitas kesehatan, ketersediaan transportasi, serta kesiapan pelayanan kegawatdaruratan obstetri menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam penguatan sistem kesehatan maternal (Cahyanti et al., 2021).

Posyandu dan kader kesehatan perlu terus diberdayakan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Kegiatan edukasi kesehatan, pemantauan ibu hamil, serta kunjungan rumah menjadi bentuk intervensi yang efektif dalam meningkatkan deteksi dini komplikasi dan kepatuhan ibu terhadap pelayanan antenatal. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Kebijakan kesehatan maternal di Indonesia perlu dikembangkan secara lebih terintegrasi dengan program gizi, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan sosial. Pendekatan lintas sektor menjadi penting karena masalah kesehatan maternal tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi klinis semata. Faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan ibu dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Penguatan sistem informasi kesehatan maternal berbasis data dan evidence-based practice juga diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi program kesehatan. Data yang akurat memungkinkan identifikasi wilayah berisiko tinggi serta membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi pada akhirnya memerlukan kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan kebidanan komunitas yang berorientasi pada promotif dan preventif menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan neonatal di Indonesia. Upaya yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta mendukung tercapainya target pembangunan kesehatan nasional maupun global.

Referensi

- Adnani, Q. E. S., Gilkison, A., & McAra-Couper, J. (2022). Strengthening midwifery role in maternal health. *Women and Birth*.
- Adnani, Q. E. S., Okinarum, G. Y., Muchlis, M., & Susanti, A. I. (2025). Midwifery profession and maternal health outcomes. *Midwifery*.
- Ahmed, S., Li, Q., Liu, L., & Tsui, A. O. (2012). Maternal deaths averted by contraceptive use: An analysis of 172 countries. *The Lancet*.
- Akokuwebe, M. E., Idemudia, E. S., & Lekulo, A. M. (2021). Determinants of cervical cancer screening uptake among women. *BMC Public Health*.
- Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, J. V. (2020). Factors influencing sexual and reproductive health of women: A systematic review. *Reproductive Health*.
- Amoakoh-Coleman, M., Klipstein-Grobusch, K., et al. (2016). Provider adherence to antenatal care guidelines and pregnancy outcomes. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Amran, Y., Fasya, T. N., & Salamah, H. (2025). Factors associated with reproductive health service utilization in Indonesia. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*.
- Aulia, D. L. N., Anjani, A. D., & Billa, D. S. (2026). Role of midwives in high-risk pregnancy care. *Viva Medika*.
- Bartsch, E., Medcalf, K. E., Park, A. L., & Ray, J. G. (2016). Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in early pregnancy. *BMJ*.
- Bhutta, Z. A., Lassi, Z. S., Blanc, A., & Donnay, F. (2010). Linkages among reproductive health, maternal health, and perinatal outcomes. *Seminars in Perinatology*.
- Cahyanti, R. D., Widyawati, W., & Hakimi, M. (2021). Maternal death audits and evidence-based recommendations in Indonesia. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Canning, D., & Schultz, T. P. (2012). The economic consequences of reproductive health and family planning. *The Lancet*.
- Carroli, G., Rooney, C., & Villar, J. (2001). How effective is antenatal care in preventing maternal mortality and serious morbidity? *Paediatric and Perinatal Epidemiology*.
- Chang, K. J., Seow, K. M., & Chen, K. H. (2023). Preeclampsia: Recent advances in predicting and managing maternal complications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.

- Conde-Agudelo, A., Villar, J., & Lindheimer, M. (2008). Maternal infection and risk of preeclampsia. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*.
- Correa-de-Araujo, R., & Yoon, S. S. (2021). Clinical outcomes in high-risk pregnancies due to advanced maternal age. *Journal of Women's Health*.
- de Masi, S., Bucagu, M., & Tunçalp, Ö. (2017). Implementing WHO antenatal care recommendations. *Global Health: Science and Practice*.
- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception care: Closing the gap in the continuum of care. *Reproductive Health*.
- Djannah, R., & Ervina, A. (2026). Community-based midwifery interventions. *International Journal of Midwifery*.
- Farajnezhad, F., Shaahmadi, F., & Fashi, Z. (2017). Prevalence of high-risk pregnancy and associated factors. *Journal of Scientific Research*.
- Fauziah, A. B., Moedjiono, A. I., & Seweng, A. (2023). Early detection of high-risk pregnancies in community health services. *Journal of Public Health Research*.
- Flenady, V., Koopmans, L., Middleton, P., et al. (2011). Major risk factors for stillbirth. *The Lancet*.
- Gedefaw, G., Alemnew, B., & Demis, A. (2020). Adverse fetal outcomes and associated factors. *BMC Pediatrics*.
- Ghulmiyyah, L., & Sibai, B. (2012). Maternal mortality from preeclampsia/eclampsia. *Seminars in Perinatology*.
- Hilal, K., & Melia, H. (2025). Continuity of care model in midwifery services. *Journal of Sanitas et Salutem*.
- Hofmeyr, G. J., Black, R. E., Rogozińska, E., et al. (2023). Evidence-based antenatal interventions. *The Lancet*.
- Huzaimah, A., Abdillah, M., & Laila, N. Q. (2023). Disregarding the reproductive rights of women in child marriage in Indonesia. *Samarah Journal*.
- Iskandar, S. I., Aryanto, S., & Prawitasari, S. (2025). Strengthening antenatal care to improve maternal health outcomes. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Kusuma, D., Cohen, J., McConnell, M., & Berman, P. (2016). Can cash transfers improve determinants of maternal mortality? *Social Science & Medicine*.
- Lee, S., Ayers, S., & Holden, D. (2012). Risk perception during high-risk pregnancy. *Health, Risk & Society*.

- Limato, R., Ahmed, R., Magdalena, A., & Nasir, S. (2018). Evaluation of community health worker interventions in Indonesia. *Evaluation and Program Planning*.
- Mirzakhani, K., Ebadi, A., & Faridhosseini, F. (2020). Well-being in high-risk pregnancy: An integrative review. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Muglia, L. J., Benhalima, K., Tong, S., & Ozanne, S. (2022). Maternal factors influencing pregnancy outcomes. *BMC Medicine*.
- Mund, M., Louwen, F., & Klingelhofer, D. (2013). Smoking and pregnancy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Musarandega, R., Nyakura, M., et al. (2021). Causes of maternal mortality: A systematic review. *Journal of Global Health*.
- Naswir, M. (2022). Effectiveness of high-risk pregnancy detection models. *Journal of Client-Centered Nursing Care*.
- Neiger, R. (2017). Long-term effects of pregnancy complications on maternal health. *Journal of Clinical Medicine*.
- Nourollahpour Shiadeh, M., Behboodi Moghadam, Z., et al. (2017). Infectious diseases and pregnancy complications. *Infection*.
- Onarheim, K. H., Iversen, J. H., & Bloom, D. E. (2016). Economic benefits of investing in women's health. *PLOS ONE*.
- Prasetyo, B., Winardi, B., Pranadyan, R., & Erlin, H. (2020). Increasing early detection of high-risk pregnancy with proactive intervention in Indonesia.
- Rodrigues, P. B., Zambaldi, C. F., & Cantilino, A. (2016). Special features of high-risk pregnancies. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*.
- Rohimi, U. E., Syafi'i, A., & Rofifah, J. (2024). Community-based health education and maternal outcomes. *Asian Journal of Health Sciences*.
- Ruhdiat, R., Wardani, D. S., & Sihite, H. (2024). Improving maternal outcomes through midwifery care. *The Journal of Obstetrics and Health*.
- Sakali, A. K., Papagianni, M., Bargiota, A., & Rasic-Markovic, A. (2023). Environmental factors affecting pregnancy outcomes. *Endocrine*.
- Symon, A., Pringle, J., Downe, S., & Hundley, V. (2016). Midwifery-led antenatal care models. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Szczepanski, J., Griffin, A., Novotny, S., & Wallace, K. (2020). Pregnancy complications and maternal outcomes. *Frontiers in Medicine*.
- Taqiyya, N., Balindra, F. R., & Sari, D. K. (2025). Midwifery continuity of care and maternal outcomes. *Jurnal Pelita Pengabdian*.

- WHO. (2018). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. World Health Organization.
- WHO. (2020). *Nutritional interventions during pregnancy*. World Health Organization.
- WHO. (2023). *Maternal and reproductive health*. World Health Organization.
- Yeoh, P. L., Hornetz, K., & Dahlui, M. (2016). Antenatal care utilisation among high-risk pregnant women. *PLOS ONE*.
- Yuliwati, Y., & Sulistyaningrum, H. (2025). Role of midwives in community health programs. *Journal of Midwifery and Health Sciences*.
- Ziganshin, A. M., & Nagimova, E. M. (2021). Maternal mortality: Causes and prevention strategies. *Journal of Obstetrics and Women's Diseases*.

Glosarium

Amenore

Tidak terjadinya menstruasi dalam periode tertentu pada perempuan usia reproduksi, baik primer maupun sekunder

Anemia

Kondisi kadar hemoglobin dalam darah di bawah normal yang dapat memengaruhi fungsi tubuh, termasuk kesehatan reproduksi

Endometrium

Lapisan dalam rahim yang mengalami penebalan dan peluruhan selama siklus menstruasi.

Fertilitas

Kemampuan biologis seseorang untuk menghasilkan keturunan melalui proses reproduksi alami

Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti HIV, sifilis, gonore, dan klamidia.

Infertilitas

Ketidakmampuan untuk mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi

Kesehatan Reproduksi

Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya

Kontrasepsi

Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, baik secara sementara maupun permanen.

Menstruasi

Proses peluruhan lapisan endometrium yang disertai perdarahan secara periodik sebagai bagian dari siklus reproduksi perempuan

Ovulasi

Proses pelepasan sel telur matang dari ovarium yang siap untuk dibuahi

Perimenopause

Masa transisi sebelum menopause yang ditandai dengan perubahan siklus menstruasi dan hormon.

Prakonsepsi

Periode sebelum terjadinya kehamilan yang menjadi waktu penting untuk mempersiapkan kesehatan ibu dan janin.

Siklus Menstruasi

Rangkaian perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada sistem reproduksi perempuan, biasanya berlangsung 21–35 hari

Sindrom Premenstruasi (PMS)

Kumpulan gejala fisik dan emosional yang muncul sebelum menstruasi, seperti nyeri, perubahan suasana hati, dan kelelahan.

Usia Subur

Rentang usia perempuan antara 15–49 tahun yang secara biologis memiliki kemampuan untuk bereproduksi

Vagina

Saluran reproduksi perempuan yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh.

BAB 5

PERAN BIDAN DALAM SISTEM RUJUKAN MATERNAL NEONATAL

A. Sistem Rujukan

Rujukan merupakan mekanisme pelimpahan tanggung jawab dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas lainnya. Secara sistematis, sistem rujukan membentuk jaringan layanan kesehatan yang memfasilitasi pelimpahan wewenang secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada pihak yang lebih kompeten, terjangkau, dan rasional dalam menangani permasalahan kesehatan Masyarakat (Susiloningtyas, 2020).

Sistem rujukan kebidanan merupakan mekanisme pelimpahan wewenang dan tanggung jawab klinis, baik secara vertikal (antarjenjang fasilitas kesehatan) maupun horizontal (antardepartemen dalam unit yang sama). Secara lebih luas, sistem rujukan pelayanan kesehatan menjadi standar prosedur yang mewajibkan fasilitas kesehatan serta peserta jaminan kesehatan untuk menjalankan koordinasi alih tugas tersebut demi kesinambungan perawatan (Munthe et al., 2019).

Rujukan terbagi menjadi tiga yakni:

1. Rujukan horizontal

mekanisme alih tanggung jawab antarfasilitas pelayanan kesehatan pada jenjang yang setara. Mekanisme ini diimplementasikan apabila fasilitas perujuk tidak mampu memenuhi kebutuhan klinis pasien akibat keterbatasan fasilitas, peralatan, maupun sumber daya manusia, baik yang bersifat menetap maupun sementara,

2. Rujukan vertikal

Rujukan vertikal melibatkan koordinasi antarfasilitas kesehatan dengan jenjang pelayanan yang berbeda, yang memungkinkan perpindahan pasien dari tingkat fasilitas yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, atau sebaliknya.

3. Rujukan parsial

pengiriman pasien atau spesimen klinis kepada pemberi layanan kesehatan lain guna mendukung penegakan diagnosis maupun pemberian terapi sebagai bagian dari rangkaian prosedur perawatan di fasilitas kesehatan terkait.

Jenis rujukan terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Rujukan Kesehatan

Rujukan kesehatan merupakan elemen krusial dalam upaya preventif dan promotif yang berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem ini melibatkan pengiriman spesimen atau bahan pemeriksaan ke fasilitas yang memiliki kapasitas lebih memadai untuk memastikan akurasi diagnosa. Secara spesifik, rujukan kesehatan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu rujukan teknologi, rujukan sarana, dan rujukan operasional.

2. Rujukan medik

Rujukan medik berkaitan erat dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, sehingga pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (*medical service*). Rujukan medik didefinisikan sebagai pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas suatu kasus, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada pihak yang lebih berwenang dan memiliki kompetensi untuk menanganinya secara rasional. Rujukan medik terbagi menjadi 3 yakni:

- a. Rujukan penderita (*transfer of patient*): Pengiriman atau konsultasi penderita kepada pihak yang lebih ahli untuk keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan operatif, dan sebagainya.
- b. Rujukan spesimen (*transfer of specimen*): Pengiriman bahan pemeriksaan (spesimen) ke fasilitas laboratorium yang lebih lengkap guna mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat.
- c. Rujukan pengetahuan atau tenaga (*transfer of knowledge/personnel*): Pengiriman tenaga ahli ke fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan supervisi atau bimbingan guna meningkatkan mutu pelayanan.

B. Kegawatdaruratan maternal dan neonatal

Kegawatdaruratan obstetri adalah kondisi klinis pada wanita hamil, bersalin, atau nifas yang disebabkan oleh kehamilan atau komplikasinya, yang ditandai oleh gangguan fungsi fisiologis yang mengancam jiwa ibu dan atau janin. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera dan tepat untuk mencegah terjadinya morbiditas berat maupun mortalitas maternal dan perinatal.

Bidan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem deteksi dini kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Melalui implementasi asuhan antenatal yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis bukti (*evidence-based*), bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai manajer risiko. Penguatan kapasitas dalam identifikasi dini faktor risiko serta edukasi tanda bahaya yang masif diharapkan mampu mengeliminasi keterlambatan penanganan

klinis, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap penurunan morbiditas dan mortalitas maternal-neonatal. Berikut merupakan kegawatdaruratan maternal:

Perdarahan

Perdarahan pada kehamilan muda merupakan kondisi perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau ketika berat janin diperkirakan kurang dari 500 gram, yaitu fase dimana janin belum mencapai viabilitas ektrauterin. Kondisi ini mencerminkan adanya gangguan pada proses implantasi, perkembangan gestasi awal, atau integritas jaringan kehamilan, yang dapat mengindikasikan terjadinya abortus imminens, abortus insipiens, maupun bentuk abortus lainnya.

Tabel 3.1
Jenis-jenis abortus

Jenis Abortus	Karakteristik Klinis	Temuan Pemeriksaan Fisik
Abortus Imminens	Perdarahan pervaginam pada usia kehamilan <20 minggu tanpa pembukaan serviks.	Ostium uteri internum (OUI) tertutup; janin masih hidup.
Abortus Insipiens	Perdarahan pervaginam dengan nyeri kram perut bawah yang intens.	OUI terbuka; hasil konsepsi masih di dalam uterus.
Abortus Inkompletus	Pengeluaran sebagian hasil konsepsi.	OUI terbuka; teraba jaringan di dalam kanalis servikalis atau kavum uteri.
Abortus Kompletus	Seluruh hasil konsepsi telah keluar.	OUI tertutup; uterus mengecil; perdarahan berkurang/berhenti.
Abortus Septik	Abortus yang disertai dengan infeksi berat pada kavum uteri.	Demam, sekret vagina purulen/berbau, nyeri tekan uterus.
Abortus Habitualis	Abortus spontan yang terjadi berturut-turut sebanyak >3x	Sesuai kondisi abortus yang terjadi (biasanya bersifat rekuren).
Missed Abortion	Hasil konsepsi meninggal namun tertahan di dalam uterus	Uterus lebih kecil dari usia kehamilan; OUI tertutup; tidak ada denyut jantung janin.

Perdarahan pada kehamilan lanjut dan menjelang persalinan biasanya terjadi karena adanya gangguan pada plasenta, seperti plasenta letak rendah atau plasenta previa, kelainan pada perlekatan tali pusat, adanya pembuluh darah pada selaput ketuban, atau terlepasnya plasenta sebelum bayi lahir. Sedangkan perdarahan setelah persalinan umumnya disebabkan oleh rahim yang tidak berkontraksi dengan baik (atonía uteri) atau adanya robekan pada rahim maupun jalan lahir saat proses persalinan.

Atonia Uteria

Atonia uteri didefinisikan sebagai kegagalan myometrium dalam mempertahankan kontraksi adekuat pascapersalinan, sehingga uterus kehilangan kemampuan kompresi vaskular pada situs implantasi plasenta. Kondisi ini merupakan etiologi primer dari perdarahan pascapersalinan (*Postpartum Hemorrhage*). Implementasi Manajemen Aktif Kala III (MAK III) merupakan protokol klinis yang imperatif untuk mencegah komplikasi tersebut. Pemberian oksitosin secara rutin pada kala III terbukti mampu mereduksi risiko perdarahan pascapersalinan hingga lebih dari 40% serta meminimalisir kebutuhan intervensi terapeutik lanjutan. Secara klinis, MAK III berkontribusi dalam menekan volume perdarahan, mencegah anemia maternal, dan menurunkan kebutuhan transfusi darah (Ghita et al., 2024).

Retensio Plasenta

Retensio plasenta didefinisikan sebagai kondisi dimana plasenta belum lahir dalam durasi lebih dari 30 menit setelah janin lahir. Diagnosis klinis retensio plasenta ditegakkan berdasarkan temuan berupa perdarahan aktif, plasenta yang belum keluar atau lahir tidak lengkap setelah interval waktu tersebut, serta adanya manifestasi klinis syok. Tindakan evakuasi plasenta secara segera merupakan prosedur yang imperatif guna memitigasi risiko komplikasi fatal, seperti perdarahan pascapersalinan (PPH), infeksi nifas, plasenta inkarserata, dan pembentukan polip plasenta. Dalam konteks klinis, prosedur manual plasenta harus dilakukan dengan teknik yang presisi dan mengikuti protokol standar guna meminimalkan risiko trauma jaringan serta komplikasi prosedural lainnya.

Robekan jalan lahir/ robekan perineum

Manifestasi perdarahan pervaginam yang terjadi pasca-ekspulsi plasenta secara lengkap, disertai dengan kondisi miometrium yang berkontraksi adekuat (uterus teraba keras), mengindikasikan bahwa etiologi perdarahan bukan berasal dari disfungsi kontraktilitas uterus maupun retensi jaringan plasenta. Berdasarkan algoritma diagnosis klinis tersebut, maka perdarahan dapat dipastikan bersumber dari trauma jalan lahir (*birth canal trauma*). Sedangkan Laserasi perineum merupakan komplikasi obstetrik dengan prevalensi yang sangat tinggi pada primipara, meskipun tidak jarang terjadi pula pada multipara. Secara anatomis, robekan umumnya terjadi pada garis median perineum. Derajat keparahan laserasi dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika persalinan dan karakteristik morfologi panggul maternal. Laserasi perineum terbagi atas 4 tingkatan:

1. Tingkat I, terdapat robekan pada selaput vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum
2. Tingkat II, robekan pada selaput vagina dan otot perineum tetapi tidak mengenai spingter ani
3. Tingkat III, robekan mengenai seluruh perineum dan otot spingter ani
4. Tingkat IV, terjadio robekan hingga mukosa rectum

Robekan serviks

Serviks uteri merupakan struktur jaringan yang memiliki tingkat vaskularisasi tinggi, sehingga rentan mengalami trauma selama proses persalinan. Laserasi pada area serviks merupakan salah satu penyebab signifikan perdarahan pascapersalinan, terutama apabila robekan meluas hingga ke arah lateral. Risiko ini meningkat secara substansial mengingat kedekatan anatomis serviks dengan *ramus descendens* dari arteri uterina, yang jika mengalami laserasi dapat memicu perdarahan masif dan membahayakan keselamatan ibu. Secara klinis, laserasi serviks tidak hanya terjadi pada persalinan spontan, tetapi lebih sering ditemukan pada persalinan dengan intervensi obstetrik. Tindakan persalinan yang dilakukan sebelum dilatasi serviks mencapai pembukaan lengkap menjadi faktor risiko utama. Selain itu, persalinan presipitatus yang ditandai dengan kontraksi uterus hipertonic yang sangat kuat sering kali memicu dorongan ekspulsi prematur terhadap janin, yang menyebabkan serviks mengalami trauma sebelum benar-benar terdistensi dengan sempurna. Proses penegakan diagnosis laserasi serviks memerlukan ketelitian klinis. Inspeksi visual menggunakan spekulum merupakan standar emas untuk memastikan lokasi dan luas perlukaan. Dalam prosedur ini, bibir serviks difiksasi menggunakan klem atraumatik untuk mempermudah visualisasi. Setelah robekan teridentifikasi, manajemen segera harus dilakukan untuk memastikan hemostasis.

Inversio uteri

Inversio Uteri adalah salah satu komplikasi persalinan ketika bagian dari dinding rahim bagian atas (fundus) terbalik ke arah bawah bahkan terkadang sampai keluar menonjol sampai mulut rahim (serviks) dan ke dalam vagina.

Penarikan yang berlebihan pada tali pusat selama kala III persalinan merupakan tindakan kontraindikasi yang berisiko memicu terjadinya inversio uteri. Oleh karena itu, prinsip utama dalam manajemen kala III adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali (*controlled cord traction*) bukan penarikan guna menjaga integritas anatomis uterus. Secara fisiologis, separasi plasenta dari situs implantasinya terjadi secara spontan dalam rentang waktu rata-rata 10 hingga 15 menit pasca kelahiran janin. Namun, apabila plasenta belum terlepas hingga melampaui durasi 30 menit, maka kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai retensio plasenta. Dalam situasi ini,

intervensi klinis berupa tindakan manual plasenta oleh tenaga medis (dokter atau bidan) menjadi prosedur definitif yang diperlukan untuk melepaskan plasenta dari dinding rahim guna mencegah komplikasi lebih lanjut (Munthe et al., 2019).

Plasenta previa

Plasenta previa merupakan kondisi malposisi plasenta pada segmen bawah rahim yang berpotensi menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Karakteristik klinis utama dari kondisi ini adalah perdarahan pervaginam tanpa nyeri, yang umumnya terjadi pada trimester ketiga (seringkali pada bulan kedelapan). Sejumlah faktor risiko yang berpengaruh meliputi usia maternal lanjut, multiparitas, serta adanya riwayat bedah sesar atau aborsi. Komplikasi klinis yang menyertai kondisi ini cukup serius, mencakup perdarahan antepartum dengan risiko syok, malpresentasi janin (seperti letak lintang atau bokong), serta tingginya kemungkinan persalinan prematu (Prawirohardjo, 2014).

Preeklampsia dan Eklampsia

Preeklampsia/eklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang umumnya terjadi setelah usia gestasi lebih dari 20 minggu, ditandai dengan hipertensi disertai proteinuria sebagai manifestasi gangguan fungsi endotel dan multisistem. Eklampsia merupakan bentuk lanjut dari preeklampsia yang ditandai dengan munculnya kejang, yang tidak disebabkan oleh kelainan neurologis lain. Kondisi ini masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal secara global. Tingginya angka kematian ibu pada kasus ini sering kali berkaitan dengan keterlambatan deteksi dan penatalaksanaan yang tidak adekuat pada tingkat pelayanan primer, sehingga pasien dirujuk dalam kondisi berat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan kebidanan di fasilitas kesehatan dasar sangat penting untuk memperbaiki prognosis maternal dan perinatal.

Kegawatdaruratan neonatal adalah kondisi klinis pada bayi baru lahir (usia ≤ 28 hari) yang ditandai oleh gangguan fungsi fisiologis akut atau penyakit kritis yang berpotensi mengancam kehidupan. Kondisi ini memerlukan identifikasi dini, evaluasi komprehensif, serta penatalaksanaan segera dan tepat, dengan pemahaman yang mendalam mengenai adaptasi fisiologis neonatus serta perubahan patologis yang dapat berkembang secara cepat dan tidak terduga (Utami & Ummah, 2024). Terdapat banyak kondisi yang menyebabkan kegawatdaruratan neonates yaitu hipotermi, hipertemia, hiperglikemia, tetanus neonatorum, penyakit -penyakit pada ibu hamil dan sindrom gawat nafas pada neonatus.

Hipotermia

Hipotermia didefinisikan sebagai kondisi klinis di mana suhu inti tubuh berada di bawah 36°C atau disertai dengan tanda objektif berupa ekstremitas yang terasa dingin. Dalam lingkup pelayanan medis, diagnosis hipotermia memerlukan instrumen pengukuran spesifik, yakni termometer dengan rentang rendah (*low reading thermometer*), guna memastikan akurasi data termoregulasi. Hipotermia bukan sekadar manifestasi simptomatik, melainkan kondisi patologis progresif yang jika tidak segera ditangani, berisiko tinggi menyebabkan mortalitas.

Hipertermia

Hipertermia merupakan kondisi klinis yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh di atas ambang normal akibat kegagalan mekanisme termoregulasi. Secara patofisiologis, kondisi ini terjadi ketika laju produksi atau absorpsi panas internal melampaui kapasitas disipasi panas tubuh. Dalam tingkat lanjut, hipertermia dikategorikan sebagai kegawatdaruratan medis yang memerlukan intervensi segera guna memitigasi risiko morbiditas permanen hingga mortalitas.

Hiperglikemia

Hiperglikemia merupakan kondisi metabolik yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi glukosa dalam plasma darah di atas rentang fisiologis normal. Secara etiologis, kondisi ini berkaitan erat dengan *diabetes mellitus*, sebuah sindrom gangguan metabolisme yang utamanya dipicu oleh defisiensi insulin absolut atau resistensi insulin pada tingkat seluler. Secara patofisiologis, hiperglikemia terjadi akibat kegagalan mekanisme glikogenesis proses konversi glukosa menjadi glikogen yang secara signifikan menurunkan kemampuan tubuh untuk melakukan pembersihan glukosa (*glucose clearance*) dari sirkulasi sistemik. Defisiensi insulin atau penurunan sensitivitas seluler terhadap insulin menyebabkan akumulasi glukosa yang persisten dalam darah, yang pada akhirnya memicu manifestasi klinis hiperglikemia.

Tetanus neonatorum

Tetanus neonatorum merupakan bentuk tetanus yang terjadi pada neonatus, yang diakibatkan oleh invasi eksotoksin *tetanospasmin* yang dihasilkan oleh bakteri anaerob obligat, *Clostridium tetani*. Penyakit ini umumnya masuk melalui pintu gerbang infeksi berupa umbilikus yang terkontaminasi selama proses persalinan yang tidak higienis atau akibat praktik perawatan tali pusat yang tidak memenuhi standar sterilitas.

tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang diderita oleh bayi baru lahir yang disebabkan karena basil *Clostridium tetani*. tanda-tanda klinis antara lain: bayi tiba-tiba panas dan tidak mau minum, mulut mencucu seperti mulut ikan, mudah terangsang, gelisah (kadang-kadang menangis) dan sering kejang disertai sianosis, kaku kuduk sampai opistotonus, ekstremitas terulud dan kaku, dahi berkerut alis mata terangkat, sudut mulut tertarik kebawah, muka risus sardonikus.

Sindrom gawat nafas

Sindrom gawat nafas merupakan kumpulan yang terdiri dari dispnea atau hAsfiksia neonatal diklasifikasikan sebagai kondisi kegagalan adaptasi pernapasan pada bayi baru lahir, yang dimanifestasikan oleh ketidakmampuan untuk memulai serta mempertahankan pola respirasi spontan yang adekuat segera setelah lahir. Secara biokimiawi, kondisi ini ditandai oleh gangguan pertukaran gas yang berujung pada kondisi hipoksemia (penurunan tekanan parsial oksigen/ PaO_2), hiperkarbia (peningkatan tekanan parsial karbon dioksida/ $PaCO_2$), serta asidosis respiratorik dan/atau metabolik yang berkelanjutan. Kejadian asfiksia pada bayi baru lahir tidak terjadi secara berdiri sendiri, melainkan hasil dari rangkaian gangguan yang kompleks. Secara garis besar, masalah ini berakar dari tiga sumber utama: kondisi kesehatan ibu, perkembangan janin itu sendiri, serta kelainan pada plasenta atau ari-ari yang menjadi jalur utama pertukaran nutrisi dan oksigen. Proses terjadinya asfiksia dapat dijelaskan melalui alur yang sederhana. Awalnya, gangguan pada salah satu dari ketiga faktor tersebut ibu, janin, atau plasenta menyebabkan aliran oksigen yang menuju janin berkurang secara drastis, atau yang dalam istilah medis disebut sebagai hipoksia. Kondisi ini sering kali diperparah dengan terhambatnya aliran darah menuju jaringan tubuh janin, atau iskemia. Ketika janin kekurangan pasokan oksigen, tubuhnya akan berusaha melakukan adaptasi dengan mengubah cara kerja organ dan proses kimianya untuk mempertahankan fungsi vital. Namun, mekanisme pertahanan ini memiliki batas kemampuan. Jika kekurangan oksigen tersebut berlangsung dalam durasi yang lama atau intensitas yang terlalu berat, tubuh janin tidak lagi mampu mengompensasi perubahan tersebut. Akibatnya, terjadi kegagalan sistemik yang membuat bayi mengalami kesulitan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah ia lahir. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai kondisi asfiksia neonatal.

C. Rujukan maternal dan neonatal

Permasalahan keterlambatan rujukan (*delayed referral*) merupakan determinan utama tingginya angka mortalitas maternal dan neonatal. Kendala tersebut bersifat multidimensional, mencakup faktor geografis, sosiokultural, serta keterbatasan finansial. Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, Sistem Kesehatan Nasional menegaskan bahwa sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal harus berlandaskan pada prinsip urgensi, akurasi, dan efisiensi, serta wajib selaras dengan kompetensi klinis tenaga kesehatan dan kapasitas sarana pelayanan. Dalam konteks operasional, Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Essensial Dasar (PONED) diwajibkan mengimplementasikan prosedur tetap (*standard operating procedure*) terhadap setiap kasus kegawatdaruratan yang masuk.

Bidan memiliki tanggung jawab profesional untuk menjamin efektivitas sistem rujukan maternal dan neonatal melalui pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Mekanisme rujukan dalam layanan obstetri merupakan bentuk delegasi wewenang dan tanggung jawab profesional yang bersifat resiprokal antar-fasilitas pelayanan kesehatan, yang mencakup koordinasi vertikal maupun horizontal guna memastikan kesinambungan penanganan kasus kebidanan. Kompetensi utama yang harus diimplementasikan oleh bidan meliputi:

1. Deteksi Dini dan Skrining: Melakukan penilaian klinis yang akurat untuk mengidentifikasi komplikasi pada ibu atau bayi yang memerlukan penanganan di tingkat lanjut.
2. Ketepatan Waktu Rujukan (*Timely Referral*): Mengintegrasikan prinsip *the golden hour* dengan merujuk pasien secara sigap sebelum kondisi memburuk, guna mengoptimalkan luaran klinis.
3. Pemilihan Institusi yang Sesuai: Mengarahkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki kapabilitas dan sarana prasarana yang memadai (PONEK) sesuai dengan urgensi kasus yang ditangani.

Rujukan dalam kebidanan dikenal dengan "BAKSO-KUDA" yakni:

B= bidan, memastikan bahwa ibu, bayi, klien yang didampingi oleh professional perawatan kesehatan yang berkualitas yang mampu menangani keadaan darurat selama rujukan.

A= alat, membawa alat dan perbekalan yang diperlukan (harum suntik, infus set, partus set, pengukur tekanan darah, stetoskop, oksigen dll)

K= kendaraan, menyiapkan kendaraan yang sesuai untuk membawa ke tempat rujukan yang memungkinkan pasien untuk melakukan perjalanan dengan cepat dan nyaman kelokasi rujukan

S= surat, surat-surat yang memuat identitas pasien, surat rujukan yang berisikan penyebab rujukan, Tindakan dan obat yang telah diberikan

O= obat-obatan, bawalah obat-obatan yang diperlukan

DA= dana dan darah, menyiapkan dana yang cukup untuk persiapan administrasi dan siapkan kantong darah berdasarkan golongan darah pasien atau calon donor darah dari keluarga untuk mencari kasus potensial yang membutuhkan donor darah.

Pada saat melakukan perencanaan rujukan, terdapat tahapan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien, keluarga/ wali pasien dan beberapa hal harus di komunikasikan antara lain: diagnosis dan tindakan medis yang diperlukan, alasan dilakukan rujukan, risiko yang mungkin timbul selama rujukan, waktu yang tepat untuk merujuk dan durasi yang diperlukan untuk merujuk, nama tenaga kesehatan yang akan mendampingi ibu dan tujuan rujukan.
2. Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan untuk memastikan kesiapan penerimaan pasien. Hal ini mencakup penyampaian informasi mengenai indikasi medis, kondisi terkini ibu dan janin, rencana teknis pengangkutan termasuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan cuaca, kesiapan sarana prasarana di lokasi tujuan, serta tindak lanjut yang telah diberikan sebelum dan selama proses rujukan.
3. Fasilitas kesehatan penerima rujukan wajib mendokumentasikan data pasien secara komprehensif, yang meliputi: identitas pasien, identitas tenaga kesehatan perujuk, alasan rujukan, status klinis ibu dan janin, riwayat pengobatan yang telah diberikan, serta profil tenaga kesehatan pendamping
4. Seluruh data klinis yang relevan wajib didokumentasikan secara sistematis dan terverifikasi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas penerima rujukan selama berlangsungnya komunikasi koordinasi melalui telepon.
5. Kelengkapan dokumentasi medis harus segera dipenuhi dan ditransmisikan melalui jalur komunikasi formal. Dokumen yang diperlukan mencakup formulir rujukan yang komprehensif meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, riwayat terapi, tujuan rujukan, serta otorisasi tenaga Kesehatan disertai dengan salinan rekam medis *antenatal*, data klinis mutakhir, hasil pemeriksaan

penunjang, serta dokumen administratif yang berkaitan dengan tanggung jawab fidusia.

6. Wajib memastikan pemasangan gelang identitas pada pasien rujukan. Selain itu, berdasarkan indikasi klinis, lakukan pemasangan akses intravena dengan ukuran 16G atau 18G
7. Setelah melakukan koordinasi klinis dengan fasilitas kesehatan tujuan, segera inisiasi penatalaksanaan dan pemberian medikamentosa sesuai dengan indikasi medis. Pastikan seluruh prosedur perawatan gawat darurat serta tindakan resusitasi telah diselesaikan secara tuntas sebelum proses transfer pasien dilakukan.
8. Pastikan ketersediaan dan kelengkapan seluruh instrumen penelitian serta perlengkapan logistik perjalanan. Mengingat potensi risiko selama proses transportasi, tim harus memiliki strategi mitigasi yang komprehensif serta kesiapan operasional dalam menghadapi situasi darurat.
9. Dokumentasi temuan klinis harus mencakup otorisasi tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan terakhir, disertai dengan data kronologis yang meliputi tanggal dan waktu pemeriksaan.

Manajemen rujukan kegawatdaruratan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi kader, bidan desa, Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga Puskesmas dilaksanakan melalui serangkaian prosedur sistematis: penapisan (*triage*) kegawatdaruratan, penetapan destinasi rujukan, pemberian informed consent kepada pasien dan keluarga, koordinasi data dengan fasilitas penerima, stabilisasi kondisi pasien, transfer logistik medis, serta evaluasi tindak lanjut guna menjamin kontinuitas pelayanan. Alur rujukan maternal dan neonatal adalah sebagai berikut:

1. Implementasi sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal berlandaskan pada prinsip fundamental yang mengutamakan kecepatan, ketepatan tindakan, efisiensi, serta efektivitas pelayanan, dengan tetap memperhatikan batasan kompetensi dan kewenangan fasilitas kesehatan. Secara prosedural, penatalaksanaan kasus emergensi obstetri dan neonatal yang diterima di unit PONED Puskesmas wajib mengacu pada standar operasional yang ditetapkan dalam panduan nasional kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
2. Setelah tercapainya stabilitas kondisi hemodinamik, langkah strategis berikutnya mencakup penentuan lokasi perawatan definitive apakah dilakukan pada level PONED Puskesmas atau merujuk pasien ke fasilitas PONEK Rumah Sakit untuk tindakan intervensi lebih lanjut
3. Aksesibilitas layanan kebidanan dan neonatal darurat bersifat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Tenaga bidan desa maupun fasilitas Polindes

diberikan kewenangan untuk memberikan asuhan kebidanan langsung kepada ibu hamil, bersalin, dan nifas, baik yang datang atas inisiatif mandiri maupun sebagai hasil rujukan dari kader kesehatan komunitas.

Proses rujukan memerlukan kelengkapan dokumen yang meliputi formulir rujukan pasien yang mencakup identitas ibu, hasil pemeriksaan, diagnosis kerja, terapi, tujuan rujukan, serta identitas petugas fotokopi rekam medis antenatal dan kondisi terkini, hasil pemeriksaan penunjang, serta dokumen pendukung administrasi jaminan kesehatan. Seluruh tindakan medis, mulai dari penatalaksanaan, pemberian obat sesuai indikasi, hingga prosedur resusitasi dan penanganan kegawatdaruratan, wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum pasien dipindahkan, tentunya setelah berkoordinasi dengan pihak fasilitas kesehatan tujuan (Komaya & Ningrum, 2020). Keberhasilan layanan rujukan bergantung pada tiga pilar utama: kompetensi tenaga bidan, kelengkapan sarana prasarana, dan kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar. Mengingat sebagian besar kasus kegawatdaruratan maternal dapat dimitigasi sejak dini di fasilitas pelayanan primer, optimalisasi pelayanan kebidanan esensial menjadi kunci penanganan yang efektif (Wulandari et al., 2026).

D. Penutup

Efektivitas sistem rujukan kebidanan tidak hanya bergantung pada kelengkapan sarana dan prasarana, melainkan juga pada ketepatan waktu pengambilan keputusan dan komunikasi antar-nakes yang efektif. Selain itu, bidan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan skill dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan kebidanan. Pengetahuan yang baik dapat membantu bidan mendiagnosis kasus sehingga cepat dalam mengambil keputusan (merujuk pasien). Ketepatan dalam rujukan merupakan salah satu Upaya dalam menghindari peningkatan AKI dan AKB.

Referensi

- Ghita, D., Yuliandini, A., Layuk, N., Reviana, R., & Dhanio, Y. W. (2024). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Paper Home Indonesia.
- Komaya, S., & Ningrum, W. M. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RUJUKAN OLEH BIDAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI RUJUKAN EFEKTIF SELAMATKAN IBU DAN KELUARGA (SIRESIK) DI RS SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA (SMC) TASIKMALAYA. *Journal of Midwifery and Public Health*, 2(1), 2685–4007.
- Munthe, J., Simbolon, M., Adithya, K. A., & Damanik, L. P. (2019). *Buku Ajar Asuhan kebidanan berkesinambungan*. Trans info media Jakarta. www.transinfotim.blogspot.com
- Prawirohardjo, S. (2014). *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo* (A. B. Saifuddin, T. Rachimhadhi, & G. H. Wiknjosastro, Eds.; Edisi Keem). Pt Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Susiloningtyas, L. (2020). *SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA*. 2(1), 6–16. <https://doi.org/10.53599>
- Utami, W. tri, & Ummah, W. (2024). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal*. Forind.
- Wulandari, E., Busman, A., & Damayanti, U. (2026). Kegawatdaruratan Maternal dalam Perspektif Pelayanan Kebidanan Esensial. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*, 9(1). <https://doi.org/10.56467/jptk.v8i2>

Glosarium

Abortus : pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) dari rahim sebelum janin tersebut mencapai viabilitas (kemampuan hidup) di luar rahim

Hipoksia : hipoksia adalah kondisi kekurangan suplai oksigen yang memadai di jaringan atau sel tubuh. Pada janin dan bayi baru lahir, kondisi ini merupakan salah satu kegawatdaruratan utama yang memerlukan tindakan medis segera.

Iskemia : iskemia adalah kondisi penurunan atau terhentinya suplai darah ke suatu jaringan atau organ tubuh.

MAK : manajemen aktif kala III

Maternal : maternal merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan ibu

Neonatal : neonatal merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan bayi baru lahir (neonatus), yaitu periode kehidupan bayi sejak lahir hingga usia 28 hari.

OUI : Ostium Uteri Internum

Poned : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.

PPH : Perdarahan pascapersalinan

BAB 6

PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KADER KESEHATAN BERBASIS KEBIDANAN KOMUNITAS DALAM UPAYA MENURUNKAN AKI DAN AKB DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan suatu negara. Tingginya AKI dan AKB masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam agenda pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs 2030), Kesehatan menjadi salah satu tujuan utama yang tercantum. Target yang AKI dan AKB yang ditetapkan sebesar <70 per 100.000 KH serta 25 per 1000 KH (SDGs, 2017). Menurut data Kementerian Kesehatan paruh pertama tahun 2024, AKI di Indonesia tercatat mencapai 4.151 kasus dan AKB berada di angka 33.131 kasus. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh SDGs 2030 (Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana, 2024). Angka ini umumnya disebabkan adanya komplikasi dalam siklus hidup perempuan sejak kehamilan hingga masa antara, infeksi serta keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (Hatijar, S.ST. & Irma Suryani Saleh S.ST., M.Kes, Lilis Candra Yanti S.St., 2020). Di sisi lain, kematian bayi sering berkaitan dengan prematuritas, asfiksia, dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adanya kompleksitas faktor penyebab AKI dan AKB dibutuhkan upaya yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada fasilitas kesehatan tetapi juga upaya memberdayakan lintas sektoral seperti masyarakat dan keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Pendekatan kebidanan komunitas menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kesehatan keluarga, khususnya Ibu dan anak. Asuhan kebidanan komunitas merupakan rangkaian pelayanan kebidanan yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative secara terpadu (Runjati, 2020). Dalam praktiknya, keterlibatan keluarga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan ibu hamil, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Keterlibatan tersebut meliputi dukungan emosional, pemenuhan kebutuhan gizi, kesiapsiagaan menghadapi komplikasi, hingga pemanfaatan fasilitas kesehatan yang

tersedia(Zahro et al., 2025). Selain pemberdayaan keluarga, peran kader kesehatan sebagai penggerak elemen masyarakat juga strategis dalam mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Kader kesehatan berfungsi sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang fokus pada kegiatan promotif dan preventif seperti penyuluhan kesehatan, pemantauan ibu hamil, serta pencatatan layanan kesehatan melalui buku KIA dan dokumen kegiatan posyandu. Kader juga menjadi agen perubahan perilaku kesehatan di masyarakat karena kedekatan sosial dan budaya dengan komunitas setempat(Saleh et al., 2024).

Pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan menjadi strategi penting dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Melalui pemberdayaan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan tetapi juga mampu mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan maupun masalah kesehatan bayi. Program pemberdayaan seperti kelas ibu hamil, pelatihan kader, dan kegiatan posyandu terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan keluarga sehingga berkontribusi dalam upaya penurunan AKI dan AKB(Wardayanti et al., 2025).

Pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan merupakan salah satu komponen penting dan utama dalam kebidanan komunitas yang nantinya dapat mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat secara umum diharapkan terwujud sistem dukungan berbasis komunitas yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

B. Konsep Dasar Pemberdayaan dalam Kebidanan Komunitas

Kebidanan komunitas mengutamakan kekuatan dalam memberdayakan komponen pendukung yang ada. Pemberdayaan (empowerment) merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan, termasuk aspek kesehatan. Menurut Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2021, pemberdayaan khususnya dalam kesehatan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat hidup, martabat dan derajat kesehatan dalam hal menjadi lebih mampu dan mandiri agar dapat mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemajuan dalam bidang kesehatan masyarakat(Ambarwati et al., 2021). Definisi serupa juga disebut dalam sebuah jurnal

yaitu pemberdayaan kesehatan masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas derajat kesehatan agar mampu mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatannya. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan yang pernah, sedang atau akan berjalan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan kesehatan tetapi juga sebagai subyek yang berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan personal(Syamsi & Lalla, 2024).

Prinsip utama pemberdayaan kesehatan masyarakat meliputi partisipasi aktif masyarakat, kesetaraan, kemandirian, dan keberlanjutan program. Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan kesehatan. Prinsip kesetaraan menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dengan tenaga kesehatan. Lalu prinsip kemandirian bertujuan membangun kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, serta prinsip keberlanjutan memastikan bahwa program kesehatan dapat terus berjalan dan memberikan dampak jangka panjang bagi komunitas(Ma & Niam, 2024). Sedangkan tujuan utama diterapkannya pemberdayaan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan. Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan memperkuat akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat, serta membangun lingkungan sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan mandiri(Suprpto et al., 2024). Spesifik dalam bidang kesehatan ibu dan anak (KIA), pemberdayaan terutama berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan untuk memahami kebutuhan kesehatan reproduksi, mengambil keputusan terkait kesehatan sendiri, serta berpartisipasi aktif dalam praktik kesehatan keluarga dan komunitas. Salah satu penelitian menunjukkan hasil bahwa rendahnya tingkat pemberdayaan perempuan sering berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal, serta praktik kesehatan keluarga yang kurang optimal(Belay et al., 2025).

Perilaku kesehatan ibu mencakup berbagai tindakan yang dilakukan selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Contoh perilaku tersebut antara lain pemeriksaan antenatal care (ANC), pemenuhan gizi selama kehamilan, persalinan dengan tenaga kesehatan terampil, serta pemanfaatan layanan kesehatan setelah melahirkan. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki hubungan signifikan dengan peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan ibu. Dengan tingkat pemberdayaan yang lebih

tinggi cenderung akan lebih aktif mengambil keputusan terkait kesehatan, khususnya pemeriksaan kehamilan dan pemilihan tenaga kesehatan terampil saat melahirkan. Peningkatan otonomi perempuan ini juga terbukti meningkatkan penggunaan layanan kesehatan maternal(Wulandari & Zoraya, 2020). Studi lain menunjukkan intervensi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan ternyata dapat meningkatkan pemanfaatan layanan Antenatal Care (ANC). Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi berkaitan dengan peningkatan kunjungan ANC dan penggunaan layanan kesehatan selama kehamilan(Suh et al., 2023). Di Bangladesh, perempuan dengan pemberdayaan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan kunjungan ANC minimal empat kali selama kehamilan dibandingkan dengan perempuan dengan tingkat pemberdayaan yang rendah(Winters et al., 2023).

Melalui pemberdayaan kesehatan sangat mungkin merubah model dan pola perilaku keluarga. Mekanisme tersebut dimulai dari adanya peningkatan pengetahuan kesehatan melalui edukasi dan penyuluhan terutama terkait kesehatan ibu dan anak sehingga akan mempengaruhi *self-efficacy* ibu untuk lebih berani mengambil otonomi lebih tinggi dalam keluarga. Peningkatan kepercayaan diri ini menentukan langkah / keputusan yang diambil termasuk pemilihan penggunaan layanan, fasilitas, dan tenaga kesehatan. Keberanian mengambil keputusan akan mempengaruhi intensitas akses ibu terhadap sumber daya yang ada, seperti akses membeli makanan bergizi dan lebih fokus memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga yang terstandar. Peningkatan akses mempengaruhi peningkatan partisipasi ibu dalam komunitas sosial seperti tukar pikiran dalam kegiatan forum pengajian, arisan dan pelatihan dari kader-kader kesehatan. Alhasil, konsistensi alur ini akan mendorong perubahan perilaku kesehatan di masyarakat(Suh et al., 2023).

Secara kuantitatif, penelitian lintas negara di negara dengan pendapatan rendah menengah menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat menurunkan kematian ibu sekitar 7-12% melalui pemanfaatan layanan kesehatan dengan mekanisme perempuan jadi lebih berdaya akan lebih sering melakukan ANC, lebih banyak melahirkan di fasilitas kesehatan, dan lebih cepat mencari pertolongan saat terjadi komplikasi kehamilan. Ketiga faktor ini merupakan determinan utama dalam kematian ibu(Abebe et al., 2025). Dari sisi kematian bayi, *Demographic dan Health Survey (DHS)* di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya pemberdayaan perempuan berkorelasi dengan meningkatnya risiko kematian bayi. Indikator pemberdayaan seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga terutama aspek kesehatan dan kebebasan mobilitas berhubungan dengan penurunan kejadian kematian bayi karena kemampuan akses ibu(Stiyaningsih & Wicaksono, 2017). Pemberdayaan perempuan juga berhubungan dengan perbaikan

status gizi ibu dan penurunan bayi berat lahir rendah (BBLR). BBLR merupakan indikator penting kematian anak karena bayi dengan kondisi ini memiliki risiko kematian neonatal 20-30 kali lebih tinggi(Kabir et al., 2020).

C. Pemberdayaan Keluarga dalam Kesehatan Ibu dan Anak

Keluarga merupakan unit sosial terdekat yang berperan dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan periode neonatal. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung utama yang memengaruhi perilaku kesehatan, pemanfaatan layanan kesehatan, serta pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Dukungan keluarga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan pelayanan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, serta penanganan komplikasi secara lebih cepat dan tepat. Dukungan sosial selama kehamilan termasuk dari pasangan dan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan maternitas serta pengalaman persalinan ibu(Mutawtah et al., 2023). Fungsi keluarga antara lain dukungan emosional, instrumental, informasional, dan sokongan dalam pengambilan keputusan kesehatan. Dalam konteks sosial, suami sering memiliki peran dominan dalam menentukan akses ibu terhadap pelayanan kesehatan, termasuk keputusan untuk melakukan pemeriksaan antenatal atau mencari pertolongan medis saat terjadi komplikasi. Oleh karena itu, keterlibatan pasangan dalam antenatal care terbukti berkaitan peningkatan penggunaan layanan kesehatan maternal, persalinan di fasilitas kesehatan, serta praktik kesehatan bayi baru lahir. Keterlibatan suami dalam hal ini semakin diakui menjadi strategi penting dalam mendukung kesehatan maternal dan neonatal(Paul & Pandey, 2023). Selain suami, anggota keluarga terdekat seperti mertua dan orang tua juga berperan dalam memberikan dukungan. Kehadirannya sebagai pendamping persalinan dapat meningkatkan kenyamanan ibu serta membantu komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi anggota keluarga sebagai pendukung berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang berpusat pada ibu serta pengalaman persalinan yang lebih positif(Nakphong et al., 2024). Dengan demikian, suami dan keluarga dapat disebut sebagai aktor penting dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Selain sebagai aktor fisik, literasi kesehatan keluarga juga merupakan predisposisi penting dalam kesehatan ibu dan anak. Literasi kesehatan keluarga (*family health literacy*) merupakan kemampuan anggota keluarga untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan guna mendukung pengambilan keputusan terkait kesehatan ibu dan bayi. Tingkat literasi kesehatan keluarga menentukan kesiapan keluarga dalam menghadapi kehamilan, persalinan,

serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama periode maternal dan neonatal. Salah satu aspek penting dari ini adalah pengetahuan mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Tanda bahaya seperti perdarahan, kejang, nyeri perut hebat, demam tinggi, atau penurunan gerakan janin merupakan indikator yang memerlukan tindakan medis segera. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi kesehatan keluarga melalui pendidikan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenali tanda bahaya dan mempercepat pencarian pelayanan kesehatan yang tepat. Faktor pengetahuan ini sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan pengambilan keputusan yang pada akhirnya berkontribusi pada risiko morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi(Nakphong et al., 2024).

Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, bidan komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi kesehatan keluarga. Melalui konseling antenatal, kelas ibu hamil, serta integrasi kunjungan rumah, bidan dapat memberikan edukasi mengenai proses kehamilan, tanda bahaya, persiapan persalinan, serta perawatan BBL. Pendekatan edukasi yang melibatkan anggota keluarga terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan keluarga dibandingkan edukasi yang hanya berfokus pada ibu. Selain itu, keterlibatan suami dalam edukasi antenatal juga berkaitan dengan peningkatan dukungan emosional dan psikologis bagi ibu selama kehamilan(Atif et al., 2023).

Selain melakukan pencegahan komplikasi, keluarga harus siap siaga dalam menghadapi komplikasi kehamilan dan persalinan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam program kesehatan maternal adalah konsep *Birth Preparedness and Complication Readiness (BPCR)*. BPCR merupakan strategi yang bertujuan meningkatkan kesiapan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi persalinan serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan dan neonatal. Konsep BPCR menekankan pentingnya perencanaan persalinan secara sistematis oleh keluarga. Persiapan tersebut meliputi pemilihan persalinan, identifikasi tenaga kesehatan yang akan menolong persalinan, serta penentuan fasilitas kesehatan rujukan apabila terjadi komplikasi. Selain itu, keluarga juga dianjurkan merencanakan transportasi menuju fasilitas kesehatan serta menyiapkan biaya / tabungan guna menghindari keterlambatan dalam pelayanan kesehatan. Kesiapsiagaan transportasi dan finansial merupakan faktor penting untuk mengurangi keterlambatan akses. Sebagian besar kasus kematian ibu, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya komplikasi fatal. Oleh karena itu, perencanaan transportasi dan tabungan persalinan menjadi bagian penting dalam

BPCR. Selain itu, identifikasi calon donor darah dari anggota keluarga / komunitas merupakan langkah antisipasi terhadap komplikasi obstetrik(Singh et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik BCPR yang baik berkaitan dengan peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan maternal serta penurunan risiko komplikasi selama persalinan. Dukungan keluarga dalam perencanaan persalinan dan kesiapsiagaan komplikasi memungkinkan ibu memperoleh pertolongan medis secara lebih cepat dan tepat waktu. Salah satunya analisis terhadap 14 studi secara acak dari 307.018 perempuan menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi BPCR berhubungan dengan penurunan mortalitas neonatal sekitar 18-24%. (Soubeiga et al., 2014). BPCR juga membantu mengatasi “three delays model” yaitu keterlambatan mengambil keputusan mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, keterlambatan mendapatkan pelayanan medis(Alamrew et al., 2024).Dengan demikian, integrasi pendekatan keluarga dalam promosi kesehatan, edukasi komunitas, serta program kesiapsiagaan persalinan merupakan strategi penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan

D. Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas

Kader kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan masyarakat yang berfungsi sebagai penghubung antara pelayanan kesehatan formal dan masyarakat. Dalam literature global, kader kesehatan sering disebut sebagai *community health workers (CHWs)* yaitu tenaga kesehatan berbasis komunitas yang dilatih untuk memberikan layanan promotif dan preventif di tingkat rumah tangga dan komunitas. Keberadaan CHWs menjadi strategi penting dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan profesional serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan, khususnya di negara berpendapatan rendah dan menengah. Peran mereka mencakup edukasi kesehatan, pemantauan kesehatan ibu dan bayi, promosi praktik kesehatan yang aman, serta fasilitasi rujukan ke fasilitas kesehatan ketika ditemukan tanda risiko atau komplikasi(Gilmore & Mcauliffe, 2013).

Dalam sistem pelayanan kesehatan primer, kader memiliki posisi strategis sebagai bagian dari jaringan pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Mereka bekerja secara kolaboratif dengan bidan desa dan puskesmas dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk kegiatan posyandu, kunjungan rumah, serta pemantauan kondisi ibu hamil dan bayi baru lahir. Kader sering menjadi aktor pertama yang berinteraksi dengan keluarga dalam mendeteksi masalah kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kader dalam sistem pelayanan kesehatan primer berperan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama di wilayah dengan tenaga kesehatan yang terbatas. Studi menunjukkan

bahwa keterlibatan CHWs dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dapat meningkatkan perilaku pencarian pelayanan kesehatan, praktik menyusui eksklusif, serta penggunaan layanan ANC oleh ibu hamil(Roux et al., 2020).

Hubungan kerja antara kader kesehatan, bidan desa, dan puskesmas bersifat sinergis dan saling melengkapi. Bidan desa berperan sebagai tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan klinis, sedangkan kader berfungsi sebagai perpanjangan tangan pelayanan kesehatan dalam menjangkau masyarakat di tingkat komunitas. Kolaborasi ini memungkinkan pemantauan kesehatan ibu dan bayi secara lebih intensif melalui pendekatan berbasis komunitas. Selain itu, kader kesehatan juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan formal karena mereka berasal dari komunitas yang sama dan memahami konteks sosial budaya setempat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan ibu dan anak.

Penguatan kapasitas kader merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Kader yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat berperan dalam mendeteksi dini segala resiko obstetric serta memfasilitasi proses rujukan apabila ditemukan tanda bahaya. Oleh karena itu, berbagai program kesehatan masyarakat menekankan pentingnya pelatihan kader kesehatan secara berkelanjutan agar mereka mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Pelatihan kader mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan BBL. Selain itu, kader juga dilatih dalam keterampilan komunikasi kesehatan dan pemantauan kesehatan ibu di masyarakat. Dalam praktiknya, salah satu alat yang sering digunakan dalam kegiatan pemantauan kesehatan ibu dan anak adalah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA). Buku ini berfungsi sebagai media pencatatan sekaligus sarana edukasi kesehatan yang memuat informasi penting mengenai kehamilan, persalinan, serta perawatan BBL. Penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dan supervisi yang kuat dapat meningkatkan kapasitas CHWs dalam melakukan deteksi dini risiko kehamilan serta meningkatkan penggunaan layanan kesehatan maternal di masyarakat(Gilmore & McAuliffe, 2013). Selain pelatihan teknis, dukungan sistem kesehatan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program kader kesehatan. Program CHW yang efektif biasanya didukung oleh sistem supervisi yang kuat, pelatihan berkelanjutan, serta integrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Tanpa dukungan tersebut, kemampuan kader dalam menjalankan fungsi promotif dan preventif dapat menjadi terbatas.

Selain berperan dalam pemantauan kesehatan, kader kesehatan juga memiliki fungsi penting sebagai agen perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Kader

berperan dalam menyampaikan informasi kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong adopsi perilaku kesehatan yang lebih baik. Sebagai perwakilan komunitas, kader dianggap sebagai sumber informasi valid yang mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat. Strategi komunikasi perubahan perilaku yang dilakukan oleh kader bisa melalui penyuluhan kesehatan, diskusi kelompok, kunjungan rumah, serta edukasi dalam kegiatan komunitas seperti posyandu / kelas ibu hamil. Pendekatan edukasi berbasis komunitas ini memungkinkan pesan kesehatan disampaikan secara kontekstual dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, meningkatkan penggunaan layanan kesehatan maternal, serta memperbaiki praktik perawatan BBL. Pendekatan *peer-education* juga menjadi strategi penting dalam perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Dalam hal ini, kader berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman antaranggota komunitas. Proses pembelajaran yang bersifat partisipatif ini dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan kesehatan dan memperkuat dukungan sosial dalam praktik kesehatan keluarga (Sharma et al., 2018).

Secara keseluruhan, kader kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak melalui penguatan kegiatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas, tenaga kesehatan yang berkolaborasi dengan kader bisa menjadi perubahan yang efektif dalam meningkatkan perilaku kesehatan masyarakat dan mendukung upaya penurunan AKI dan AKB.

E. Strategi Pemberdayaan Berbasis Komunitas

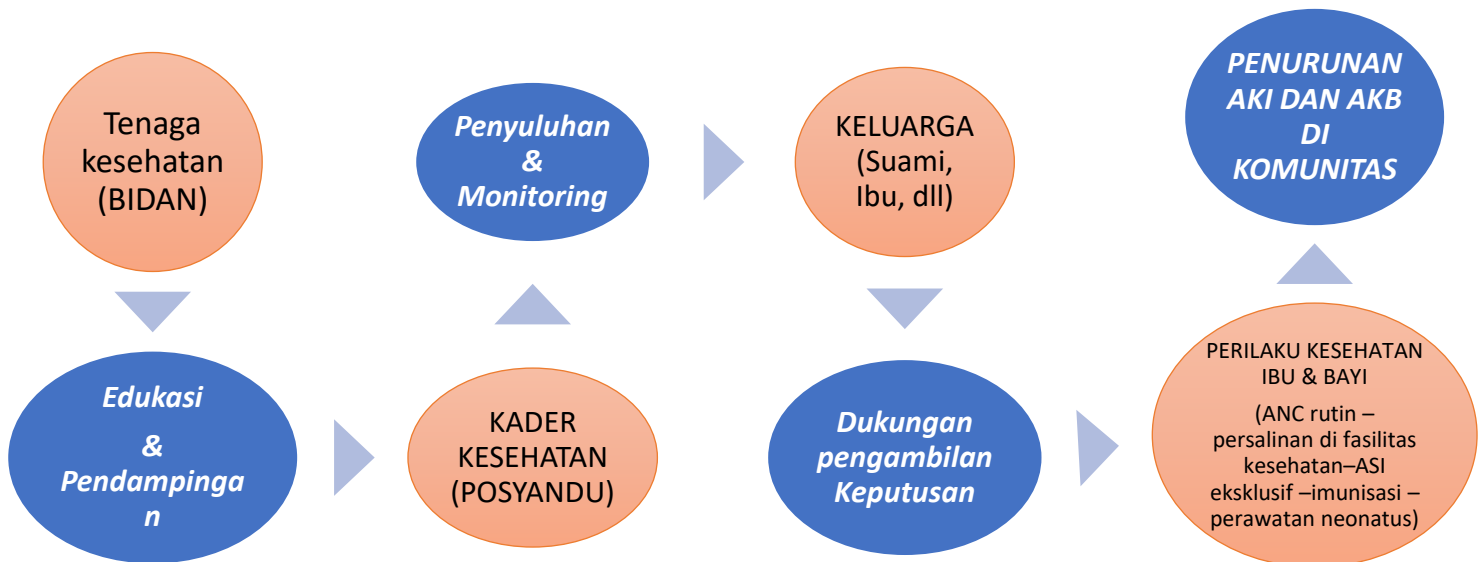
Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas pembangunan kesehatan global karena tingginya risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa antara serta neonatal. Pendekatan kesehatan modern menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program kesehatan. Pendekatan partisipatif dalam program KIA menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan melalui peningkatan aktivitas masyarakat dalam kegiatan-kegiatan komunitas seperti musyawarah masyarakat desa (MMD) serta perencanaan program berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan ini terbukti meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan maternal karena masyarakat merasa program yang dijalankan sehingga memicu keaktifan dalam perilaku kesehatan yang lebih positif. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas melalui kelompok masyarakat dan promotor kesehatan mampu meningkatkan kunjungan

ANC serta penggunaan fasilitas kesehatan saat persalinan (Kassim et al., 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan fondasi penting dalam upaya pemberdayaan kesehatan reproduksi karena mendorong peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak (Faiza et al., 2024).

Optimalisasi posyandu sebagai pusat pemberdayaan keluarga juga merupakan strategi untuk menyokong pelayanan kesehatan primer yang berbasis masyarakat. Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita dan pemeriksaan ibu hamil, tetapi juga pusat edukasi kesehatan keluarga yang berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan, posyandu dapat meningkatkan pengetahuan ibu mengenai gizi, kesehatan reproduksi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Peran kader kesehatan menjadi kunci dalam keberhasilan posyandu, terutama dalam hal bersifat observasi dan skrining. Studi menunjukkan bahwa keberadaan *community health-workers* (Kader) memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal, terutama menjangkau kelompok rentan di komunitas (Gupta & Khan, 2024). Optimalisasi fungsi posyandu juga memungkinkan integrasi pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, sehingga pemantauan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan sejak masa kehamilan hingga periode tumbuh kembang anak.

Selain penguatan sistem pelayanan berbasis komunitas, inovasi program-program pemberdayaan masyarakat juga penting untuk dioptimalisasi sebagai tombak penyokong penurunan AKI dan AKB. Berbagai program yang pernah dan terus dilakukan seperti adanya Desa Siaga, Kampung KB, serta program Suami Siaga menekankan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan keluarga terhadap risiko kehamilan, termasuk dalam pengambilan keputusan, dukungan emosional, serta kesiapan transportasi dan biaya saat terjadi komplikasi persalinan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam penguatan edukasi kesehatan ibu melalui digitalisasi informasi kesehatan dan penggunaan aplikasi pemantauan kehamilan. Implementasi teknologi digital dalam sistem pemantauan kesehatan ibu terbukti mampu meningkatkan pelaporan kasus, pemantauan kondisi ibu hamil, serta komunikasi antara kader kesehatan dan tenaga medis (Septiono et al., 2025). Integrasi teknologi digital dengan sistem kesehatan berbasis komunitas juga dapat meningkatkan efektivitas surveilans kesehatan ibu dan anak serta mempercepat deteksi dini risiko kehamilan.

Melalui upaya-upaya partisipatif dari semua lini terutama pemberdayaan masyarakat di atas, berikut alogaritma yang diharapkan dapat terjadi sinergis dan tersiklus secara kontinyu di masyarakat:



Gambar 4.1
Alogaritma Pemberdayaan Masyarakat oleh Tenaga Kesehatan sebagai Upaya penurunan AKI dan AKB

F. Tantangan dan Hambatan dalam Pemberdayaan Keluarga dan Kader

Pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan merupakan salah satu strategi fundamental dalam penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat, khususnya pada program kesehatan ibu dan anak. Namun, implementasi pendekatan pemberdayaan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, sosial, dan kelembagaan yang kompleks. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga dipengaruhi dinamika sosial budaya masyarakat serta keterbatasan dukungan sistem kesehatan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pemberdayaan keluarga dan kader harus dipahami sebagai proses transformasi sosial yang melibatkan perubahan norma, distribusi kekuasaan dalam keluarga, serta penguatan kapasitas komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan.

Faktor sosial budaya merupakan determinan penting yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan keluarga dalam program kesehatan ibu dan anak. Sebagian besar masyarakat, praktik kesehatan seringkali dipengaruhi oleh

kepercayaan tradisional yang diwariskan secara turun temurun, termasuk persepsi mengenai kehamilan, persalinan, perawatan BBL. Kepercayaan tersebut berperan sebagai sumber dukungan sosial, tetapi juga dapat menjadi hambatan ketika bertentangan dengan praktik kebidanan yang berbasis bukti (*Evidence-based midwifery*). Dalam beberapa komunitas, misalnya penggunaan pengobatan tradisional atau kepercayaan terhadap pantangan kehamilan dapat mengurangi pemanfaatan layanan kesehatan formal. Penelitian menunjukkan bahwa norma budaya dan kepercayaan lokal dapat memengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan maternal serta penerimaan terhadap intervensi kesehatan modern (Sari et al., 2024).

Selain itu, struktur sosial yang bersifat patriarkal turut memengaruhi proses pemberdayaan keluarga, khususnya terkait peran gender dalam pengambilan keputusan kesehatan. Sebagian besar konteks sosial, keputusan terkait perawatan kesehatan ibu masih didominasi oleh suami atau anggota keluarga senior, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dipercaya di wilayah tersebut. Hal ini membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan kesehatan mereka sendiri. Studi terbaru menunjukkan bahwa program pemberdayaan serta menghambat akses terhadap pendidikan kesehatan dan pelatihan kepemimpinan komunitas (Eshikhena et al., 2025). Selain itu, ekspektasi sosial terhadap peran domestik perempuan juga dapat mengurangi kesempatan mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan komunitas. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa norma patriarkal dan distribusi peran gender menjadi salah satu hambatan struktural dalam pemberdayaan perempuan pada program pembangunan kesehatan berbasis komunitas (Dwipayanti et al., 2025). Pengambilan keputusan dalam keluarga juga menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan intervensi. Keputusan terkait kunjungan ANC hingga pemilihan tempat persalinan serta penggunaan layanan kesehatan sering kali bersifat kolektif dan melibatkan berbagai aktor keluarga. Dinamika ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kesehatan tidak dapat hanya berfokus pada individu ibu, tetapi wajib melibatkan seluruh struktur keluarga sebagai unit sosial yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan keluarga perlu mempertimbangkan dimensi budaya, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta konteks sosial yang membentuk perilaku kesehatan masyarakat.

Selain keluarga, kader kesehatan juga merupakan aktor kunci dalam sistem kesehatan berbasis komunitas karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan fasilitas kesehatan formal. Meskipun kontribusi kader terbukti signifikan, berbagai kendala masih menghambat optimalisasi perannya. Salah satunya adalah keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas diri. Banyak

program kader belum menyediakan pelatihan berkelanjutan yang memadai, sehingga kemampuan kader dalam melakukan edukasi kesehatan, deteksi dini risiko, dan pemantauan kesehatan keluarga menjadi terbatas. Kajian sistematis menunjukkan bahwa kualitas pelatihan dan supervisi berkala merupakan faktor penentu utama kinerja kader dalam program kesehatan masyarakat (Care et al., 2024).

Selain aspek kapasitas teknis, motivasi kader juga menjadi isu penting. Sebagian besar kader bekerja secara sukarela dengan insentif yang terbatas, sementara beban kerja mereka terus meningkat seiring dengan perluasan program kesehatan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun banyak kader memiliki motivasi intrinsik yang tinggi karena komitmen sosial terhadap komunitas, kurangnya pengakuan institusional, insentif finansial yang terbatas, serta minimnya dukungan logistic dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan risiko attrition atau pengunduran diri kader (Bibhakar & Sinha, 2025). Hambatan lain yang signifikan adalah lemahnya dukungan sistem kesehatan terhadap kader. Integrasi kader ke dalam sistem pelayanan kesehatan seringkali belum disertai dengan mekanisme supervisi, pendanaan, serta penguatan kebijakan yang memadai. Padahal kader memiliki peran sentra dalam menjangkau populasi yang sulit diakses oleh tenaga kesehatan formal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program kader sangat bergantung pada dukungan struktural seperti sistem supervisi yang kuat, pelatihan berkelanjutan, serta integrasi kader dalam kebijakan kesehatan nasional (Gupta & Khan, 2024). Tanpa dukungan sistem kesehatan yang memadai, potensi kader sebagai agen perubahan dalam komunitas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan menunjukkan bahwa keberhasilan program kesehatan berbasis komunitas tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga pada transformasi sosial dan penguatan sistem kelembagaan. Pendekatan yang sensitive terhadap konteks budaya, penguatan kapasitas kader secara berkelanjutan, serta dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem kesehatan komunitas yang berkelanjutan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

G. Penutup

Pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan merupakan fondasi penting dalam penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Berbagai bukti menunjukkan bahwa keterlibatan aktif komunitas melalui kader kesehatan dan dukungan keluarga mampu meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan maternal, memperluas jangkauan edukasi kesehatan, serta memperkuat deteksi dini risiko kehamilan dan komplikasi persalinan. Program berbasis komunitas yang melibatkan kelompok masyarakat terbukti mampu meningkatkan penggunaan layanan kesehatan ibu, karena pendekatan tersebut membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat kapasitas lokal dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Dalam konteks ini, bidan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pemberdayaan masyarakat. Selain menjalankan fungsi klinis dalam pelayanan antenatal, persalinan, dan perawatan neonatal, bidan juga berperan sebagai fasilitator edukasi kesehatan, pemimpin komunitas, serta penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan kesehatan formal. Peran kepemimpinan bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak memungkinkan terbangunnya kolaborasi yang efektif antara tenaga kesehatan, kader, dan keluarga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Di Indonesia sendiri, bidan menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan maternal dengan cakupan besar dalam pelayanan antenatal dan persalinan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Keberhasilan program kesehatan ibu dan anak juga sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas aktor di tingkat komunitas. Sinergi antara keluarga, kader kesehatan, bidan, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang responsif dan berkelanjutan. Kader kesehatan berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan, sementara keluarga menjadi unit sosial utama yang menentukan perilaku kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Kolaborasi tersebut memperkuat mekanisme rujukan, meningkatkan kepatuhan terhadap pemeriksaan kehamilan, serta mendorong kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi risiko komplikasi obstetri.

Dengan demikian, pemberdayaan komunitas melalui penguatan peran keluarga, kader kesehatan, dan bidan merupakan strategi yang tidak hanya bersifat intervensi jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas sosial masyarakat

secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam sistem kesehatan, sehingga mampu menciptakan ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai risiko kesehatan maternal dan neonatal. Oleh karena itu, penguatan model pemberdayaan komunitas perlu terus dikembangkan sebagai strategi berkelanjutan dalam menurunkan AKI dan AKB di Indonesia, sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan kesehatan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan ibu dan anak.

Referensi

- Abebe, Y., Demissie, A., & Adugna, K. (2025). *The association of women ' s empowerment dimensions and antenatal care utilization in Ethiopia ; facility based cross-sectional study.*
- Alamrew, A., Sisay, A., Ayele, M., Lake, E. S., Kumie, G., & Mossie, H. H. (2024). *Determinants of birth preparedness and complication readiness practice among reproductive-age women in Africa a systematic review and meta-analysis.*
- Ambarwati, E. R., Lusi, N., Nisa, R. M., & Azhari, R. A. (2021). *Community Empowerment in Maternal and Child Health as An Effort to Increase Health Degree AKBIDYO College of Health Sciences.*
- Atif, M., Farooq, M., Shafiq, M., Ayub, G., & Ilyas, M. (2023). The impact of partner ' s behaviour on pregnancy related outcomes and safe child - birth in Pakistan. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05814-z>
- Belay, D. G., Tessema, G. A., Dunne, J., Roy, A., & Norman, R. (2025). *The role of women ' s empowerment in the uptake of maternal health services in low- and middle-income countries: a propensity score-matched analysis.* 15. <https://doi.org/10.7189/jogh.15.04188>
- Bibhakar, P., & Sinha, M. (2025). *Exploring the motivations and barriers affecting community health workers ' performance in the Noida-Greater Noida Region.*
- Care, P., Nida, S., Swasti, A., Tyas, A., Putri, N. E., Larasanti, A., & Widoyopi, A. A. (2024). A systematic review of the types , workload , and supervision mechanism of community health workers: lessons learned for Indonesia. *BMC Primary Care*, 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12875-024-02319-2>
- Dwipayanti, N. M. U., Kurnianingsih, I. D. K. D. S., Mustafa, A., Nastiti, A., Daniel, D., Kowara, M., & Savitri, I. G. A. D. (2025). Socio-ecological barriers to women's empowerment in sanitation in Eastern Indonesia. *Health & Place*, 96, 103554. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2025.103554>
- Eshikhena, G., Ojielo, N., Eche-george, A., Ibe, U., Sabenus, T., Abba, C., Ogenyi, A., Uzoma, S., Obi, C., Akoma, D., Akpabio, O., Amire, A., Oyeh, N., Idigbe, I., & Kaduru, C. (2025). *Exploring gender factors affecting women ' s involvement in public health capacity development programmes in Nigeria.*
- Faiza, N., Tohit, M., Athirah, S., Abd, Z., Farizatul, W., Wan, S., Fakuradzi, A., Adnin, N., Zaidi, A., & Haque, M. (2024). *Exploring Pathways from Community Involvement to Empowerment in Sexual and Reproductive Health : A Public Health Perspective.* 296–307. <https://doi.org/10.4103/aihb.aihb>
- Gilmore, B., & Mcauliffe, E. (2013). *Effectiveness of community health workers*

delivering preventive interventions for maternal and child health in low- and middle-income countries: a systematic review.

- Gupta, A., & Khan, S. (2024). *Importance of Community Health Workers for Maternal Health Care Management*. 45(February), 1–11. <https://doi.org/10.3389/phrs.2024.1606803>
- Hatijar, S.ST., M. K., & Irma Suryani Saleh S.ST., M.Kes, Lilis Candra Yanti S.St., M. K. (2020). Buku ajar asuhan kebidanan pada kehamilan. In *PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo*.
- Kabir, A., Rashid, M., Hossain, K., Khan, A., & Sikder, S. S. (2020). *Women ' s empowerment is associated with maternal nutrition and low birth weight: evidence from Bangladesh Demographic Health Survey*. 1–12.
- Kassim, A. B., Newton, S. K., Dornechele, W., Rahinatu, B. B., Yanbom, C. T., Yankson, I. K., & Otupiri, E. (2023). *Effects of a community-level intervention on maternal health care utilization in a resource-poor setting of Northern Ghana*. 1–12.
- Ma, N., & Niam, M. M. (2024). *Model Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui Taman Gizi Hismawati Perguruan Islam Mathali ' ul Falah Kajen Margoyoso Pati*. 2(2), 257–278.
- Mutawtah, M. Al, Campbell, E., Kubis, H. P., & Erjavec, M. (2023). Women ' s experiences of social support during pregnancy: a qualitative systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-06089-0>
- Nakphong, M. K., Afulani, P. A., Beltrán-sánchez, H., Opot, J., & Sudhinaraset, M. (2024). *Integrating support persons into maternity care and associations with quality of care: a postpartum survey of mothers and support persons in Kenya*. 1–11.
- Paul, P. L., & Pandey, S. (2023). *An examination of the factors associated with male partner attendance in antenatal care in India*. 8, 1–10.
- Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana, D. (2024). *Angka Kematian Ibu dan Bayi*. <https://lms.kemkes.go.id/courses/4aa21d4b-db2c-4f07-8e51-f9a3bf3ba947>
- Roux, K. W., Almirol, E., Rezvan, P. H., Roux, I. M., Mbewu, N., Dippenaar, E., Stansertkatzen, L., Baker, V., & Tomlinson, M. (2020). *Community health workers impact on maternal and child health outcomes in rural South Africa – a non-randomized two- group comparison study*. 1–14.
- Runjati. (2020). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. EGC.
- Saleh, U. K. S., Kiah, F. K., & Mau, B. S. B. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kader Peduli CoC untuk Kesehatan Ibu Hamil*. 2(1), 25–30.
- Sari, Y., Fitriana, S., Hajrah, W. O., & Hartati, G. A. (2024). *Analysis of Socio-Cultural*

Factors in the Decision Making of Women of Childbearing Age Regarding Reproductive and Sexual Health. 6(3), 151–159.
<https://doi.org/10.33860/jbc.v6i3.3306>

SDGs. (2017). *Sustainable Development Goals*. www.sdg2030indonesia.org

Septiono, W., Siagian, F. P., Lazuardi, L., Handayani, S., & Prasetyo, S. (2025). Lessons of practices of community-based maternal and child health surveillance system during and post COVID-19 in Indonesia. *Global Health Action*, 18(1), 2547438. <https://doi.org/10.1080/16549716.2025.2547438>

Sharma, B. B., Jones, L., Loxton, D. J., Booth, D., & Smith, R. (2018). *Systematic review of community participation interventions to improve maternal health outcomes in rural South Asia*. 1–16.

Singh, T., Tripathy, B., Pandey, A. K., Gautam, D., & Mishra, S. S. (2024). *Examining birth preparedness and complication readiness: a systematic review and meta-analysis of pregnant and recently delivered women in India*. 1–12.

Soubeiga, D., Gauvin, L., Hatem, M. A., & Johri, M. (2014). *Birth Preparedness and Complication Readiness (BPCR) interventions to reduce maternal and neonatal mortality in developing countries: systematic review and meta-analysis*. 1–11.

Stiyaningsih, H., & Wicaksono, F. (2017). *Impact of Women 's Empowerment on Infant Mortality in Impact of Women 's Empowerment on Infant Mortality in Dampak Pemberdayaan Perempuan pada Kematian Bayi di Indonesia*. 11(4), 185–191. <https://doi.org/10.21109/kesmas>.

Suh, H., Kalai, S., Trivedi, N., Underwood, C., & Hendrickson, Z. M. (2023). Effects of women's economic empowerment interventions on antenatal care outcomes: a systematic review. *BMJ Open*, 13(3), e061693. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061693>

Suprpto, S., Arda, D., Menga, M. K., & Situmeang, L. (2024). *Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menuju kesehatan yang berkualitas*. 1, 49–55. <https://doi.org/10.61099/jpmei.v1i2.40>

Syamsi, N., & Lalla, N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia (JPMEI)*, 1, 9–14.

Wardayanti, B. A., Rhamadianto, M. I., Hapsari, H. A., Surya, R., Pratama, P., Nurrohman, M. Z., Kunci, K., Hamil, I., & Woman, P. (2025). *Peningkatan Pengetahuan Perawatan Pasca Melahirkan melalui Pemberdayaan Kelas Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Bambanglipuro*. 10(11), 2354–2360.

Winters, S., Pitchik, H. O., Akter, F., Yeasmin, F., Jahir, T., & Huda, T. N. (2023). How does women 's empowerment relate to antenatal care attendance? A cross - sectional analysis among rural women in Bangladesh. *BMC Pregnancy and*

Childbirth, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05737-9>

Wulandari, M. D., & Zoraya, E. (2020). *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 16(3).

Zahro, F. F., Sari, Z. L., & Christiani, N. (2025). *Pemberdayaan Remaja , Ibu Hamil dan Balita Melalui Asuhan Kebidanan Komunitas sebagai Upaya Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat*. 4(2), 2302–2315.

Glosarium

A

AKB: Angka Kematian Bayi adalah Jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu yang digunakan sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat

AKI: Angka Kematian Ibu adalah Jumlah kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan akibat sebab yang berkaitan dengan kehamilan atau penanganannya per 100.000 kelahiran hidup.

B

Bidan Komunitas: adalah Tenaga kesehatan kebidanan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat masyarakat dengan melibatkan keluarga dan komunitas.

D

Deteksi Dini Risiko Kehamilan: adalah Upaya identifikasi secara awal terhadap faktor risiko atau komplikasi pada ibu hamil melalui pemeriksaan kesehatan dan pemantauan rutin untuk mencegah terjadinya komplikasi yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi.

K

Kader Kesehatan: adalah Anggota masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dan bekerja secara sukarela untuk membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, terutama dalam kegiatan promotif dan preventif di tingkat komunitas.

Kebidanan Komunitas: adalah Bidang praktik kebidanan yang berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga, komunitas, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan.

P

Pemberdayaan Keluarga: adalah Proses meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian keluarga dalam menjaga serta mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan ibu, bayi, dan anak

BAB 7

MODEL INTERVENSI KEBIDANAN KOMUNITAS BERBASIS LOKAL

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas utama kesehatan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang di mana angka kematian dan kesakitan ibu masih tinggi. Meskipun kehamilan merupakan proses fisiologis tetapi dapat disertai komplikasi yang dapat membahayakan nyawa ibu dan janin jika tidak terdeteksi sejak dini (Adnani et al., 2025). Secara global, sekitar 295.000 kematian ibu terjadi setiap tahun, dengan sebagian besar disebabkan oleh kondisi yang dapat dicegah seperti perdarahan, gangguan hipertensi, infeksi, dan aborsi yang tidak aman (Zakar et al., 2025). Di Indonesia, angka kematian ibu tetap menjadi perhatian yang signifikan dan terkait erat dengan keterlambatan dalam mengenali tanda-tanda bahaya, mengakses layanan kesehatan, dan menerima perawatan yang tepat. Kondisi ini mencerminkan tren yang terus berlanjut dalam tantangan kesehatan ibu meskipun ada upaya kebijakan yang berkelanjutan (Duhita et al., 2023).

Salah satu strategi utama untuk mengurangi angka kematian ibu adalah meningkatkan pengetahuan dan kesiapan ibu dalam mengidentifikasi tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Tanda-tanda bahaya seperti perdarahan vagina, sakit kepala parah, penglihatan kabur, sakit perut, dan berkurangnya gerakan janin memerlukan perhatian medis segera. Pengenalan dini tanda-tanda ini dapat secara signifikan mengurangi risiko komplikasi dan kematian ibu (Yuriah et al., 2023). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan di kalangan ibu hamil dan keluarga mengenai tanda-tanda bahaya ini masih kurang memadai, terutama di lingkungan masyarakat. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terus-menerus antara kebijakan kesehatan ibu dan implementasi di tingkat masyarakat, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas (Yuriah & Zahra, 2024).

Selain komplikasi terkait kehamilan, praktik pemberian makan bayi yang suboptimal juga berkontribusi pada hasil kesehatan ibu dan anak yang buruk. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan merupakan intervensi yang sangat efektif untuk meningkatkan kelangsungan hidup anak, mengurangi angka infeksi, dan mencegah kekurangan gizi dan stunting (Maisaroh & Sartika, 2025). Meskipun manfaatnya telah terdokumentasi dengan baik,

prevalensi pemberian ASI eksklusif secara global masih di bawah target yang direkomendasikan, dengan hanya sekitar 40% bayi yang menerima ASI eksklusif. Di Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan cakupan pemberian ASI, angkanya masih tidak konsisten dan belum mencapai target nasional (Muthoharoh et al., 2022). Tren ini menyoroti perlunya intervensi berbasis komunitas yang lebih efektif dan praktis yang membahas aspek pengetahuan dan perilaku (Munthe et al., 2025).

Model intervensi kebidanan komunitas diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan memberdayakan individu dan keluarga untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan mereka. Intervensi terpadu yang menggabungkan pendidikan, deteksi dini, dan partisipasi masyarakat telah terbukti secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan dibandingkan dengan intervensi komponen tunggal (Rozifa et al., 2023).

Pelayanan kebidanan berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini (Shikuku et al., 2020b). Model ini menekankan partisipasi aktif masyarakat, peran kader kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor dalam menyediakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek klinis tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Buku ini berkontribusi pada bidang kebidanan komunitas dengan menyediakan model intervensi terintegrasi yang menggabungkan komponen pendidikan, perilaku, dan psikososial. Oleh karena itu, program keterlibatan komunitas ini bertujuan untuk mengimplementasikan model intervensi kebidanan berbasis komunitas terintegrasi.

B. Kawal Bumil Kawal Masa Depan: Sinergi Lintas Sektor Untuk Kesehatan Ibu Anak

Pembangunan kesehatan adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat, dengan tujuan mencapai standar kesehatan masyarakat setinggi mungkin. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu (AKI) Indonesia mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi adalah 16,85 per 1.000 kelahiran hidup (Simatupang et al., 2026).

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang bertujuan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB. Memastikan keberlanjutan program KIA membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan partisipasi yang kuat lintas sektor melalui model pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan media. Sebagai organisasi masyarakat sipil, Rumah Zakat, PKBI DKI Jakarta, dan UNFPA berkomitmen untuk secara aktif berperan sebagai mitra

strategis pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Kolaborasi ini menghasilkan terciptanya program Kawal Ibu Hamil (Kawal Bumil), yang diimplementasikan sepanjang tahun 2025 (Zakar et al., 2025).

Program Kawal Bumil berfokus pada edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil, pasangan usia subur (PUS), calon pengantin (catin), dan remaja, dengan tujuan membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi sejak dini. Melalui edukasi berkelanjutan, diharapkan ibu-ibu di Indonesia dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang bebas stunting.

Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem kesehatan ibu dan anak yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Program Kawal Bumil diharapkan menjadi model pemberdayaan yang bisa direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Kawal Bumil adalah model intervensi yang memberikan pendampingan kesehatan bagi ibu hamil berdasarkan prinsip ekonomi Islam (pembiayaan Islam) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini menerima dukungan pendanaan katalitik dari UNFPA melalui Fasilitas Investasi Strategis (SIF), bekerja sama dengan Rumah Zakat dan PKBI DKI Jakarta sebagai mitra pelaksana. Dirancang sebagai proyek percontohan, Kawal Bumil mengintegrasikan pemantauan berbasis komunitas yang erat dengan penggunaan dana zakat sebagai alternatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk program kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Melalui pendekatan ini, program ini bertujuan untuk mengembangkan model yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan tetapi juga berkelanjutan secara finansial dan dapat direplikasi di wilayah lain (Shikuku et al., 2020a).

Komponen Utama Program Kawal Bumil Pendampingan & Kunjungan Rumah antara lain kader kesehatan melakukan kunjungan langsung untuk memantau kesehatan bumil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seperti dapur gizi bersama menyediakan nutrisi tambahan, Edukasi Gizi dan Kesehatan dengan melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan, nifas, dan ASI Eksklusif, serta penguatan akses layanan seperti memastikan ibu hamil mendapat akses layanan kesehatan yang terjangkau (Wahyuni, 2025).

Program ini difokuskan di beberapa wilayah dengan melibatkan tenaga kesehatan dan kader, serta bertujuan mendukung pencapaian SDGs serta RPJMN 2025–2029.

C. Model Berbasis Masyarakat

Model berbasis masyarakat dilakukan dengan melibatkan petugas kesehatan (bidan), keluarga, kader dan masyarakat. Semua elemen yang berperan perlu mendapatkan pelatihan untuk lebih memahami konsep dan peran dalam mengimplementasikan model ini. Selain itu, pelatihan juga diberikan untuk menyamakan tujuan bersama, yaitu pembentukan perilaku pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan yang pada akhirnya dapat mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan. Keterlibatan kader dan masyarakat dalam model ini sangat tepat. Berdasarkan hasil tinjauan sistematis, kader terbukti mampu menyampaikan pesan intervensi untuk mencegah masalah kesehatan ibu dan anak di negara berkembang dan negara miskin. Karena kader mampu menyampaikan pesan langsung kepada sasaran, yaitu ibu, dengan menggunakan pendekatan budaya dan adat yang berlaku di masyarakat (Puriastuti et al., 2025).

Keberhasilan model berbasis masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan hasil yang sangat baik dalam upaya mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan khususnya, serta meningkatkan pembangunan kesehatan desa secara umum (Puriastuti et al., 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan merupakan kontribusi masyarakat terhadap kesehatan anggota masyarakat melalui pemberian tanggung jawab terkait isu-isu tertentu. Tentu saja, tanggung jawab ini juga fleksibel sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayah. Dalam beberapa kondisi, terkadang masyarakat hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, seperti membuat kondisi di masyarakat yang mampu mendukung pelaksanaan program kesehatan. Namun, dalam kondisi lain, selain melaksanakan tanggung jawab sosial, masyarakat juga melaksanakan tanggung jawab teknis (Wahyuni, 2025). Secara umum, realisasi tanggung jawab yang dilakukan masyarakat terhadap kondisi kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Mengadopsi perilaku untuk mencegah masalah kesehatan;
2. Partisipasi efektif dalam kegiatan pengendalian penyakit;
3. Berkontribusi pada perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan;
4. Menyediakan sumber daya kesehatan.

Dalam upaya mengurangi risiko komplikasi yang dapat menyebabkan kematian ibu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan cakupan program. Partisipasi dapat berupa keterlibatan masyarakat dan kehadiran selama promosi kesehatan, sehingga ketika partisipasi meningkat, informasi/pengetahuan yang

disampaikan dalam program tersebut dapat tersampaikan kepada lebih banyak sasaran. Partisipasi masyarakat juga berarti bahwa masyarakat mendapatkan pembelajaran tambahan tentang isu-isu yang sedang dikerjakan dan pada saat yang sama mengambil tindakan konkret. Dengan menghadiri pertemuan bulanan, masyarakat akan memperoleh pengetahuan tentang cara mengenali komplikasi kehamilan, pemeriksaan ANC dan akses ke fasilitas kesehatan dalam menghadapi komplikasi persalinan.

D. Kelas Ayah Siaga

Program Ayah Siaga adalah kebijakan nasional yang mendukung peningkatan peran ayah dalam kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi dan keluarga, program ini menekankan keterlibatan ayah dalam kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Analisis ini merangkum hasil penelitian selama lima tahun terakhir yang meninjau model implementasi, hasil evaluasi, hambatan, dan faktor pendukung (fasilitator) untuk program Kelas Ayah Siaga di Indonesia (Wahyuni, 2025).

1. Model Implementasi Program Ayah Siaga

Model implementasi Program Ayah Siaga di Indonesia bervariasi sesuai konteks regional, tetapi umumnya didasarkan pada pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Model implementasi yang paling umum adalah "Kelas Ayah Siaga" sebagai turunan dari kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan Indonesia. Beberapa studi, menunjukkan bahwa model ini melibatkan pendidikan ayah melalui kelas tatap muka, media digital, dan buku-buku pendidikan. Integrasi antara petugas kesehatan, kader, dan pemimpin masyarakat merupakan strategi implementasi utama. Lebih lanjut, inovasi hibrida (kombinasi daring dan luring) telah diimplementasikan sejak pandemi untuk menjangkau daerah terpencil.

2. Hasil Evaluasi Implementasi Program

Evaluasi implementasi Program Ayah Siaga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan sikap ayah mengenai perawatan ibu dan bayi. Keterlibatan ayah berdampak positif pada pencegahan stunting melalui peningkatan pengetahuan gizi dan dukungan emosional bagi ibu.

Pelatihan Ayah Siaga meningkatkan kesiapan ayah untuk menanggapi tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, studi di beberapa pusat kesehatan (Putra, 2023; Sulastri, 2025) menunjukkan peningkatan kehadiran ayah pada kunjungan ANC dan persalinan. Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan ketidaksetaraan dalam implementasi di daerah terpencil karena keterbatasan personel pelatihan dan dukungan logistik.

3. Hambatan Implementasi

Hambatan utama dalam mengimplementasikan Program Ayah Siaga meliputi faktor budaya, struktural, dan sumber daya manusia. Norma sosial yang masih menempatkan tanggung jawab kehamilan pada perempuan merupakan hambatan bagi partisipasi ayah. Selain itu, kurangnya dukungan kebijakan regional dan pelatihan yang tidak memadai bagi petugas kesehatan tentang strategi komunikasi dengan ayah juga menghambat efektivitas program. Hambatan logistik seperti keterbatasan dana, fasilitas pelatihan, dan media pendidikan digital juga menjadi kendala di beberapa daerah. Sebuah studi menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara jadwal kerja ayah dan jadwal kelas merupakan tantangan signifikan bagi keberlanjutan program (Yudhia Fratidhina et al., 2021).

4. Fasilitator Implementasi Program Ayah Siaga

Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada dukungan lintas sektor, motivasi keluarga, dan kebijakan kesehatan inklusif. Fasilitator utama meliputi kehadiran tenaga kesehatan terlatih, dukungan pemerintah daerah, dan keterlibatan kader masyarakat dan pemimpin agama.

Pendekatan berbasis masyarakat juga meningkatkan keberlanjutan program melalui rasa kepemilikan lokal. Inovasi media pendidikan seperti video animasi, modul digital, dan e-booklet Ayah Siaga yang dikembangkan pada tahun 2023–2025 telah terbukti efektif dalam meningkatkan jangkauan pendidikan. Mengintegrasikan Program Ayah Siaga dengan program nasional seperti Gerakan 1000 HPK dan Pencegahan Stunting memperkuat dasar kebijakan dan memperluas dampaknya pada kesehatan keluarga.

E. Pelayanan Kebidanan Berbasis Komunitas (PKBK)

Pelayanan Kebidanan Berbasis Komunitas (*Community-Based Midwifery Care/CBMC*) merujuk pada penyediaan layanan kebidanan oleh bidan yang tinggal dan bekerja di komunitas mereka, atau yang secara teratur mengunjungi dan melayani komunitas tersebut. Layanan ini meluas melampaui fasilitas kesehatan formal dan sering dilakukan di rumah pasien, pos kesehatan terpadu (Posyandu), atau pusat kesehatan komunitas kecil (Awaliyah & Yuriah, 2024).

Cakupan Layanan CBMC:

1. Pra-kehamilan: Konseling nutrisi, imunisasi, perencanaan kehamilan, pemeriksaan kesehatan.
2. Perawatan Antenatal (*Antenatal Care/ANC*): Pemeriksaan kehamilan rutin, deteksi dini risiko, pendidikan kesehatan kehamilan, dan persiapan persalinan.

3. Perawatan Intranatal (*Intranatal Care/INC*): Bantuan persalinan normal, penanganan dini komplikasi, dan rujukan tepat waktu.
4. Perawatan Pascanatal (*Postnatal Care/PNC*): Perawatan ibu pascapersalinan, dukungan menyusui, perawatan bayi baru lahir, dan nasihat perencanaan keluarga.
5. Kesehatan Reproduksi: Pemeriksaan kanker serviks, pendidikan kesehatan reproduksi remaja, dan penanganan infeksi menular seksual.
6. Peningkatan Aksesibilitas: Mendekatkan layanan kepada masyarakat, mengatasi hambatan geografis dan sosial ekonomi, terutama untuk populasi rentan (UNFPA, 2014).
7. Peningkatan Kualitas dan Kontinuitas Perawatan: Bidan komunitas membangun hubungan yang saling percaya dengan keluarga, memungkinkan perawatan holistik dan berkelanjutan sepanjang siklus hidup seorang wanita.
8. Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Bidan memimpin pendidikan kesehatan, mempromosikan praktik sehat, dan mendeteksi masalah kesehatan sebelum menjadi parah.
9. Efektivitas Biaya: Layanan berbasis komunitas seringkali lebih hemat biaya daripada perawatan rumah sakit, dengan hasil kesehatan yang sebanding atau lebih baik.

Tantangan dalam Mengintegrasikan PKBK antara lain:

1. Ketersediaan dan Distribusi Bidan: Terdapat kekurangan bidan, terutama di daerah pedesaan, dan distribusinya tidak merata.
2. Dukungan Sistematis: Kurangnya sistem rujukan yang kuat, dukungan logistik (misalnya, transportasi, pasokan obat), dan supervisi klinis untuk bidan di masyarakat.
3. Remunerasi dan Kondisi Kerja: Gaji rendah, beban kerja tinggi, dan jaminan sosial dapat mengurangi motivasi bidan.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Terdapat kesenjangan dalam kurikulum pendidikan kebidanan yang kurang berfokus pada aspek komunitas dan manajemen program kesehatan.
5. Koordinasi Antar Tingkat Layanan: Kurangnya koordinasi yang efektif antara layanan komunitas dan fasilitas kesehatan primer atau sekunder.
6. Sistem Informasi Kesehatan: Sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak memadai menghambat pemantauan dan evaluasi kinerja.

Untuk mengatasi tantangan di atas, beberapa strategi utama diperlukan (Rozifa et al., 2023):

1. Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Bidan: Meninjau pendidikan berkualitas, berfokus pada kompetensi komunitas, dan menyediakan peluang untuk pengembangan profesional berkelanjutan.
2. Meningkatkan Kondisi Kerja dan Insentif: Memberikan gaji, tunjangan, dan lingkungan kerja yang mendukung untuk menarik dan mempertahankan bidan di komunitas.
3. Penguatan Sistem Rujukan: Membangun mekanisme rujukan yang jelas dan cepat yang didukung oleh transportasi dan komunikasi yang efektif antara komunitas dan fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi.
4. Dukungan Klinis dan Manajerial: Memberikan supervisi rutin, dukungan teknis, dan kesempatan konsultasi bagi bidan komunitas.
5. Sistem Informasi Kesehatan Terpadu: Membangun sistem pencatatan dan pelaporan yang efisien untuk mengintegrasikan indikator kesehatan, kinerja bidan, dan perencanaan program.
6. Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan.
7. Kebijakan yang Mendukung: Mempromosikan kebijakan nasional yang mengakui dan mendukung peran bidan komunitas sebagai bagian integral dari Layanan Kebidanan Komunitas, termasuk peraturan praktik dan standar layanan.
8. Kolaborasi Multisektoral: Berkolaborasi dengan sektor lain (pendidikan, sanitasi, transportasi) untuk mengatasi determinan sosial kesehatan.

F. Digitalisasi Layanan Kebidanan Komunitas

Peran Teknologi Digital dalam Kebidanan

Digitalisasi telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, termasuk praktik kebidanan komunitas. Teknologi digital memungkinkan bidan untuk menjangkau lebih banyak individu, terutama di daerah terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Dengan memanfaatkan telemedisin, bidan dapat memberikan konsultasi jarak jauh, memantau kesehatan ibu hamil, dan mendidik masyarakat tanpa batasan geografis (Shikuku et al., 2020b).

Penggunaan teknologi digital juga memfasilitasi pengumpulan dan analisis data kesehatan. Sistem informasi kesehatan berbasis digital memungkinkan bidan untuk merekam, menyimpan, dan memantau data pasien secara real-time, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Dalam konteks komunitas, data ini dapat digunakan untuk merancang program kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Aplikasi Digital untuk Layanan Kebidanan

Beberapa aplikasi digital telah dikembangkan untuk mendukung layanan kebidanan komunitas. Telemedisin, sebuah inovasi kunci, memungkinkan bidan untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, termasuk konsultasi prenatal dan tindak lanjut postnatal. Sistem ini sangat membantu dalam situasi darurat atau untuk komunitas yang sulit dijangkau. Selain itu, aplikasi seluler untuk memantau kesehatan ibu telah menjadi alat penting dalam praktik kebidanan.

G. Desa Siaga

1. Definisi Desa Siaga

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki sumber daya, kemampuan, dan kemauan untuk secara mandiri mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan keadaan darurat kesehatan. Desa yang dimaksud di sini dapat berupa kecamatan atau istilah lain untuk unit komunitas hukum dengan batas-batas yang ditentukan, yang berwenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SI = SIAP, yang berarti pengumpulan data dan pemantauan semua ibu hamil, kesiapan untuk mendampingi ibu dan pendonor darah, kesiapan untuk memberikan bantuan kendaraan untuk rujukan, kesiapan untuk membantu pendirian, dan bidan kecamatan selalu siap memberikan pelayanan. A = ANTAR, yang berarti penduduk desa, bidan kecamatan, dan komponen lainnya dengan cepat dan sigap mendampingi dan mengangkut ibu yang akan melahirkan jika diperlukan tindakan darurat. GA = JAGA, yang berarti melindungi ibu selama dan setelah melahirkan serta menjaga kesehatan bayi baru lahir. Warga dapat mengembangkan UKBM (Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas) dan menerapkan pengawasan berbasis komunitas (termasuk pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku), penanganan keadaan darurat kesehatan dan bencana, serta sanitasi lingkungan di mana komunitas menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Simatupang et al., 2026).

2. Tujuan Desa Waspada

a. Tujuan umum

Untuk menciptakan komunitas desa yang sehat yang peduli dan responsif terhadap masalah kesehatan di wilayahnya.

b. Tujuan khusus

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran di kalangan masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan.
- 2) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan di kalangan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menyebabkan masalah kesehatan (bencana, epidemi, keadaan darurat, dan lainnya)
- 3) Meningkatkan jumlah keluarga yang sadar akan gizi dan yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 4) Meningkatkan kesehatan lingkungan di desa-desa.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan keinginan masyarakat desa untuk membantu diri mereka sendiri di sektor kesehatan.

Komponen yang Terlibat

- 1) Bidan di desa
- 2) Fasilitator masyarakat
- 3) Pusat kesehatan masyarakat
- 4) Pejabat desa
- 5) Pemimpin masyarakat
- 6) Pemimpin agama

3. Tahapan Desa Siaga

Agar sebuah desa menjadi Desa Siaga, desa tersebut harus memiliki forum desa/lembaga masyarakat yang aktif dan fasilitas/akses layanan kesehatan dasar. Dalam perkembangannya, Desa Siaga akan dikembangkan dengan membaginya menjadi empat tahap (Rozifa et al., 2023):

- a. Tahap Pengembangan
- b. Tahap Pertumbuhan
- c. Tahap Pengembangan
- d. Tahap Lengkap

4. Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu)

Posyandu adalah forum komunikasi untuk transfer teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk keluarga berencana, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dengan dukungan dari petugas kesehatan dan keluarga berencana, serta pelatihan teknis. Posyandu memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

5. Polindes

Polindes adalah bentuk UKBM (Usaha Kesehatan Masyarakat) yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah, sebagai pelengkap pengembangan masyarakat desa, untuk menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak serta layanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.

6. Keluarga Berencana/KIA

Keluarga Berencana/KIA adalah kelompok studi kesehatan ibu dan anak yang anggotanya meliputi ibu hamil dan ibu menyusui.

7. Dasa Wisma

Dasa Wisma adalah kelompok ibu-ibu dari 10 rumah tetangga. Kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Kegiatan meliputi pertemuan sosial (arisan), membangun jamban dan sumur, mengembangkan dana kesehatan (PMT, pengobatan medis ringan, dan membangun fasilitas pembuangan sampah dan limbah). Dasa Wisma, atau kelompok "per-sepuluh", adalah platform pelatihan untuk partisipasi masyarakat dalam kesehatan melalui swadaya di tingkat keluarga. Salah satu anggota keluarga dalam kelompok "per-sepuluh" dipilih untuk menjadi ketua kelompok atau penghubung/mentor. Bidan desa ditunjuk sebagai pengawas, bertugas melakukan perawatan rutin dan menerima rujukan untuk masalah kesehatan (Suci Anggraeni et al., 2026).

8. Donor Darah Keliling

Donor darah keliling adalah salah satu strategi yang diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Pengembangan Kesehatan Ibu. Melalui program pemberdayaan perempuan, keluarga, dan masyarakat, mereka berupaya mempercepat penurunan angka kematian ibu.

9. Ambulans Desa

Ambulans desa merupakan bentuk kerja sama dan kepedulian timbal balik antar warga desa, dalam sistem rujukan dari desa ke unit rujukan kesehatan. Ambulans desa adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut warga yang membutuhkan bantuan dan perawatan ke fasilitas kesehatan.

H. Society 5.0

Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang memanfaatkan teknologi canggih untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini berasal dari Jepang dan merupakan kelanjutan dari Masyarakat 4.0 (Munthe et al., 2025).

1. Karakteristik *Society* 5.0:

Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Era 5.0 menekankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, keadilan sosial, dan kesejahteraan.

2. Mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari

Mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari berarti menggunakan teknologi untuk mendukung berbagai aktivitas. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan efisiensi.

3. Penekanan pada konsep "kota pintar"

Konsep "kota pintar" menekankan manajemen kota berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

Konsep "kota pintar" menekankan:

- a. Pemanfaatan sumber daya yang efisien
- b. Peningkatan konektivitas
- c. Peningkatan kualitas layanan publik
- d. Peningkatan efektivitas interaksi dengan warga
- e. Peningkatan pariwisata
- f. Peningkatan pengembangan potensi ekonomi lokal
- g. Beberapa indikator "kota pintar" adalah:

Konektivitas, yaitu akses luas ke jaringan internet berkecepatan tinggi, Keberlanjutan, yaitu implementasi kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan, dan Tata kelola cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokratis

4. Memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *big data*

5. Model Pelayanan Kebidanan Komunitas Berbasis Teknologi & Lokal (*Society* 5.0)

Tele-Midwifery dan Monitoring Berbasis Digital: Penggunaan aplikasi pemantauan ibu hamil dan balita untuk deteksi dini komplikasi secara real-time (data 2026 mencatat integrasi sistem informasi antara bidan di desa dengan fasilitas kesehatan rujukan).

Continuity of Care (CoC) Digital: Bidan memberikan asuhan berkesinambungan (dari hamil hingga nifas) yang didukung oleh rekam medis elektronik terintegrasi. Hal ini terbukti menurunkan AKI/AKB.

Aplikasi "Bidan Desa Smart": Aplikasi berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk membantu kader dan bidan desa dalam memantau gizi, imunisasi, dan tanda bahaya, yang kemudian datanya dikirim ke pusat data Puskesmas.

1. Model Intervensi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat & Kearifan Lokal

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi (Sistem Rujukan Terpadu): Mengubah peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra bidan dalam memotivasi ibu hamil untuk ANC (*Antenatal Care*) dan bersalin di fasilitas kesehatan, serta mempromosikan perawatan nifas berbasis budaya (Shikuku et al., 2020b).

"Ambulans Desa" dan Dana Sosial Desa: Mengaktifkan kembali tabungan ibu bersalin (Tabulin) dan donor darah berjalan untuk mengatasi masalah 3-Terlambat (Terlambat mengenali bahaya, mencapai fasilitas, mendapat pelayanan).

Kelas Ibu Hamil/Balita Tradisional-Modern: Edukasi kelompok dengan menggunakan media digital, namun tetap mengintegrasikan nilai-nilai adat yang positif (misal: pemberian makanan pendamping ASI dengan bahan lokal/kearifan lokal).

2. Implementasi Khusus di Era *Society* 5.0

Deteksi Dini dengan *Artificial Intelligence* (AI): Menggunakan algoritma cerdas pada aplikasi kesehatan untuk memprediksi risiko preeklamsia atau gizi buruk pada balita berdasarkan data yang dimasukkan bidan di lapangan.

Pusat Data Kesehatan Desa Digital: Kumpulan data kesehatan berbasis digital di tingkat RT/RW yang dikelola kader (data stunting, bumil risti) yang terhubung ke Puskesmas, mempermudah intervensi cepat (Puriastuti et al., 2025).

I. Penutup

Model intervensi kebidanan komunitas berbasis lokal yang komprehensif, terintegrasi, dan responsif terhadap konteks sosial budaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Keberhasilan model-model ini sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara bidan, masyarakat, dan keluarga, serta kemampuan bidan untuk beradaptasi dengan budaya lokal.

Model intervensi kebidanan komunitas berbasis lokal sangat efektif dan relevan dalam menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. Keberhasilan intervensi ini bergantung pada Partisipasi Aktif (Sinergi antara bidan desa, kader, keluarga, dan tokoh masyarakat), Integrasi Budaya (menghormati tradisi lokal yang positif sambil mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan praktik berisiko), dan aksesibilitas seperti penyediaan layanan proaktif (pendampingan dan kunjungan rumah) untuk mengatasi hambatan geografis dan sosial-ekonomi.

Referensi

- Adnani, Q. E. S., Maulina, R., Ramadhan, K., Argaheni, N. B., Kennedy, H. P., & Telfer, M. (2025). Trends and determinants of antenatal, intranatal, and postnatal care utilization among Indonesian women (2012–2017): Associated factors in midwifery service utilization between midwives and other health professionals. *BMC Nursing*, 24(1), 912. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03527-6>
- Awaliyah, H. F., & Yuriah, S. (2024). Family empowerment in support of pregnancy examination: Scoping review. *International Journal of Health Sciences*, 8(S1), 1543–1555. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v8nS1.15319>
- Duhita, F., Irianti, B., Halida, E. M., Hartiningtyaswati, S., Yulianti, N., Prabandari, F., Anggraini, Y., & Yulita, N. (2023). Survei Kebutuhan Asuhan Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(3), e1064. <https://doi.org/10.36990/hijp.v15i3.1064>
- Maisaroh, S., & Sartika, R. (2025). *EFFECTIVENESS OF A COMMUNITY-BASED MATERNITY CARE MODEL: AN ANALYSIS OF THE COMMUNITY-BASED MIDWIFERY LITERATURE*. 1(1). <https://jurnal.unsaka.ac.id/index.php/mahi/article/view/159>
- Munthe, N. B. G., Machmud, R., Semiarty, R., Serudji, J., Bachtiar, A., Yani, F. F., & Symond, D. (2025). Effectiveness of a Community-Based Intervention Model in Increasing Neonatal Visit Coverage. *Journal of Neonatal Surgery*, 14(7). <https://doi.org/10.63682/jns.v14i7S.2389>
- Muthoharoh, B. L., Yuriah, S., Gustiani, R., Agustina, Y. R., Indrawati, I., & Mufdlilah, M. (2022). Efficacy of early initiation of breastfeeding (EIB) for preventing hypothermia in newborns. *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery*, 5(2), 82–95. <https://doi.org/10.31101/jhtam.2211>
- Puriastuti, E. A., Nilakesuma, N. F., Yuriah, S., Eliwarti, N., & Batubara, D. S. T. (2025). *KEHAMILAN SEHAT DENGAN PENDEKATAN BERBASIS BUKTI: SOLUSI UNTUK TANTANGAN KEBIDANAN*.
- Rozifa, A. W., Mardliyana, N. E., & Puspita, I. M. (2023). Description of the implementation of complementary therapy in midwifery services in Surabaya, Indonesia. *Majalah Obstetri & Ginekologi*, 31(2), 75–79. <https://doi.org/10.20473/mog.V31I22023.75-79>
- Shikuku, D. N., Tanui, G., Wabomba, M., Wanjala, D., Friday, J., Peru, T., Atamba, E., & Sisimwo, K. (2020a). *Community midwifery model's effect on availability, utilization and outcomes of maternal and newborn health services in hard-to-reach communities of Busia Kenya: A Quasi-experimental study*. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27919/v1>

- Shikuku, D. N., Tanui, G., Wabomba, M., Wanjala, D., Friday, J., Peru, T., Atamba, E., & Sisimwo, K. (2020b). The effect of the community midwifery model on maternal and newborn health service utilization and outcomes in Busia County of Kenya: A quasi-experimental study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 708. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03405-w>
- Simatupang, M. Y., Gultom, S., & Rahman, A. (2026). Midwife competency training management model based on Participatory Innovative Collaborative (PILAR) for stunting prevention in West Nias Regency. *Journal of Education and Health Promotion*, 15(1). https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_702_25
- Suci Anggraeni, Nur Yeni Hidajaturrokhmah, Yenny Puspitasari, Lingga Kusuma Wardani, & Reni Nurhidayah. (2026). Integrated Community-Based Maternal Health Promotion to Improve Knowledge of Pregnancy, Breastfeeding, and Mental Health. *Journal of Community Engagement in Health*, 9(1), 155–163. <https://doi.org/10.30994/jceh.v9i1.808>
- Wahyuni, I. (2025). *POLICY ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF AYAH SIAGA CLASSES IN INDONESIA: SCOOPING REVIEW*. 3(1).
- Yudhia Fratidhina, Nina Herlina, Hamidahs, & Sri Mulyati. (2021). The Development of a Community-Based Model as an Assisting Approach in the Prevention of Pregnancy and Labor Complications in Pandeglang Regency, Banten, Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(4), 2904–2912. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i4.17141>
- Yuriah, S., Juniarti, S., & Sepriani, P. (2023). Midwifery care for Mrs “Y” at BPM Soraya Palembang. *International Journal of Health Sciences*, 7(S1), 2966–2984. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v7nS1.14631>
- Yuriah, S., & Zahra, T. (2024). *ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS PADA NY. E G4P3A0 USIA KEHAMILAN 37 MINGGU 3 HARI DENGAN ANEMIA RINGAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEKAR JAYA*. 2(4). <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644>
- Zakar, R., Tekian, A., Zakar, N. M., & Fischer, F. (2025). Community-based health education: A pilot module on maternal and child health for public health students in Pakistan. *BMC Medical Education*, 25(1), 1673. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08245-w>

Glosarium

A

AKI: adalah jumlah kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (nifas), yang disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, bukan karena kecelakaan.

AKB: adalah jumlah kematian bayi di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup, yang menjadi indikator penting pembangunan kesehatan dan kualitas hidup.

ANC : adalah serangkaian perawatan medis rutin oleh tenaga kesehatan (bidan/dokter) untuk memantau kesehatan fisik dan mental ibu serta tumbuh kembang janin.

Artificial Intelligence : adalah teknologi simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan pada mesin atau sistem komputer.

C

Continuity of Care (CoC): adalah pelayanan kesehatan komprehensif dan berkesinambungan yang diberikan bidan kepada perempuan. Pelayanan ini mencakup masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga keluarga berencana (KB) untuk memantau kesehatan ibu-bayi secara komprehensif, memberikan dukungan emosional, dan mendeteksi dini komplikasi.

I

INC : adalah *Intranatal Care* pelayanan kesehatan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan kompeten, dimulai sejak kontraksi uterus (inpartu) hingga 6 jam setelah melahirkan.

Internet of Things (IoT) : adalah konsep jaringan perangkat fisik (seperti sensor, mesin, atau peralatan rumah tangga) yang tertanam teknologi, sensor, dan perangkat lunak untuk saling bertukar data dan terhubung ke internet.

P

PNC : adalah *Post Natal Care* pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir selama masa nifas, umumnya hingga 6 minggu atau 42 hari setelah persalinan, untuk memastikan pemulihan fisik, mencegah komplikasi, dan memantau kesehatan bayi.

R

RPJMN: adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Indonesia untuk periode 5 tahun.

S

SDGs : adalah agenda internasional 2015-2030 yang disepakati 193 negara anggota PBB (termasuk Indonesia) untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi. Ini mencakup 17 Tujuan dan 169 target untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim dengan prinsip *No One Left Behind*

Society5.0 : adalah konsep masyarakat "super pintar" berpusat pada manusia (human-centered) yang mengintegrasikan ruang maya dan fisik menggunakan AI, IoT, dan Big Data untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup.

T

Tabulin : adalah (Tabungan Ibu Bersalin) program tabungan khusus yang dirancang untuk membantu ibu hamil dan keluarganya mempersiapkan biaya persalinan secara bertahap, aman, dan fleksibel.

U

UNFPA : adalah (Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa) badan PBB yang fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi, mulai beroperasi pada 1969. Mandat utamanya adalah menciptakan dunia dengan kehamilan yang diinginkan, persalinan aman, dan potensi pemuda terpenuhi melalui kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan.

PROFIL PENULIS



Dr. Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes., Lahir di Situbondo, 22 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2014 di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan S3 tahun 2020 pada prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia dan lulus tahun 2024. Seluruh proses Pendidikan ditempuh dengan jalur beasiswa baik pada S1 (PBSB Kemenag RI), S2 (Yayasan P2S3) dan S3 (LPDP Kemenkeu RI). Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi staff pengajar di Akademi Kebidanan Ibrahimy, dan kemudian menjadi dosen tetap Yayasan pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ibrahimy yang merupakan merger dari PT sebelumnya, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, Asuhan Kebidanan Pra Nikah dan Pra Konsepsi, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Penelitian dalam Kebidanan, Kebijakan dalam Kebidanan, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional dan internasional, melakukan oral presentasi hasil penelitian dan atau PkM pada seminar nasional dan internasional serta menjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan ilmiah. Penulis juga merupakan penerima hibah penelitian dan PkM yang diselenggarakan oleh DRPM Kemenristekdikti RI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: azizatulhamidiyah@gmail.com
Motto: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain"



Dewi Junita Lamtumiari, SKM., S.Keb., M.Kes., Lahir di Jambi, 22 Juni 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan tahun 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Kader Bangsa Palembang dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 penulis bekerja di Stikes Prima Jambi sampai Agustus 2014. Kemudian september 2014 sampai dengan Agustus 2016 penulis bekerja di Akademi Kebidanan Cipto Medan. Saat ini penulis bekerja di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi mengampu mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Saya dapat dihubungi melalui e-mail: dewijunita86@gmail.com. Motto: "Semakin Tinggi Ilmuku Maka Semakin Cepat Aku Mengukur Kebodohanku."

PROFIL PENULIS



Ana Mufidaturrosida, S. ST., MPH., Lahir di Karanganyar, 19 Juli 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret lulus pada tahun 2015. Penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum dari tahun 2015 – sekarang, sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan. Penulis mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan editor jurnal nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mufidaana@gmail.com.



Putu Lusita Nati Indriani, SST., M.Kes., merupakan dosen tetap di Universitas Kader Bangsa Palembang dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Beliau adalah seorang bidan profesional dengan kompetensi dan pengalaman akademik di bidang kesehatan reproduksi, khususnya pada kelompok remaja. Lahir di Kalianda pada tanggal 9 April 1991, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan (M.Kes.) pada tahun 2016 dan menuntaskan Program Profesi Bidan pada tahun 2024. Latar belakang pendidikan tersebut memperkuat kapasitas akademik dan praktik profesionalnya dalam pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi yang berbasis promotif dan preventif. Fokus kegiatan tridarma perguruan tinggi yang ditekuni meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan konsentrasi utama pada kesehatan reproduksi remaja, terutama strategi pencegahan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesiapan kesehatan generasi muda. Berbagai kajian dan kegiatan pengabdian yang dilakukan diarahkan pada penguatan literasi kesehatan reproduksi serta pencegahan perilaku berisiko pada remaja. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik pada alamat putu.indriani91@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Nurrahma Layuk, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Luwuk, 02 Juni 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen Jurusan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Ternate. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan aktif sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nrrlayuk@gmail.com

Motto: "The key of success is to focus our conscious mind on the things we want, not the things we fear"



Imroatus Sholihah, S.Keb., bd., M.Keb., Lahir di Sampang, 27 April 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2012 - 2016. Kemudian melanjutkan program pendidikan Profesi Bidan di fakultas kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2017 – 2018, serta melanjutkan kembali program Magister Kebidanan di fakultas kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2019 - 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 sebagai Dosen Tetap di AKBID Graha Husada Sampang yang saat ini telah beralih bentuk menjadi STIKES Sukma Wijaya Sampang. Saat ini penulis telah mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, serta Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Pada institusi yang sama, Penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprod) DIII Kebidanan sejak 2022 hingga sekarang. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iim27midwife@gmail.com

Motto: "Satu-satunya yang tidak akan pernah berhenti berubah yaitu Perubahan itu sendiri"

PROFIL PENULIS



Bd. Siti Yuriah, S.Tr.Keb., M.Keb lahir di Harjowinangun, 16 Juni 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma Tiga pada Program Studi DIII Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan Diploma Empat Kebidanan pada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2022. Tahun 2024 penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai Tenaga Kesehatan di Klinik Pondok Pesantren Modern Nurussalam Sidogede. Pada bulan November 2020, penulis bergabung bersama TIM bimbingan belajar Avicenna Research Consulting sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Baturaja mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi, dan Balita, serta mata kuliah Pemberdayaan Perempuan dalam Aspek Pelayanan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan bimbingan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitiyuriah@stikesalmaarif.ac.id

Motto: "Be yourself"

Sinopsis

Buku referensi “Kebidanan Komunitas dalam Penurunan AKI dan AKB di Indonesia” karya Imroatus Sholihah membahas peran strategis kebidanan komunitas dalam mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai determinan sosial kesehatan ibu dan bayi, yang meliputi faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, akses pelayanan kesehatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam memahami penyebab masih tingginya risiko kematian ibu dan bayi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber daya dan akses pelayanan.

Selanjutnya, buku ini mengkaji asuhan kebidanan berbasis komunitas sebagai pendekatan pelayanan yang menekankan upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta pendampingan berkelanjutan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan keluarga. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat.

Buku ini juga membahas pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi, termasuk pentingnya identifikasi faktor risiko, pemantauan kondisi ibu dan janin, edukasi kesehatan, serta rujukan yang tepat waktu. Peran bidan dalam sistem rujukan maternal neonatal menjadi bagian penting dalam buku ini, terutama dalam memastikan ibu dan bayi memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, buku ini menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan sebagai mitra bidan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap masalah kesehatan ibu dan bayi. Pemberdayaan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kebidanan komunitas dalam menurunkan AKI dan AKB secara berkelanjutan.

Pada bagian akhir, buku ini menyajikan pembahasan mengenai model intervensi kebidanan komunitas berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kebidanan diharapkan menjadi lebih efektif, kontekstual, dan mudah diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, buku ini sangat relevan digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang terlibat dalam program kesehatan ibu dan anak. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kontribusi kebidanan komunitas dalam mewujudkan kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik di Indonesia.

Buku referensi “Kebidanan Komunitas dalam Penurunan AKI dan AKB di Indonesia” karya Imroatus Sholihah membahas peran strategis kebidanan komunitas dalam mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai determinan sosial kesehatan ibu dan bayi, yang meliputi faktor pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, akses pelayanan kesehatan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam memahami penyebab masih tingginya risiko kematian ibu dan bayi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber daya dan akses pelayanan.

Selanjutnya, buku ini mengkaji asuhan kebidanan berbasis komunitas sebagai pendekatan pelayanan yang menekankan upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta pendampingan berkelanjutan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan keluarga. Melalui pendekatan ini, bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat.

Buku ini juga membahas pencegahan komplikasi kehamilan risiko tinggi, termasuk pentingnya identifikasi faktor risiko, pemantauan kondisi ibu dan janin, edukasi kesehatan, serta rujukan yang tepat waktu. Peran bidan dalam sistem rujukan maternal neonatal menjadi bagian penting dalam buku ini, terutama dalam memastikan ibu dan bayi memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, buku ini menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan sebagai mitra bidan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap masalah kesehatan ibu dan bayi. Pemberdayaan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kebidanan komunitas dalam menurunkan AKI dan AKB secara berkelanjutan.

Pada bagian akhir, buku ini menyajikan pembahasan mengenai model intervensi kebidanan komunitas berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kebidanan diharapkan menjadi lebih efektif, kontekstual, dan mudah diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, buku ini sangat relevan digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, peneliti, serta pihak-pihak yang terlibat dalam program kesehatan ibu dan anak. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kontribusi kebidanan komunitas dalam mewujudkan kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-18-3 (PDF)



9

786347

756183